

발 간 등 록 번 호
11-1352000-001556-14



재난응급의료 비상대응매뉴얼

2023. 11.



보건복지부
Ministry of Health and Welfare

「재난응급의료 비상대응매뉴얼」 신구조문대비표 및 수정사유

구분	현 행	개 정 안	수정사유
p.3 3. 근거법률 및 관계 법령	③ 근거법률 및 관계법령 ○ 근거법률 - 「응급의료에 관한 법률(이하 “응급의료법”이라 함) 제15조의 2와 동법 시행령 제8조의2	③ 근거법률 및 관계법령 ○ 근거법률 - 「응급의료에 관한 법률」(이하 “응급의료법”이라 함) 제15조의 2(비상대응매뉴얼), 같은 법 시행령 제8조의2(비상대응 매뉴얼의 내용)	▶ 문구 정비
p.4 4. 용어 정의	〈신 설〉	재난의 정의 (재난안전법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조) 〈본문 참조〉	▶ 재난의 정의 신설
p.4 4. 용어 정의	- “다수사상자사고(Mass Casualty Incident, MCI)”란 동시에 다수의 사상자가 발생하였거나, 발생할 우려가 있어 응급의료의 제공을 위해 별도의 의료자원 동원 등의 조치가 필요한 사건·사고를 말함	- “다수사상자사고(Mass Casualty Incident, MCI)”란 동시에 다수의 사상자가 발생하였거나, <u>추가로 사상자가 발생할 우려가</u> 있어 응급의료의 제공을 위해 별도의 의료자원 동원 등의 조치가 필요한 사건·사고를 말함	▶ 문구 정비
p.4 4. 용어 정의	○ “재난관리책임기관”이란 재난관리업무를 하는 다음 기관을 말함 - 중앙행정기관 및 지방자치단체 - 지방행정기관·공공기관·공공단체 및 재난관리의 대상이 되는 중요시설의 관리기관 등(재난안전법 시행령 별표1의 2)	○ “재난관리책임기관”이란 재난관리업무를 하는 다음 기관을 말함 - 중앙행정기관 및 지방자치단체 - 지방행정기관·공공기관·공공단체 및 재난관리의 대상이 되는 중요시설의 관리기관 등으로서 대통령령으로 정하는 기관(재난안전법 시행령 [별표 1의2])	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.4 4. 용어 정의	○ “재난관리주관기관”과 이란 재난이나 그 밖의 각종 사고에 대하여 그 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하는 관계 중앙행정기관(재난안전법 시행령 별표1의3)	○ “재난관리주관기관”이란 재난이나 그 밖의 각종 사고에 대하여 그 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하도록 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관을 말함(재난안전법 시행령 [별표 1의3])	▶ 문구 정비
p.5 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “긴급구조”란 재난이 발생할 우려가 현저하거나 재난이 발생하였을 때에 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 긴급구조기관과 긴급구조지원기관이 하는 인명구조, 응급처치, 그 밖에 필요한 모든 긴급한 조치를 말함	▶ 긴급구조 기관 관련 정의 신설
p.5 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “긴급구조기관”이란 소방청·소방본부 및 소방서를 말하며, 해양에서 발생한 재난의 경우에는 해양경찰청·지방해양경찰청 및 해양경찰서를 말함	
p.5 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “긴급구조지원기관”이란 긴급구조에 필요한 인력·시설 및 장비, 운영체계 등 긴급구조능력을 보유한 기관이나 단체로서 대통령령으로 정하는 기관과 단체를 말함(재난안전법 시행령 제4조, 재난안전법 시행규칙 [별표1])	
p.5 4. 용어 정의	○ “임시의료소”란 의료소장(또는 신속대응반, DMAT)이 재난 현장에 도착하여 현장응급의료를 운영하기 전까지 소방공무원이 운영하는 의료소를 말함(긴급구조현장지휘규칙 제20조제5항)	○ “임시의료소”란 의료소장(또는 신속대응반, DMAT)이 재난현장에 도착하여 현장응급의료를 운영하기 전까지 소방공무원이 운영하는 의료소를 말함(긴급구조현장지휘규칙 제20조제10항)	▶ 인용 조문 수정
p.5 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “구급지휘팀”이란 다수사상자 발생 재난 응급의료 현장을 지휘·조정·통제하고, 구급활동 등을 지원하기 위한 팀을 말함	▶ 구급지휘팀 정의 신설

구분	현행	개정안	수정사유
p.5 4. 용어 정의	〈신설〉	- “재난의료관리자”란 응급의료지원센터 직원으로 권역 내 재난의료 업무를 조정·관리하는 재난의료전담인력을 말함	▶ 재난의료관리자 정의 신설
p.6 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “재난안전통신망”(Public Safety – Long Term Evolution: 이하 ‘PS-LTE’)이란 재난관리책임기관·긴급구조기관 및 긴급구조지원기관이 재난 및 안전관리업무에 이용하거나 재난현장에서의 통합지휘에 활용하기 위하여 구축·운영하는 통신망을 말함	▶ 재난안전통신망 정의 신설
p.6 4. 용어 정의	〈신설〉	○ “모바일상황실”이란 재난 등의 발생시 사고정보와 사상자 발생 현황 등 관련 정보를 관계기관(보건복지부, 지자체, 보건소, 응급의료기관, 중앙응급의료센터, 응급의료지원센터 등)과 공유하기 위하여 만들어진 단체 대화방을 말함	▶ 모바일상황실 정의 신설
p.6 5. 의료지원이 필요한 재난 등	재난의 정의 (재난안전법 및 같은 법 시행령)	(재난의 정의 삭제)	▶ 재난의 정의 내용 이동
p.6 5. 의료지원이 필요한 재난 등	〈신설〉	○ 보건복지부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장은 재난 등의 발생 시 응급의료종사자에게 응급의료 업무에 종사할 것을 명하거나, 의료기관의 장 또는 구급차등을 운영하는 자에게 의료시설을 제공하거나 응급환자 이송 등의 업무에 종사할 것을 명할 수 있음 - 응급의료종사자, 의료기관의 장 및 구급차등을 운영하는 자는 정당한 사유가 없으면 이를 거부할 수 없음	▶ 응급의료법 제18조 관련 문구 신설

구분	현행	개정안	수정사유																
p.7 5. 의료지원이 필요한 재난 등	〈신설〉	환자가 여러 명 발생한 경우의 조치 (응급의료법 및 같은 법 시행령)	▶ 위치 이동																
p.7 6. 국가행사 등 대규모 행사의 응급의료지원	○ 대규모 인명피해 발생가능성이 있는 국가행사 등 대규모 행사 시에는 <u>보건복지부가</u> 해당 지자체 및 <u>권역응급의료센터에 응급의료지원을 응급의료법 제18조에 따라 요청할 수 있으며</u> , 지원 규모 및 형태는 행사규모에 따라 <u>보건복지부가 결정함</u>	○ 대규모 인명피해 발생 가능성이 있는 국가행사 등 대규모 행사 시에는 <u>보건복지부 또는 시·도지사가</u> 해당 지자체 및 <u>응급의료기관에 응급의료지원을 요청할 수 있으며</u> , 지원 규모 및 형태는 행사규모에 따라 <u>보건복지부 및 시·도지사가 결정함</u>	▶ 내용 명확화																
p.8 7. 재난 등에서의 의료대응 단계	<table><tr><th>구분</th><th>판단 기준</th></tr><tr><td>관심 (Blue)</td><td>1. 다수사상자 발생 위험이 큰 사건 또는 행사/현상 • 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해의 진행 • 군중 운집(mass gathering) 행사 등의 개최</td></tr><tr><td>주의 (Yellow)</td><td>1. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상 • 해당 시간의 예측 수용인구수가 20명 이상인 다중이용시설의 화재, 붕괴, 침수 등 • 다중교통사고, 군중운집행사에서 사상자 발생 • 태풍, 홍수, 해일, 지진 등 자연재해에서 사상자 발생 • 화학물질의 누출, 방사선 시설에서의 사고 2. 국지전/테러 발생의 위험</td></tr><tr><td>경계 (Orange)</td><td>1. 다수사상자가 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 상황 • 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생이 현저히 의심되는 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 • 운항/운행 중인 여객선박, 여객항공기, 여객열차 및 대형승합차의 추락, 침몰, 탈선 및 전복 등의 확인 • 10대 이상 차량의 다중 교통사고 확인 • 화학, 방사선 물질에 의한 인구집단의 노출 확인</td></tr></table>	구분	판단 기준	관심 (Blue)	1. 다수사상자 발생 위험이 큰 사건 또는 행사/현상 • 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해의 진행 • 군중 운집(mass gathering) 행사 등의 개최	주의 (Yellow)	1. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상 • 해당 시간의 예측 수용인구수가 20명 이상인 다중이용시설의 화재, 붕괴, 침수 등 • 다중교통사고, 군중운집행사에서 사상자 발생 • 태풍, 홍수, 해일, 지진 등 자연재해에서 사상자 발생 • 화학물질의 누출, 방사선 시설에서의 사고 2. 국지전/테러 발생의 위험	경계 (Orange)	1. 다수사상자가 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 상황 • 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생이 현저히 의심되는 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 • 운항/운행 중인 여객선박, 여객항공기, 여객열차 및 대형승합차의 추락, 침몰, 탈선 및 전복 등의 확인 • 10대 이상 차량의 다중 교통사고 확인 • 화학, 방사선 물질에 의한 인구집단의 노출 확인	<table><tr><th>구분</th><th>판단 기준</th></tr><tr><td>관심 (Blue)</td><td>1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수사상자 발생 가능성이 있는 경우 2. 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상</td></tr><tr><td>주의 (Yellow)</td><td>1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수의 사상자가 이미 발생한 경우 2. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상</td></tr><tr><td>경계 (Orange)</td><td>1. 소방 대응 1단계 이상으로 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 2. 다수의 중증환자가 이미 발생하였거나 5명 이상의 중증환자 발생 가능성이 현저히 높으며 상황이 장기화 될 우려가 있어 현장에서 초기 의료대응이 중점적으로 필요한 경우</td></tr></table>	구분	판단 기준	관심 (Blue)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수사상자 발생 가능성이 있는 경우 2. 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상	주의 (Yellow)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수의 사상자가 이미 발생한 경우 2. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상	경계 (Orange)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 2. 다수의 중증환자가 이미 발생하였거나 5명 이상의 중증환자 발생 가능성이 현저히 높으며 상황이 장기화 될 우려가 있어 현장에서 초기 의료대응이 중점적으로 필요한 경우	▶ 출동기준 보완
구분	판단 기준																		
관심 (Blue)	1. 다수사상자 발생 위험이 큰 사건 또는 행사/현상 • 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해의 진행 • 군중 운집(mass gathering) 행사 등의 개최																		
주의 (Yellow)	1. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상 • 해당 시간의 예측 수용인구수가 20명 이상인 다중이용시설의 화재, 붕괴, 침수 등 • 다중교통사고, 군중운집행사에서 사상자 발생 • 태풍, 홍수, 해일, 지진 등 자연재해에서 사상자 발생 • 화학물질의 누출, 방사선 시설에서의 사고 2. 국지전/테러 발생의 위험																		
경계 (Orange)	1. 다수사상자가 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 상황 • 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생이 현저히 의심되는 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 • 운항/운행 중인 여객선박, 여객항공기, 여객열차 및 대형승합차의 추락, 침몰, 탈선 및 전복 등의 확인 • 10대 이상 차량의 다중 교통사고 확인 • 화학, 방사선 물질에 의한 인구집단의 노출 확인																		
구분	판단 기준																		
관심 (Blue)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수사상자 발생 가능성이 있는 경우 2. 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상																		
주의 (Yellow)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수의 사상자가 이미 발생한 경우 2. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상																		
경계 (Orange)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 주의(Yellow) 단계 해당 상황/사건 2. 다수의 중증환자가 이미 발생하였거나 5명 이상의 중증환자 발생 가능성이 현저히 높으며 상황이 장기화 될 우려가 있어 현장에서 초기 의료대응이 중점적으로 필요한 경우																		

구분	현행		개정안		수정사유
	구분	판단 기준	구분	판단 기준	
		2. 다수사상자사고에서, 재난관리주관기관 및 재난관리책임기관의 의료대응 요청		3. 다수사상자사고에서 재난관리주관기관 및 재난관리책임기관의 의료대응 요청	
	심각 (Red)	1. 일상적인 응급의료서비스로는 대응할 수 없는 명백한 재난 등	심각 (Red)	1. 일상적인 응급의료서비스로는 대응할 수 없는 명백한 재난 등	
			(관심 2.) 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상의 예시는 다음과 같다 - 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해의 진행 - 군중 운집(mass gathering) 행사 등의 개최 (주의 2.) 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상의 예시는 다음과 같다 - 해당 시간의 예측 수용인구수가 20명 이상인 다중이용시설의 화재, 붕괴, 침수 등 - 다중교통사고, 군중 운집 행사에서의 사상자 발생 - 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해에서 사상자 발생 - 화학물질의 누출, 방사선 시설에서의 사고 등으로 인구집단의 노출 확인 - 국지전/테러 발생으로 사상자 발생 - 운항/운행 중인 여객선박, 여객항공기, 여객열차 및 대형승합차의 추락, 침몰, 탈선 및 전복 등의 확인		
p.11~12 1. 기관별 역할 가. 대비 (평상시 역할)	구분	대비활동	구분	대비활동	▶ 문구 정비
	보건 복지부	• 유관부처 간 협력체계 유지	보건 복지부	• <u>재난의료자원의 조정 및 배치</u> • <u>유관기관 협력체계 유지 및 조율</u>	
	중앙응급의료센터 (국립중앙의료원)	• 시도별 재난의료관리업무의 지원 (응급의료지원센터) - 재난거점병원의 재난교육, 훈련, 정보관리 업무 지원(응급의료지원센터)	중앙응급의료센터 (국립중앙 의료원)	• 시도별 재난의료관리업무의 지원 (응급의료지원센터) - 재난거점병원의 재난교육, 훈련, 정보관리 업무 지원	
	시·도	〈신 설〉	시·도	• <u>지역 내 재난의료 자원의 조정 및 배치</u> • <u>다수환자 발생 대비 조치계획 수립·운영</u>	

구분	현행		개정안		수정사유
	구분	대비활동	구분	대비활동	
	시·군·구 (보건소)	- 관계기관(경찰서, 군부대 등)간 협조체계 유지 - 신속대응반 구성·운영(교육, 훈련) 및 출동체계 유지	시·군·구 (보건소)	- 관계기관(경찰서, 소방서, 해양경찰서, 군부대 등)간 협조체계 유지 - 신속대응반 구성 및 출동체계 유지 - 신속대응반 구성원의 교육·훈련 참가	
	소방	119 종합상황실을 통한 통합감시체계 운영 - 재난 핫라인 운영, 상황 전파 (중앙센터종합상황실) - DMAT 요청 체계 유지	소방	119 종합상황실을 통한 통합감시체계 운영 - 재난 핫라인 운영, 상황 전파 (중앙응급의료센터 중앙응급의료상황실) - 신속대응반 및 DMAT 출동 요청 등 중앙응급의료센터와의 협조체계 유지	
	권역응급의료센터 (재난거점병원)	- 재난의료 대응계획의 수립 - 병원 내 재난대응계획 수립, 비상연락망 관리 등	권역응급의료센터 (재난거점병원)	원내 재난의료대응계획 수립 및 비상연락망 관리	
	민간 이송업	재난의료핫라인의 운영 및 관련 정보 제공 (보건소/재난거점병원에 보고)	민간 이송업	재난의료핫라인의 운영 및 관련 정보 제공 (보건소/응급의료지원센터에 보고)	
p.13~14 1. 기관별 역할 나. 대응 (재난 시 역할)	구분	대응활동	구분	대응활동	▶ 문구 정비
	보건 복지부	부처간 협력	보건 복지부	- 부처 및 유관기관 간 협력 - 재난의료자원의 조정 및 배치 (예비병상 가동 포함)	
	중앙응급의료센터 (국립중앙의료원)	- 지역 내 재난응급의료 관련 업무의 조정 및 지원(지역응급의료지원센터) - 현장의료에 관한 신속대응반, DMAT 업무 지원	중앙응급의료센터 (국립중앙의료원)	- 지역 내 재난응급의료 관련 업무의 조정 및 지원(응급의료지원센터) - 재난 등 발생 시 현장 출동 및 현장의료에 관한 신속대응반, DMAT 업무 지원	
	시·군·구 (보건소)	부상자, 사망자 현황 정보 수집 및 관리	시·군·구 (보건소)	사상자 현황 정보 수집 및 관리	
	권역응급의료센터 (재난거점병원)	재난 등의 상황 장기화 대비 계획 (인력, 물품 등)	권역응급의료센터 (재난거점병원)	- 재난 등의 상황 장기화 준비(인력, 물품 등) - 필요 시 원내 재난대책본부 혹은 부서 가동	

구분	현행					개정안					수정사유
	구분		대응활동			구분		대응활동			
	응급의료기관 및 응급실 운영기관		〈신설〉			응급의료기관 및 응급실 운영기관		• 의료기관 자체의 피해(환자안전, 직원안전, 시설 및 설비) 확인 및 이상 시 중앙응급의료상황실로 보고(핫라인) • 필요 시 원내 재난대책본부 혹은 부서 가동			
p.15 1. 기관별 역할 다. 대응단계별 기관별 주요 활동	구분	보건소	DMAT	응급의료 기관	이송업체	구분	보건소	DMAT	응급의료 기관	이송업체	▶ 문구 정비
	관심 (Blue)	핫라인 유지	핫라인 유지	핫라인 유지	핫라인 유지	관심 (Blue)	핫라인·비상 연락망 확인	핫라인·비상 연락망 확인	핫라인·비상 연락망 확인	핫라인·비상 연락망 확인	
	주의 (Yellow)	필요시 출동대기, 비상연락망 확인	필요시 출동대기, 비상연락망 확인	비상연락망 확인	비상연락망 확인	주의 (Yellow)	필요시 출동대기, 비상연락망 가동	필요시 출동대기, 비상연락망 가동	비상연락망 가동	비상연락망 가동	
p.15 1. 기관별 역할 다. 대응단계별 기관별 주요 활동	구분	중앙응급의료센터		응급의료기관		구분	중앙응급의료센터		응급의료기관		▶ 문구 정비
	경계 (Orange)	• 응급자원정보수집/제공		• 수용환자 <u>현황보고</u>		경계 (Orange)	• 실시간 응급자원정보 수집/제공 • 대응 정보 수집 및 공유 • (필요 시) <u>응급의료지원센터</u> <u>현장출동</u>		• 수용환자 <u>보고</u> • <u>피해상황</u> <u>현황보고</u>		
p.15 1. 기관별 역할 다. 대응단계별 기관별 주요 활동	구분	중앙응급의료센터				구분	중앙응급의료센터				▶ 문구 정비
	심각 (Red)	• 응급자원정보수집/제공				심각 (Red)	• 실시간 응급자원정보수집/제공				

구분	현행	개정안	수정사유
p.20 나. 재난 시 현장응급의료 지휘체계(현장 응급의료소)	○ 현장응급의료소에는 소장 1명과 분류반, 응급처치반, 이송반을 두며, 현장응급의료소장은 긴급구조통제단장의 지휘를 받아 의료소의 운영 전반에 관하여 지휘·감독함	○ 현장응급의료소에는 소장 1명과 분류반, 응급처치반, 이송반, <u>운영지원반</u> 을 두며, 현장응급의료소장은 긴급구조통제단장의 지휘를 받아 의료소의 운영 전반에 관하여 지휘·감독함	▶ 운영지원반 신설
p.20 다. 신속대응반/ 재난의료지원팀 (DMAT) 체계	○ 권역 DMAT : 특정 지역 단위에서 조직된 DMAT으로 <u>중앙응급의료상황실에서 출동 요청하며, 지자체, 소방에서도 출동 요청 가능함</u>	○ 권역 DMAT : 특정 지역 단위에서 조직된 DMAT으로 <u>중앙응급의료상황실에서 출동 요청함</u>	▶ 문구 정비
p.20 다. 신속대응반/ 재난의료지원팀 (DMAT) 체계	○ 지역 DMAT : 재난거점병원 외 응급의료기관 등에서 운영하는 DMAT으로 <u>보건복지부 구성 외에도 필요 시 시·도나 의료기관에서 자체로 구성할 수 있음</u>	○ 지역 DMAT : 재난거점병원 외 응급의료기관 등에서 운영하는 DMAT으로 <u>필요 시 시·도나 의료기관에서 자체로 구성할 수 있음</u>	▶ 문구 정비
p.25 1. 재난상황 접수 및 전파	○ 중앙응급의료상황실은 의사와 상황요원이 24시간 교대 근무하며 재난상황을 모니터링하고, 재난 등의 발생 시 상황의 전파, <u>재난의료지원팀 출동요청</u> , 재난대응기관 간 통신, 정보 수집 및 제공, 환자 현황 집계 등의 역할을 수행함	○ 중앙응급의료상황실은 의사와 상황요원이 24시간 교대 근무하며 재난상황을 모니터링하고, 재난 등의 발생 시 상황의 전파, <u>DMAT 출동요청</u> , 재난대응기관 간 통신, 정보 수집 및 제공, 환자 현황 집계 등의 역할을 수행함	▶ 문구 정비
p.25 1. 재난상황 접수 및 전파	○ 수신한 상황은 중앙응급의료상황실에서 운영하는 모바일 상황실(<u>보건복지부 응급의료과, 소방청, 소방본부(상황실 및 구급상황관리센터)</u>), 중앙응급의료센터, 재난의료책임자, <u>지역응급의료지원센터</u>)에 메시지로 전파함.	○ 수신한 상황은 중앙응급의료상황실에서 운영하는 모바일 상황실(<u>보건복지부(재난의료과 및 비상안전기획관), 시·도, 보건소, 중앙응급의료센터, 재난의료책임자, 응급의료지원센터</u>)에 메시지로 전파함.	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.26 1. 재난상황 접수 및 전파	〈그림 7. 재난상황 흐름도〉 〈본문 참조〉	〈그림 7. 재난상황 흐름도〉 〈본문 참조〉	▶ 그림 수정
p.27 가. 출동대기	○ 재난 등 상황 발생 초기이거나, 현장 상황에 대한 정보 수집이 충분하지 않아 신속대응반이나 DMAT 출동 결정을 바로 내릴 수 없는 경우 <u>중앙급의료상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, 재난안전통신망 등)을 통해 상황을 전파하고 출동 대기를 요청할 수 있음</u>	○ 재난 등 상황 발생 초기이거나, 현장 상황에 대한 정보 수집이 충분하지 않아 신속대응반이나 DMAT 출동 결정을 바로 내릴 수 없는 경우 <u>중앙응급의료상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, PS-LTE 등)을 통해 상황을 전파하고 출동 대기를 요청할 수 있음</u>	▶ 문구 정비
p.27 나. 출동기준	○ <u>재난관리주관기관 및 재난관리책임기관의 요청</u> ○ <u>그 밖에 보건소장 및 재난의료책임자의 판단</u>	○ <u>보건소장 및 재난의료책임자의 판단</u> ※ 긴급구조기관의 대응단계 변경 시 신속대응반 및 DMAT의 출동규모도 변경할 수 있음 ※ 방사선 물질 관련 사고에 대해서는 방사선 비상진료체계를 우선 가동하고, 방사선 비상진료체계에 의한 대응 부족 시 출동 요청 ※ 사상자 중 중증환자 다수 발생으로 전문적인 현장의료대응이 요구될 시 DMAT 출동 고려	▶ 문구 정비
p.27 다. 출동 요청	○ 신속대응반 혹은 DMAT의 출동이 결정된 경우 중앙응급의료 상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, <u>재난안전통신망</u> 등)을 통해 신속대응반 또는 DMAT의 출동을 요청하고 보건복지부에 보고할 수 있음	○ 신속대응반 혹은 DMAT의 출동이 결정된 경우 중앙응급의료 상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, <u>PS-LTE</u> 등)을 통해 신속대응반 또는 DMAT의 출동을 요청하고 보건복지부에 보고할 수 있음	▶ 문구 정비
p.27~28 다. 출동 요청	○ <u>현장이 안전하지 않다고 판단되거나 상황에 따라 현장 대응이 아닌 원내 대응이 더 효율적인 경우 출동 기준에 부합하더라도 출동요청 아니하거나 타 병원 출동 요청이 가능함(예. 현장에서</u>	○ <u>현장이 안전하지 않다고 판단되는 경우 출동 기준에 부합하더라도 출동 요청을 하지 않을 수 있음</u> ○ 상황에 따라 현장 대응이 아닌 원내 대응이 더 효율적인	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	<u>재난거점병원까지의 거리가 짧아 현장 출동 보다 원내에서 더 많은 환자를 수용하는 것이 효율적인 경우, 사고 현장과 가까운 응급의료기관에 환자 쏠림으로 인해 의료진이 부족한 경우 등 DMAT이 현장이 아닌 해당 의료기관으로 출동하여 활동)</u>	<u>경우 출동 기준에 부합하더라도 출동 요청을 하지 않거나 타 병원으로 출동 요청이 가능함(예. 현장에서 재난거점병원까지의 거리가 짧아 현장 출동 보다 원내에서 더 많은 환자를 수용하는 것이 효율적인 경우, 사고 현장과 가까운 응급의료기관에 환자 쏠림으로 인해 의료진이 부족한 경우 등에는 DMAT이 현장이 아닌 해당 의료기관으로 출동하여 활동)</u>	
p.28 다. 출동 요청	○ 출동 요청은 관할 지역 신속대응반과 재난거점병원(시도 경계와 무관하게 가장 가까운)에 요청되며, 발생지점이 2개 이상 의료기관과의 거리가 모호한 경우 해당 의료기관 모두 요청할 수 있음	○ 출동 요청은 관할 지역 신속대응반과 재난거점병원(시도경계와 무관하게 가장 가까운)에 요청되며, 발생지점이 2개 이상 재난 거점병원과의 거리가 모호한 경우(예상도착시간 차이가 5분 이내) 관할 지역의 DMAT을 우선으로 요청할 수 있음	▶ 문구 정비
p.28 다. 출동 요청	○ 관할 구역 내 다수 사고 발생 시 추가 출동명령이 필요할 경우 중앙응급의료상황실에서 <u>차순위 근거리 DMAT</u> 출동 요청을 할 수 있음	○ 관할 구역 내 다수 사고 발생 시 추가 출동명령이 필요할 경우 중앙응급의료상황실에서 <u>근거리 순으로 DMAT</u> 출동 요청을 할 수 있음	▶ 문구 정비
p.28 다. 출동 요청	<u>〈신 설〉</u>	○ 다수 권역DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 대응이 예상되는 재난 등의 경우 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 중앙DMAT의 출동을 결정할 수 있음 ○ 응급의료지원센터는 중앙응급의료상황실의 출동지시가 있을 경우 현장으로 출동하며, 중앙응급의료상황실은 신속대응반만 출동한 경우에도 현장 상황에 따라 지역응급의료지원센터의 출동을 요청할 수 있음. 관할 지역의 응급의료지원센터가 부재하거나 야간·공휴일의 경우 다른 지역의 응급의료지원센터 출동을 요청할 수 있음	▶ 중앙 DMAT 및 응급의료 지원센터 출동기준 신설

구분	현행	개정안	수정사유
p.28 다. 출동 요청	○ <u>지역 DMAT이 더 가까운 경우 권역 DMAT 보다 먼저 출동이 요청될 수 있음</u>	〈삭 제〉	▶ 문구 정비
p.28 라. 출동	○ <u>병원에서 근무 중인 인력으로 1차 DMAT을 구성하여 출동 (인력 구성은 IV장 참조), 병원은 이를 위해 직렬당 1명 이상 24시간 출동이 가능하도록 근무를 배치해야 함</u>	○ <u>재난거점병원은 병원에서 근무 중인 인력으로 DMAT 1팀을 구성하여 출동(인력 구성은 IV장 참조)하며, 필요 시 2시간 이내에 2팀이 출동할 수 있도록 권역 DMAT의 인력풀을 유지하도록 함(동시 최대 2개 팀이 출동가능)</u>	▶ 문구 정비
p.29 라. 출동	○ <u>신속한 출동을 위해 긴급자동차(병원 구급차/민간이송업 등) 및 응급의료전용헬기를 이용할 수 있으며, 단, 현장의료 지원의 필요성에 따라 재난의료지원차량은 준비되는 대로 출동</u>	○ <u>신속한 출동을 위해 긴급자동차(병원 구급차/민간이송업 등) 및 응급의료전용헬기 등을 이용할 수 있으며, 단, 현장의료 지원의 필요성에 따라 재난의료지원차량은 준비되는 대로 출동</u>	▶ 문구 정비
p.29 라. 출동	○ <u>출동 시 복장은 미리 구비된 경우 착용하며, 구비되지 않은 경우 보건소에서 비축하고 있다가 현장에서 배포함(부록 1 참고)</u> ○ <u>출동 시 긴급구조통제단장 명의로 재난현장 출입증을 반드시 패용하도록 함(부록 2 참고)</u>	○ <u>출동 시 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하도록 함</u>	▶ 문구 정비
p.29 3. 선착대 (신속대응반, DMAT) 도착	3. <u>선착대</u> (신속대응반, DMAT) 도착	3. <u>선착팀</u> (신속대응반, DMAT) 도착	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.29 3. 선착대 (신속대응반, DMAT) 도착	현장 선착대의 임무 〈본문 참조〉	현장 선착팀의 임무 〈본문 참조〉	▶ 문구 정비
p.29~30 가. 현장 지휘체계의 확인 및 연계 (C, Command & Control)	가. 현장지휘체계의 확인 및 연계 ○ 신속대응반 또는 DMAT 중 가장 먼저 현장에 도착한 선착대는 현장지휘소장(시·군·구 긴급구조통제단장)에게 도착을 보고(구두, 유선 등)해야 하며, 가능하면 <u>구조대장이나 구급담당자</u>에게도 도착을 <u>알린다</u>. 다만, 긴급구조통제단이 가동되기 전이라면 보건소장의 지시에 따름 ○ 소방에서 임시의료소를 운영중이었다면, 보건소장은 임시의료소 운영에 관한 사항(사상자 현황, 임시의료소에서 조치한 분류, 처치, 이송 현황 및 현장 상황 등)이 기록된 구급현장 인계인수서를 받아야 함 ○ 현장응급의료소장은 보건소장>권역응급의료센터장>응급의료지원센터장>지역응급의료센터장이 할 수 있음. 단, 중앙 DMAT이 도착한 경우에는 중앙 DMAT 팀장이 가장 우선권을 <u>가짐</u>	가. 현장지휘체계의 확인 및 연계(C, Command & Control) ○ 신속대응반 또는 DMAT 중 가장 먼저 현장에 도착한 선착팀은 현장지휘소장(시·군·구 긴급구조통제단장)에게 도착을 보고(구두, 무선 등)해야 하며, 가능하면 <u>구급대장이나 구급지휘팀장, 임시의료소장</u>에게도 도착을 <u>알림</u>. 다만, 긴급구조통제단이 가동되기 전이라면 보건소장의 지시에 따름 ○ 소방에서 임시의료소를 운영 중이었다면, 보건소장은 임시의료소 운영에 관한 사항(사상자 현황, 임시의료소에서 조치한 분류, 처치, 이송 현황 및 현장 상황 등)이 기록된 구급현장 인계인수서를 받아야 함. 단, DMAT이 먼저 도착한 경우 DMAT 팀장이 받을 수 있음. 현장응급의료소로 전환 시 <u>현장응급의료소장은 임시의료소장과 논의하여 운영인력의 역할을 재조정해야 함</u> ○ 현장응급의료소장은 보건소장>권역응급의료센터장>응급의료지원센터장>지역응급의료센터장이 할 수 있음. <u>현장응급의료소장은 현장응급의료소의 의료적 기능(중증도분류, 응급 처치 등 환자진료와 관련된 임무의 지휘)을 DMAT 팀장에게 위임 가능함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.30 가. 현장 지휘체계의 확인 및 연계 (C, Command & Control)	재난현장지휘체계 - 재난현장 지휘체계 - 긴급구조기관(소방청, 소방본부 및 소방서, 해양경찰청, 지방해양경찰청, 해양경찰서)이 재난대응의 중심기관이며 긴급구조지원기관(보건복지부, 종합병원, 응급의료기관 등)은 긴급구조기관의 재난대응을 지원하는 역할을 수행	재난현장지휘체계 재난현장지휘체계 긴급구조기관(소방청, 소방본부 및 소방서, 해양경찰청, 지방해양경찰청, 해양경찰서)이 재난대응의 중심기관이며 긴급구조지원기관(보건복지부, 종합병원, 응급의료기관, 보건소 등)은 긴급구조기관의 재난대응을 지원하는 역할을 수행	▶ 문구 정비
p.30 나. 현장 안전 확보 (S, Safety)	나. 현장 안전 확보	나. 현장 안전 확보(S, Safety)	▶ 문구 정비
p.30 다. 통신체계 구성 (C, Communication)	다. 통신체계 구성 ○ <u>선착대는 먼저 재난 현장에서 중앙응급의료상황실, 현장지휘소, 현장응급의료소 내 통신체계를 확립해야 함</u>	다. 통신체계 구성(C, Communication) ○ <u>선착팀은 먼저 재난 현장에서 중앙응급의료상황실, 현장지휘소, 현장응급의료소 내 통신체계를 확립해야 함</u>	▶ 문구 정비
p.30 다. 통신체계 구성 (C, Communication)	- PS-LTE, 휴대전화, 모바일 상황실 사용이 가능하며, 모바일 상황실 운영을 위해서는 <u>적절한 인터넷 환경을 확보하거나 통제단에 요청해야 함</u> <u>파견이 없을 경우 현장지휘소와 현장응급의료소 간 통신을 위해 무선통신수단을 확보해야 하며, 이를 위해 현장지휘소에 무전기(PS-LTE, UHF 등)를 요청해야 함(Ⅵ장 참고)</u> <u>현장응급의료소 내 통신은 PS-LTE 사용을 기본으로 하되, PS-LTE 사용이 어려운 경우 휴대전화, 무전기(워키토키 등) 등을 사용함</u>	- PS-LTE, 휴대전화, 모바일 상황실 사용이 가능하며, 모바일 상황실 운영을 위해서는 <u>적절한 인터넷 환경을 확보하여야 함</u> <u>현장에 출동하거나 출동 중인 신속대응반, DMAT, 응급의료지원센터는 재난안전통신망 표준운영절차에 따라 공통통화 그룹에 합류하여야 함(Ⅵ장 참고)</u> <u>현장응급의료소 내 통신은 PS-LTE 사용을 기본으로 하되, PS-LTE 사용이 어려운 경우 휴대전화, 무전기 등을 사용함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.31 라. 현장 의료수요 파악 (A, Assessment)	라. 현장 의료수요 파악 ○ <u>선착대는</u> 전체 피해자 예상 규모, 환자 중증도, 기이송된 환자 규모 및 향후 예상되는 요구조자, 이송자원 현황 등 현장 상황에 대한 파악을 하여 재난현장의 의료수요를 평가하고, 추가 인력, 장비, 물품이 필요한지에 대해 종합하여 중앙응급의료상황실에 보고 ○ <u>중앙응급의료상황실</u>은 동시에 많은 의료 인력이 필요하거나 <u>현장 지원 활동이 6시간 이상 소요되는 경우 등 필요하다고 판단한 경우에는</u> 다른 재난거점병원의 DMAT이나 재난거점 병원이 아닌 응급의료기관에 대해서도 의료진 출동을 요청할 수 있으며, 다른 재난거점병원의 DMAT이 출동하는 경우에는 관할 시·도 및 보건복지부에 즉시 통보해야 함 ○ <u>후발대는</u> 인력 구성으로 시간이 소요됨에 따라 <u>선착대는 후발대 파견 여부를 신속히 판단하여 중앙응급의료상황실에 요청해야 시간을 단축할 수 있음</u>	라. 현장 의료수요 파악(A, Assessment) ○ <u>선착팀은</u> 전체 피해자 예상 규모, 환자 중증도, 기이송된 환자 규모 및 향후 예상되는 요구조자, 이송자원 현황 등 현장 상황에 대한 파악을 하여 재난현장의 의료수요를 평가하고, 추가 인력, 장비, 물품이 필요한지에 대해 종합하여 중앙응급의료상황실에 보고 ○ <u>보건복지부 및 중앙응급의료상황실</u>은 동시에 많은 의료 인력이 필요한 경우 다수 권역 DMAT, 재난거점병원이 아닌 응급의료기관에게 출동을 요청할 수 있으며, 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 다수 권역 DMAT 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상 장기 대응이 필요하다고 판단하는 경우 중앙 DMAT의 출동을 결정할 수 있음 ○ <u>후착팀은</u> 인력 구성으로 시간이 소요됨에 따라 <u>선착팀은 후착팀 파견 여부를 신속히 판단하여 중앙응급의료상황실에 요청해야 시간을 단축할 수 있음</u>	▶ 문구 정비
p.31 마. 현장응급 의료소 시행장소 선정(P, Place)	마. 현장응급의료소 시행장소 선정 ○ <u>현장응급의료소 설치가 필요하나 설치 전인 경우 설치장소를 협의하여 선정</u>	마. 현장응급의료소 시행장소 선정(P, Place) 〈삭 제〉	▶ 문구 정비
p.32 4. 후착팀 합류	4. <u>후발 DMAT</u> 합류 ○ <u>후발대로 참여하거나 인근 권역/지역 DMAT으로 합류하는 경우</u> 현장에 도착하여 가장 먼저 현장응급의료소장에게 보고함	4. <u>후착팀</u> 합류 ○ <u>후착팀으로 참여하는 DMAT이나 신속대응반은</u> 현장에 도착하여 가장 먼저 현장응급의료소장에게 <u>보고하고, 현장응급 의료소장 부재 시 선착팀에 도착을 알림</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유																								
p.32~33 4. 후착팀 합류	○ 선착대는 <u>합류하는 DMAT에게</u> 현장 상황에 대한 정보를 제공해야 함 ○ 현장응급의료소장에게 임무를 부여받고 DMAT의 업무를 개시함 <table><tr><th>선착대</th><th>DMAT 후발대(후착대)</th></tr><tr><td>• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동</td><td>• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체가 되는 경우 후발대로 현장으로 출동</td></tr><tr><td>• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 10분 이내에 빠른 출동 및 안전하게 현장 도착을 목표</td><td>• 출동대기요청 이후 2시간 내에 출동</td></tr><tr><td>• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착대</u>는 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계 받음</td><td>〈신 설〉</td></tr><tr><td>• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보</td><td>• 합류팀도 다시 현장 안전 확보</td></tr><tr><td>• 분류반과 처치반, 이송반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠</td><td>• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착대와 합류팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반의 인력을 재조정하여 배치</td></tr></table>	선착대	DMAT 후발대(후착대)	• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동	• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체가 되는 경우 후발대로 현장으로 출동	• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 10분 이내에 빠른 출동 및 안전하게 현장 도착을 목표	• 출동대기요청 이후 2시간 내에 출동	• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착대</u> 는 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계 받음	〈신 설〉	• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보	• 합류팀도 다시 현장 안전 확보	• 분류반과 처치반, 이송반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠	• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착대와 합류팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반의 인력을 재조정하여 배치	○ 선착팀은 <u>합류하는 DMAT이나 신속대응반에게</u> 현장 상황에 대한 정보를 제공해야 함 ○ 현장응급의료소장에게 임무를 부여받고 DMAT의 업무를 개시함. <u>현장응급의료소장에게</u> 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 <u>DMAT이</u> 부여하거나 혹은 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정함 <table><tr><th>선착팀</th><th>후착팀</th></tr><tr><td>• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동</td><td>• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체되는 경우 후착팀으로 현장 출동</td></tr><tr><td>• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게(10분 이내 목표) 출동하여 안전하게 현장에 도착하도록 함</td><td>• 출동 요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게 출동(1팀: 10분 이내 목표, 2팀: 2시간 이내 목표)하여 안전하게 현장에 도착하도록 함</td></tr><tr><td>• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착팀</u>은 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계받음</td><td>• 현장응급의료소장에게 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 <u>DMAT이</u> 부여하거나 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정함</td></tr><tr><td>• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보</td><td>• 후착팀도 다시 현장 안전 확보</td></tr><tr><td>• 분류반과 처치반, 이송반, 운영지원반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠</td><td>• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착팀과 후착팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반, 운영지원반의 인력을 재조정하여 배치</td></tr></table>	선착팀	후착팀	• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동	• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체되는 경우 후착팀으로 현장 출동	• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게(10분 이내 목표) 출동하여 안전하게 현장에 도착하도록 함	• 출동 요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게 출동(1팀: 10분 이내 목표, 2팀: 2시간 이내 목표)하여 안전하게 현장에 도착하도록 함	• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착팀</u> 은 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계받음	• 현장응급의료소장에게 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 <u>DMAT이</u> 부여하거나 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정함	• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보	• 후착팀도 다시 현장 안전 확보	• 분류반과 처치반, 이송반, 운영지원반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠	• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착팀과 후착팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반, 운영지원반의 인력을 재조정하여 배치	▶ 문구 정비
선착대	DMAT 후발대(후착대)																										
• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동	• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체가 되는 경우 후발대로 현장으로 출동																										
• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 10분 이내에 빠른 출동 및 안전하게 현장 도착을 목표	• 출동대기요청 이후 2시간 내에 출동																										
• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착대</u> 는 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계 받음	〈신 설〉																										
• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보	• 합류팀도 다시 현장 안전 확보																										
• 분류반과 처치반, 이송반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠	• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착대와 합류팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반의 인력을 재조정하여 배치																										
선착팀	후착팀																										
• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동	• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체되는 경우 후착팀으로 현장 출동																										
• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게(10분 이내 목표) 출동하여 안전하게 현장에 도착하도록 함	• 출동 요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게 출동(1팀: 10분 이내 목표, 2팀: 2시간 이내 목표)하여 안전하게 현장에 도착하도록 함																										
• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 <u>선착팀</u> 은 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계받음	• 현장응급의료소장에게 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 <u>DMAT이</u> 부여하거나 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정함																										
• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계현장 안전 확보	• 후착팀도 다시 현장 안전 확보																										
• 분류반과 처치반, 이송반, 운영지원반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠	• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선착팀과 후착팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반, 운영지원반의 인력을 재조정하여 배치																										

구분	현행	개정안	수정사유
p.34 가. 현장응급 의료소의 구성과 운영	○ 이송반 : 중증도 분류에 따라 이송할 병원을 지정하고, PS-LTE 및 모바일 상황실의 연락을 담당하며 최소 1인 이상 배치함. <u>지역응급의료지원센터의 인력이 현장에 도착한 경우 우선적 배치함</u> 〈신 설〉	○ 이송반 : 중증도 분류에 따라 이송할 병원을 지정하고, PS-LTE 및 모바일 상황실의 연락을 담당하며 최소 1인 이상 배치함. ○ 운영지원반 : <u>현장응급의료소의 행정 업무(현장기록, 사상자 현황 파악, 상황실 정보 보고, 추가자원 동원 등)를 수행. 응급의료지원센터가 현장에 도착한 경우 운영지원반의 업무를 지원할 수 있음</u>	▶ 문구 정비
p.34 나. 현장응급 의료소 활동 (3T)	나. 현장응급의료소 <u>활동</u> ○ <u>중증도분류</u> - 〈신 설〉 - 중증도분류는 <u>MASS(다중손상 중증도 분류), SALT법을 기본으로 하고, 각 환자에 대한 중증도 분류에는 START법을 병용할 수 있음</u>	나. 현장응급의료소 <u>활동(3T)</u> ○ <u>중증도분류(T, Triage)</u> - <u>소생 가능성이 매우 희박한 심정지 환자 또는 현장응급의료소의 역량을 초과하는 다수의 심정지 환자가 발생한 경우 의사(구급지도의사 포함) 지도에 따라 개별 또는 다수의 심정지 환자에 대한 심폐소생술을 유보할 수 있음</u> ○ 중증도분류는 <u>MASS(Move, Assess, Sort, Send), SALT (Sort, Assess, Life-saving interventions, Treatment/transport), START(Simple Triage And Rapid Treatment) 법 등을 사용할 수 있음</u>	▶ 문구 정비
p.36 • 응급처치 (T, Treatment)	○ <u>응급처치</u> - 응급처치는 <u>DMAT이</u> 현장에 가져간 재난의료지원물품을 기본으로 사용하며, 부족 시 구급차에 있는 물품을 요청하여 <u>사용함</u>	○ <u>응급처치(T, Treatment)</u> - 응급처치는 <u>DMAT 및 신속대응반이</u> 현장에 가져간 재난의료 지원물품을 기본으로 사용하며, 부족 시 구급차에 있는 물품을 <u>활용함</u>. 추가적인 물품이 필요한 경우 <u>현장응급의료소장을 통해 통제단장에게 요청 후 중앙응급의료상황실에 보고</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.37 • 이송 (T, Transportation)	○ 이송 - 병원별 수용능력은 실시간으로 조사하고 부록4의 병원별 수용능력표를 작성하여 이송병원 선정에 참고함 - 선정된 이송병원명, 구급차 차량번호, 현장출발시간 등을 기재하여 중증도 분류표 작성을 완성하고, 1부는 이송반에 나머지 1부는 의료기관이 보관할 수 있도록 환자와 함께 인계함	○ 이송(T, Transportation) - 부록 4의 '병원별 수용능력표'를 준용하여 병원별 중상자와 경상자 수용능력을 실시간으로 조사하고, 이송병원 선정에 참고함. - 선정된 이송병원명, 구급차 차량번호 또는 구급차 소속, 현장출발시간 등을 기재하여 중증도 분류표 작성을 완성하고, 1부는 이송반에 나머지 1부는 의료기관이 보관할 수 있도록 환자와 함께 인계함	▶ 문구 정비
p.38 다. 보건소	○ 보건소는 관할 지역 내 <u>재난 또는 다수 사상자 발생 사고</u> 에 대비하여 <u>의료인 2~3인, 행정요원 2인</u> 으로 구성된 신속대응반을 편성 현장응급의료소 운영일지 필수 기재사항	○ 보건소는 관할 지역 내 <u>재난 등에</u> 대비하여 <u>의사/간호사/응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상</u> 으로 구성된 신속대응반을 편성 〈삭 제〉	▶ 문구 정비
p.39 마. 응급의료지원센터	마. <u>지역응급의료지원센터</u> ○ <u>지역응급의료지원센터의 주업무는 재난거점병원 - 보건소 - 시·도 공무원 - 중앙응급의료상황실 등 재난의료 관계기관 간 협력을 지원하고, 보건소의 현장응급의료소 운영 지원 업무를 협력 수행하는 것임</u>	마. <u>응급의료지원센터</u> ○ <u>평시 재난의료관리자는 재난거점병원 - 보건소 - 시·도 공무원 - 중앙응급의료상황실 등 재난의료 관계기관 간 협력을 지원</u> - 재난거점병원의 재난교육, 훈련, 정보 관리, 재난의료 핫라인 관리 등 재난의료 대비 및 질 향상 활동	▶ 문구 정비
p.39 마. 응급의료지원센터	〈신 설〉	○ 재난 발생 시 재난 현장에서 보건소 신속대응반과 DMAT의 현장응급의료소 운영지원 업무 수행	▶ 현장 출동 명시

구분	현행	개정안	수정사유
p.40 7. 활동의 종료 후 조치사항	○ 응급의료법 시행령 제9조에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다수의 환자가 발생한 때에는 사고 발생일로부터 사고수습 종료일까지 매일 1일 활동상황을 보건복지부장관에게 <u>보고</u>하여야 하며, 사고 수습이 종료된 경우에는 지체 없이 <u>종합보고</u>를 하여야 함(부록 6 참고) 〈신설〉	○ 응급의료법 시행령 제9조에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다수의 환자가 발생한 때에는 사고 발생일로부터 사고수습 종료일(지역재난안전대책본부가 설치된 경우 사고수습종료일은 지역재난안전대책본부 운영종료일로 봄)까지 매일 1일 활동상황을 보건복지부장관에게 <u>통보</u>하여야 하며, 사고 수습이 종료된 경우에는 지체 없이 <u>종합하여 통보</u>하여야 함 ○ 현장에 출동했던 보건소, 재난거점병원, 응급의료지원센터는 사고수습 종료 후 선착팀 및 현장응급의료 활동에 대한 자체 평가를 실시하여야 하며, 그 결과는 기관별로 유지하여야 함	▶ 문구 정비
p.40~41 가. 현장기록	○ 중증도 분류표 서식은 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 붙임 서식을 <u>참고로 하되</u>(부록 3 참고) 자체 제작한 중증도 분류표가 있다면 사용할 수 있음. 단 다음의 정보는 반드시 기재되도록 함 중증도분류표 서식 필수 기재사항 ○ 병원별 수용능력표는 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 별지 제1의3 서식에 따라 기입하도록 함(부록 4 참고) ○ 현장응급의료소 운영일지*는 별도의 서식은 없지만 다음과 같은 사항은 필수적으로 기재해야 함 현장응급의료소 운영일지 필수 기재사항 〈신설〉	○ 중증도 분류표 서식은 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 붙임 서식을 <u>참고로 함</u>(부록 3 참고) 〈삭제〉 ○ 병원별 수용능력표는 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 별지 제1의3 서식을 참고하여 병원별 중상자와 경상자의 수용능력을 파악하여 기입하도록 함(부록 4 참고) 〈삭제〉 ○ 현장 대응이 길어지는 경우 환자 등록지를 활용할 수 있음(부록 6 참고)	▶ 문구 정비
p.41 나. 결과보고서	○ 신속대응반은 현장응급의료소 운영일지(부록 7 참고), DAMT은 활동보고서(부록 6 참고)을 작성하여 1주일 이내에	○ 신속대응반은 신속대응반 활동보고서(부록 7 참고), DMAT은 DMAT 활동보고서(부록 8 참고)를 작성하여 사고수습종료일	▶ 문구 정비

구분	현행				개정안				수정사유
	응급의료지원센터에 제출해야함 ○ 중앙응급의료상황실은 중앙응급의료상황실에서 작성한 결과 보고서와 취합된 자료를 <u>보건복지부에</u> 제출해야 함				1주일 이내에 응급의료지원센터에 제출해야 함 ○ 중앙응급의료상황실은 중앙응급의료상황실에서 작성한 결과 보고서와 취합된 자료를 <u>보건복지부 및 관할 시·도에</u> 제출해야 함				
p.45 IV. 재난현장의 응급의료지원 인력의 구성 및 운영	구분	신속대응반	권역 DMAT	중앙 DMAT	구분	신속대응반	권역 DMAT	중앙 DMAT	▶ 문구 정비
	출동 개시 (요청 후)	즉시	1차팀 10분 이내 출동 2차팀 2시간 이내 3차팀 12시간 이내	3시간 이내	출동 개시 (요청 후)	즉시	1팀 10분 이내 출동 목표 2팀 2시간 이내 출동 목표 3팀 12시간 이내 교대	3시간 이내	
	인원 구성	의료인 2~3인, 행정요원 2인 이상	팀당 의사 1인, 간호사/ 응급구조사 2인, 행정요원 1인	의사, 간호사, 행정요원이 기본으로 사고 유형 및 규모에 따라 구성	인원 구성	의사/간호사/ 응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상	팀당 의사 1인, 간호사/ 응급구조사 2인, 행정요원 1인	사고 유형 및 규모에 따라 구성	
	운영	현장상황이 12시간 이상 길어지면 추가 1개팀 구성하여 파견(인근 보건소 인력 구성 가능)	현장상황이 12시간 이상 길어지면 인력 교체를 위한 팀 파견	중앙응급의료 센터장이 판단하여 후발대 파견 가능	운영	현장상황이 12시간 이상 길어지면 인력 교체를 위한 팀 파견	현장상황이 12시간 이상 길어지면 인력 교체를 위한 팀 파견	복지부 및 중앙응급의료 센터가 판단하여 후발대 파견 가능	
	물품	신속대응반 물품	1차팀 DMAT bag 2차팀 현장응급 의료소 물품	DMAT bag 현장응급의료소 물품	물품	신속대응반 물품	1팀 DMAT bag 2팀 현장응급 의료소 물품	DMAT bag 현장응급의료소 물품, 필요 시 이동형병원	
	이동	긴급자동차	1차팀 긴급자동차 2차팀 재난의료 지원차량	긴급자동차	이동	긴급자동차 등	1팀 긴급자동차 등 2팀 재난의료 지원차량	긴급자동차 등	

구분	현행	개정안	수정사유
p.46 가. 보건소장	○ 보건소장은 재난 관련 교육 프로그램을 참여 및 이수해야 함 <u>〈신설〉</u> ○ 재난 발생 시 직접 현장에 출동하지 못하는 경우, 출동한 보건소 직원에게 현장대응에 대한 권한 위임을 할 수 있음 ○ 통제단장의 지휘를 받아 응급의료자원의 관리, 사상자의 분류, 응급처치, 이송 및 사상자 현황파악, 보고 등의 현장 응급의료소의 운영 전반을 지휘·감독함	<u>〈삭제〉</u> ○ <u>현장응급의료소 설치 지역의 관할 보건소장은 현장응급의료소장이 됨</u> ○ <u>현장응급의료소장은 보건소장>권역응급의료센터장>응급의료지원센터장>지역응급의료센터장이 할 수 있음</u> - 위 각 기관장의 역할은 기관장의 권한과 책임을 위임받은 해당 기관의 소속 직원이 대신할 수 있음 ○ <u>현장응급의료소장은 통제단장의 지휘를 받아 응급의료자원의 관리, 사상자의 분류, 응급처치, 이송 및 사상자 현황 파악, 보고 등의 현장응급의료소의 운영 전반을 지휘·감독함</u>	▶ 문구 정비
p.46 다. 인원 구성	다. 인원 구성 ○ <u>의료인 2~3인, 행정요원 2인 이상으로 구성</u> ○ <u>신속대응반은 출동 요청을 받은 즉시 1개 팀을 구성 및 출동하는 것을 목표로 해야 하며, 12시간이 초과되는 경우 추가 1개팀 (총 2개팀)을 구성하여 교대함</u> ○ <u>신속대응반은 재난 등의 발생 관할 지역 보건소에서 출동하는 것을 원칙으로 하나 이후 출동팀은 인근 보건소 인력으로 구성할 수 있음</u>	다. 인원 구성 ○ <u>의사/간호사/응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상으로 구성</u> ○ <u>신속대응반은 출동 요청을 받은 즉시 1개 팀을 구성 및 출동하는 것을 목표로 하며, 현장 활동이 12시간을 넘게 되는 경우 교대팀이 투입될 수 있도록 보건소별로 총 2개 팀 이상을 구성함</u> <u>〈삭제〉</u>	▶ 문구 정비
p.46 라. 복장	○ <u>현장에 출동하는 신속대응반 인원은 가능한 재난의료팀을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고) 과 출입증을 착용해서, 타 재난 관계자들이 재난 의료팀을 용이하게 인식할 수 있도록 해야 함</u> ○ <u>신속대응반임과 동시에 가능한 직역과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함</u>	○ <u>현장에 출동하는 신속대응반은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 신속대응반을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함</u> ○ <u>현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.47 마. 운영	마. 운영 ○ <u>재난 등의 발생으로 출동 요청이 있을 경우 선발대는 가능한 즉시 출동해야 함</u> ○ <u>보건소장은 재난 응급의료 지원의 성격과 규모를 감안하여 인근 보건소의 재난의료인력 지원을 통해 추가로 1개 팀을 파견할 수 있음. 또한, 현장 상황이 12시간 이상 길어질 경우, 기존 인력의 교체를 위해 인근 보건소의 인력의 지원을 통해 교체 팀을 파견 할 수 있음</u> ○ <u>현장에 도착한 신속대응반은 현장에 있는 DMAT과 팀을 같이 구성하되 부상자, 사망자 현황 정보 수집 및 관리와 같은 행정에 관련된 부문에 더욱 집중해 활동</u>	마. 운영 ○ <u>재난 등의 발생으로 출동 요청을 받은 신속대응반은 가능한 즉시 1개 팀을 출동하도록 해야 함</u> ○ <u>현장 활동이 12시간 이상 길어질 경우 인근 보건소 인력 지원 등을 통해 교체팀을 파견할 수 있음</u> ○ <u>신속대응반은 재난 등의 발생 관할 지역 보건소에서 출동하는 것을 원칙으로 하나 재난의 유형이나 규모에 따라 인근 보건소의 신속대응반이 출동 요청될 수 있음</u> 〈삭 제〉	▶ 문구 정비
p.47 아. 교육훈련	○ <u>신속대응반 구성 인력은관련 교육 프로그램을 이수해야 함</u> ○ <u>신속대응반 구성 인력은 교육 프로그램과 별도로 재난대비 훈련도 해야 함</u> ○ <u>개인별 연간 훈련 참여 실적을 보건소에 등록해야 함</u>	○ <u>보건소장 등은 현장응급의료소장을 위한 별도의 교육 프로그램을 이수해야 함</u> ○ <u>신속대응반 구성 인력은 관련 교육 프로그램을 이수해야 하며, 해당 보건소 및 시·도, 시·군·구, 소방 등 유관기관에서 진행하는 재난 대비 훈련에 연 1회 이상 참여해야 함</u> ○ <u>신속대응반 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 보건소에서 등록하고 관리해야 함</u>	▶ 문구 정비
p.48 가. 재난의료 책임자	○ <u>재난의료책임자는 관련 교육 프로그램을 이수해야만 임명 가능함</u> ○ <u>해당 재난거점병원의 재난의료의 준비 및 대응에 관해 책임이 있으며, 보건소 및 지역 DMAT과 긴밀한 관계를 유지해야 함</u>	〈삭 제〉 ○ <u>해당 재난거점병원의 재난의료의 준비 및 대응에 관해 책임이 있으며, 소방, 보건소 등 재난 대응 및 지원 기관과 긴밀한 관계를 유지해야 함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	○ <u>DMAT이 신속히 출동할 수 있도록 월 단위의 당직 DMAT 명단을 확보해야 함</u>	○ <u>권역DMAT이 출동 요청에 따라 신속하게 출동할 수 있도록 월 단위로 당직 DMAT 명단을 확보하고, 이를 위한 권역 DMAT 인력풀을 관리해야 함</u>	
p.48 다. 인원 구성	○ <u>재난거점병원 별로 총 3개팀을 구성해야 함</u>	○ <u>재난거점병원은 3개 팀을 구성하고 동시 최대 2개 팀이 출동할 수 있도록 권역DMAT의 인력풀을 유지하도록 함</u>	▶ 문구 정비
p.48 라. 복장	○ <u>현장에 출동하는 DMAT 인원은 가능한 재난의료팀을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)과 출입증을 착용해서, 타 재난 관계자들이 재난 의료팀을 용이하게 인식할 수 있도록 해야 함</u> ○ <u>DMAT임과 동시에 가능한 직역과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함(부록 1, 2참고)</u>	○ <u>현장에 출동하는 권역DMAT은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 권역DMAT을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함</u> ○ <u>현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함</u>	▶ 문구 정비
p.48~49 마. 운영	○ <u>최초 출동 DMAT은 당일 당직 근무중인 의사, 간호사, 응급구조사를 중심으로 편성, 재난의료책임자의 지시에 따라 10분 이내 출동을 목표로 함</u> ○ <u>재난의료책임자는 현장 상황에 따라 DMAT을 추가로 1개 팀을 파견할 수 있으며 2시간 이내 출동을 목표로 함. 또한, 현장 상황이 12시간 이상 길어질 경우 기존 인력의 교체를 위해 1개 팀을 파견할 수 있음</u> ○ <u>중앙응급의료센터장의 요청에 따라 관외 지역에 출동할 수 있음</u>	○ <u>권역 DMAT 1팀은 원칙적으로 당일 당직 근무중인 응급 의학과 등 전문의, 간호사, 응급구조사를 중심으로 편성하도록 하여 출동요청 후 10분 이내 출동을 목표로 함</u> ○ <u>현장 상황에 따라 인력, 의료물품 등의 추가 지원이 필요한 경우 2시간 이내 2팀을 파견할 수 있으며, 현장 활동이 12시간을 넘게 되는 경우에도 교체팀을 파견할 수 있도록 함</u> ○ <u>권역DMAT은 재난 등의 발생 지역에서 근거리 순으로 출동하는 것을 원칙으로 하되, 재난 등의 유형이나 규모에 따라 달리 적용할 수 있음</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.49 바. 출동 방법	○ <u>다수사상자 사고현장으로 출동지시가 발생한 경우 최초 출동 DMAT은 보관중인 재난 물품을 지참하고 즉시 현장으로 출동해야 하며, 이동 방식은 긴급자동차(예 119 구급차, 병원 앰불런스 등)을 이용해 출동함</u> ○ <u>재난의료지원차량이 있는 재난거점병원은 DMAT 2팀 출동 시 재난의료지원차량 물품 기준에 맞춰 모두 적재 후 출동함. 단, 재난의료지원차량 및 차량 내 물품 등이 필요한 경우에는 준비되는 대로 즉시 출동할 수 있음(차량의 출동 및 중단 여부는 재난의료책임자가 결정함)</u> ○ <u>DMAT 혹은 재난의료지원차량이 출동한 경우 재난의료 책임자는 이를 즉각 중앙응급의료상황실에 보고해야 함</u>	○ <u>재난 등 현장으로 출동지시가 발생한 경우 권역DMAT은 보관중인 재난 물품을 지참하고 즉시 현장으로 출동(목표 시간 10분 이내)해야 하며, 이동 방식은 긴급자동차(예 119 구급차, 병원 앰불런스 등) 등을 이용해 출동함</u> ○ <u>재난의료지원차량이 출동하는 경우 재난의료지원차량 물품 기준에 맞춰 모두 적재 후 출동함(차량의 출동 및 중단 여부는 재난의료책임자가 결정함)</u> ○ <u>권역DMAT이 출동한 경우 재난의료책임자는 출발시각, 예상 도착시간, 출동 인력 현황을 즉각 중앙응급의료상황실에 보고해야 함</u>	▶ 문구 정비
p.49 사. 역할	○ <u>DMAT 등 추가 의료지원 요청 여부 결정 및 중앙응급의료 상황실로 보고</u>	○ <u>추가 의료지원 요청 여부 결정 및 중앙응급의료상황실로 보고</u>	▶ 문구 정비
p.49 아. 교육훈련	아. 교육훈련 ○ <u>DMAT 구성 인력은 관련 교육 프로그램을 이수해야 함</u> ○ <u>DMAT 구성 인력은 교육 프로그램과 별도로 재난 대비 훈련도 해야 함</u> ○ <u>개인별 연간 훈련 참여실적을 중앙응급의료센터에 등록해야 함</u> ○ <u>지역 내 보건-소방-의료기관 등 관련 기관이 참여하는 재난대응 교육을 주관하여 제공하고, 연 2회 이상 재난대응 훈련을 직접 실시하거나 소방본부 등이 주관하는 훈련에 참여해야 함</u>	아. 교육훈련 ○ <u>권역 DMAT 구성 인력(재난의료책임자 포함)은 관련 교육 프로그램(재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육 등)을 이수해야 함</u> ○ <u>재난거점병원은 지역 내 소방-보건소-의료기관 등 관련 기관이 참여하는 재난대응 교육·훈련을 연 2회 이상 주관하여 실시하고, 연 3회 이상 외부기관이 주관하는 훈련에 참여해야 함</u> ○ <u>권역 DMAT 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 소속 기관에서 등록하고 관리해야 함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.50 가. 출동 기준	○ 권역 DMAT의 역량을 초과하는 대규모 재난 발생시 보건복지부 및 중앙응급의료센터의 요청에 따라 출동 ○ 국립중앙의료원 인력으로 편성된 중앙 DMAT은 출동 요청이 발생한 후 3시간 이내 출동하는 것을 원칙으로 함	○ 다수 권역DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 대응이 예상되는 재난 등의 경우 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 중앙 DMAT의 출동을 결정할 수 있음 ○ 국립중앙의료원 등의 인력으로 편성된 중앙 DMAT은 출동 요청이 발생한 후 3시간 이내 출동하는 것을 원칙으로 함	▶ 문구 정비
p.50 나. 출동 인원	○ 의사, 간호사, 행정요원을 기본으로 하되, 사고 유형 및 규모에 따라 인원 및 직렬 구성 가능	○ 의사, 간호사/응급구조사, 행정요원을 기본으로 하되, 사고 유형 및 규모에 따라 인원 및 직렬 구성 가능	▶ 문구 정비
p.50 다. 복장	○ 현장에 출동하는 DMAT 인원은 가능한 중앙 DMAT을 인식할 수 있는 복장과 출입증을 착용해서, 타 재난 관계자들이 중앙 DMAT임을 용이하게 인식할 수 있도록 해야 함 ○ DMAT임과 동시에 직역 혹은 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함 (부록 1, 2 참고)	○ 현장에 출동하는 중앙DMAT은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 중앙DMAT을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함 ○ 현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함	▶ 문구 정비
p.50 라. 운영	○ 중앙응급의료센터장은 의사, 간호사, 약사, 의료기사 등이 포함된 중앙 DMAT 인력풀을 구성·운영하여 출동에 대비하여야 함 ○ 선발대 출동은 3시간 이내 출동을 목표로 하며, 중앙응급의료센터장은 재난 응급의료 지원의 성격과 규모를 감안하여 후발대를 파견할 수 있음 ○ 중앙응급의료센터장은 재난 등의 유형 및 규모에 따라 필요한 이동형 병원 모듈을 구성하며, 이동형 병원 설치를 위한 부지 선정을 위하여 통제단장에게 협조를 요청할 수 있음	○ 중앙응급의료센터장은 의사, 간호사, 약사, 응급구조사, 의료기사 등이 포함된 중앙DMAT 인력풀을 구성·운영하여 출동에 대비하여야 함 ○ 최초 중앙 DMAT은 3시간 이내 출동을 목표로 하며, 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 재난 등의 유형과 규모를 감안하여 추가 지원 규모 및 출동 준비 시간을 조정할 수 있음 〈삭 제〉 〈삭 제〉	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	○ 이동형 병원 설치 및 운용 등에 관한 내용은 관련 매뉴얼을 참고하여 운영함		
p.50~51 마. 교육훈련	○ DMAT 구성 인력은 관련 교육 프로그램을 이수해야 함 ○ DMAT 구성 인력은 교육 프로그램과 별도로 재난 대비 훈련을 해야 함 ○ 개인별 연간 훈련 참여 실적을 중앙응급의료센터에 등록해야 함	○ 중앙DMAT 구성 인력은 관련 교육 프로그램(재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육 등)을 이수해야 함 ○ 중앙DMAT 구성 인력은 소속기관 및 유관기관에서 진행하는 재난대비 훈련(이동형 병원 운영 훈련 등)에 참여해야 함 ○ 중앙DMAT 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 중앙응급의료센터에서 등록하고 관리해야 함	▶ 문구 정비
p.51 4. 재난 등의 발생 시 응급의료 지원	〈신 설〉	○ 응급의료법 제18조 및 동법 시행령 제10조에 따라 시·도 지사는 다수의 환자발생에 대비하여 환자 발생의 원인 및 규모에 따른 적절한 조치계획을 수립해야 함	▶ 다수환자 조치계획 수립의무 신설
p.51 4. 재난 등의 발생 시 응급의료 지원	〈신 설〉 ○ 재난거점병원 외 응급의료기관은 의료기관의 역량에 따라 현장 응급의료지원을 위한 DMAT을 편성하여 운용할 수 있으며, 중앙응급의료상황실의 상황 전파에 따라 부상자 이송에 대비하여 응급실과 의료진, 병상 등을 준비하여야 함 ○ 재난거점병원의 DMAT 팀원이 출동할 시에는 해당 병원에서 ‘출장’으로 행정처리를 해야 하며 이에 따른 행정비용은 병원이 부담함 〈신 설〉	○ 재난거점병원 및 보건소는 DMAT과 신속대응반으로 투입 가능한 인력의 명단을 매달 중앙응급의료센터로 제출해야 함 ○ 재난거점병원 외 응급의료기관은 의료기관의 역량에 따라 현장 응급의료지원을 위한 지역 DMAT을 편성하여 운용할 수 있으며, 중앙응급의료상황실의 상황 전파에 따라 부상자 이송에 대비하여 응급실과 의료진, 병상 등을 준비하여야 함 ○ 재난거점병원의 권역 DMAT이 출동할 시에는 해당 병원에서 ‘출장’으로 행정처리를 해야 하며 이에 따른 행정비용은 병원이 부담함	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
		○ 보건복지부는 현장 응급의료지원 업무 중 발생한 상해 등에 대비하여 출동 인력을 대상으로 보험가입 등을 할 수 있고 이에 대한 비용을 부담함	
p.55 1. 응급의료지원 물품의 정의	○ ‘응급의료지원 물품’이란 재난 상황 시 의료지원을 위해 현장에 출동하는 DMAT 소속 팀원 개인물품 DMAT Bag을 포함하여 재난거점병원에서 보유(재난의료지원차량 포함)하고 있는 현장응급의료소 등 재난현장에 지원하는 물품 일체를 말함 <u>〈신 설〉</u>	○ ‘응급의료지원 물품’이란 재난 상황 시 의료지원을 위해 현장에 출동하는 DMAT 소속 팀원 개인물품 DMAT Bag을 포함하여 재난거점병원에서 보유(재난의료지원차량 포함)하고 있는 현장응급의료소 등 재난현장에 지원하는 물품 일체를 말함 ○ ‘이동형 병원’은 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 의료지원이 필요한 경우 재난 현장에 설치하는 의료소로, 이동이 가능한 형태로 일정 기간 자급 자족이 가능하며 필요에 따라 규모의 확장 및 축소 운영이 가능한 시설과 장비 등을 말함	▶ 문구 정비 및 이동형 병원 정의 신설
p.56 2. DMAT 물품	○ DMAT 1차팀은 구성원별 DMAT bag을 가지고 <u>긴급 자동차로 이동</u> <u>〈그림 11. DMAT 1차팀 출동 물품의 예〉</u> - 보호복 : 활동복 또는 표준 복장(부록1), 모자 또는 헬멧, <u>헤드랜턴</u> , <u>안전화</u> , 필요 시 우의	○ DMAT 1차팀은 구성원별 DMAT bag을 가지고 <u>긴급 자동차 등으로 이동</u> <u>〈그림 11. DMAT 1차팀 출동 물품의 예〉</u> * 시체낭 제외 - 보호복 : 활동복 또는 표준 복장(부록1), 모자 또는 헬멧, 필요 시 우의, <u>헤드랜턴</u> , <u>안전화</u>	▶ 문구 정비
p.57 2. DMAT 물품	○ DMAT bag - 다음의 DMAT bag 구성안은 각 DMAT에서 <u>최소한으로 구성해야 하는 물품</u> 이며, 각 DMAT의 판단에 따라 품목의 종류나 수량을 증가할 수 있으며, 같은 기능을 가진 다른	○ DMAT bag - 다음의 DMAT bag 구성안은 각 DMAT에서 구성해야 하는 <u>권장안</u> 이며, 각 DMAT의 판단에 따라 품목의 <u>종류 및 수량을 변동</u> 시킬 수 있으며, 같은 기능을 가진 다른	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	물품으로 교체도 가능함 - 특수재난(화학, 방사능 재난 등)시에는 <u>개인보호장구</u> 등을 포함하여 추가물품을 구성해 출동하거나 현장 도착 전 특수구조대나 관련 기관에서 공급받을 수 있도록 조치하여야 함	물품으로 교체도 가능함 - 특수재난(화학, 방사능 재난 등) 시에는 <u>가능한 개인보호장구</u> 등을 포함하여 추가물품을 구성해 출동하거나 현장 도착 전 특수구조대나 관련 기관에서 공급받을 수 있도록 조치하여야 함	
p.59 2. DMAT 물품	○ 기타 DMAT 물품 - DMAT 이동을 위한 구급차에 탑재가 가능한 장비, 물품을 말함 - 다음의 DMAT 물품 구성안은 최소한으로 구성해야 하는 물품이며, 각 DMAT 의 판단에 따라 품목의 종류나 수량을 증가할 수 있으며, 같은 기능을 가진 다른 물품으로 교체도 가능함	○ 재난의료지원차량 - 재난 현장 상황에 따라 필요한 경우 재난의료책임자 또는 중앙응급의료상황실은 재난의료지원차량을 권역 DMAT과 함께 출동시킬 수 있음 - 재난의료지원차량에 구비해야 하는 장비 및 물품은 부록 9 표 2와 같음	▶ 문구 정비
p.59 3. 현장응급의료소 물품	○ 현장응급의료소 물품은 중증 환자 40명 처치 기준 및 재난 현장 출동기준 72시간정도 외부의 지원 없이 현장응급의료소가 <u>원활히 운영될 수 있는 수준</u>을 맞춰야 함 〈신 설〉	○ 현장응급의료소 물품은 중증 환자 40명 처치 기준 및 재난 현장 출동기준 72시간정도 외부의 지원 없이 현장응급의료소가 <u>기본적 응급의료 기능을 수행할 수 있는 수준</u>을 맞춰야 함 ○ 추가적인 물품이 필요한 경우 현장응급의료소장을 통해 통제단장에게 요청 후 중앙응급의료상황실에 보고	▶ 문구 정비
p.60 나. 보관	○ 의약품의 경우에는 <u>약국에서 보관</u>하고 별도의 관리대장을 사용해서 보관함	○ 의약품의 경우에는 <u>DMAT을 운영하는 기관의 의약품 관리 지침에 따라 보관</u>하고 별도의 관리대장을 사용해서 보관함	▶ 문구 정비
p.60 라. 점검	〈신 설〉	○ 보건복지부는 매뉴얼 개정시마다 응급의료지원 물품의 <u>기준에 대해 전문가 자문 조사를 실시하고 이 결과에 따라 항목을 조정</u>하여야 함	▶ 물품 기준 갱신 근거 마련

구분	현행	개정안	수정사유
p.61 5. 신속대응반 물품 구성	○ DMAT 개인물품과 DMAT bag 수준의 물품 구성이 가능하면 구성함 ○ 주 업무가 중증외상환자 진료보다는 초기 중증도분류 및 행정지원업무이기 때문에 다음과 같은 구성도 가능함 〈신설〉 〈신설〉	〈삭제〉 〈삭제〉 ○ 신속대응반 개인물품 - 보호복 : 활동복 또는 표준 복장(부록1), 모자 또는 헬멧, 필요 시 우의, 헤드랜턴, 안전화 - 통신수단 : PS-LTE단말기, 무전기 등 - 랜턴, 글로브, 마스크, 가위, 펜 등 - 재난출입증(비표) ○ 신속대응반 bag	▶ 문구 정비
p.62~65 6. 이동형 병원	〈신설〉	6. 이동형 병원 〈본문 참조〉	▶ 이동형 병원 신설
p.69 가. 핫라인 구성	○ 핫라인은 재난발생시 보건복지부, 시·도, 중앙응급의료센터, 병원, <u>보건소 간의</u> 신속하고 일관성 있는 대응을 유도하는 통합 <u>연락체계임</u> ○ 핫라인은 유선전화, 무선전화, PS-LTE(Long Term Evolution; 4세대 이동 통신 방식) 등을 사용할 수 있음	○ 핫라인은 재난발생시 보건복지부, 시·도, 중앙응급의료센터, 소방, 병원, <u>보건소 등 간의</u> 신속하고 일관성 있는 대응을 유도하는 통합 <u>연락체계로</u>, 대외에 공개되지 않도록 관리하여야 함 ○ 핫라인은 유선전화, 무선전화, <u>PS-LTE</u> 등을 사용할 수 있음	▶ 문구 정비
p.69~70 다. 핫라인 및 비상연락망 취합·점검	○ 모든 구성원은 핫라인 및 비상연락망 변동 시 <u>중앙응급의료상황실에</u> 그 즉시 알려야 함 ○ PS-LTE 핫라인의 경우 응급의료지원센터가 점검 주체가 되어 <u>매 월마다</u> 점검하고, 중앙응급의료센터 <u>무선통신망</u> 사업 담당 부서로 결과를 제출함	○ 모든 구성원은 핫라인 및 비상연락망 변동 시 <u>응급의료지원센터</u>를 통해 중앙응급의료상황실에 그 즉시 알려야 함 ○ PS-LTE 핫라인의 경우 응급의료지원센터가 점검 주체가 되어 <u>매 월</u> 점검하고, 중앙응급의료센터 <u>재난안전통신망</u> 사업 담당 부서로 결과를 제출함	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.70 2. 상황접수 및 전파체계	○ 중앙응급의료상황실은 신속한 상황 전파를 위해 <u>스마트폰</u> 등 개인 무선통신장비 또는 응급의료 무선통신장비(PS-LTE)를 활용하여 다음 체계도에 따라 상황을 전파함	○ 중앙응급의료상황실은 신속한 상황 전파를 위해 <u>휴대전화기</u> 등 개인 무선통신장비 또는 응급의료 무선통신장비(PS-LTE)를 활용하여 다음 체계도에 따라 상황을 전파함	▶ 문구 정비
p.70 그림 14	〈그림 12. 상황 전파 체계도〉	〈그림 14. 상황 전파 체계도〉 - 응급의료지원센터 → 현장의료 임무 부여	▶ 그림 수정
p.71 • 현장과의 통신	- 신속대응반 및 DMAT은 시·도 또는 중앙응급의료상황실로부터 현장 활동 사항의 보고를 요청받은 경우 <u>스마트폰</u> 등 개인 무선통신장비 또는 PS-LTE를 활용하여 보고하여야 함 - 현장 의료진은 DMAT 활동(출동, 현장도착, 현장활동개시, 활동내용, 철수 등), 환자이송현황(현장에서 이송되는 환자를 대상으로 정보 수집), 환자이송지침, 필요 자원 요청 등의 정보를 중앙응급의료상황실로 전달해야 함(Ⅵ장 참고)	- 신속대응반 및 DMAT은 시·도 또는 중앙응급의료상황실로부터 현장 활동 사항의 보고를 요청받은 경우 <u>휴대전화기</u> 등 개인 무선통신장비 또는 PS-LTE를 활용하여 보고하여야 함 - 현장 의료진은 DMAT 활동(출동, 현장도착, 현장활동개시, 활동내용, 철수 등), 환자이송현황(현장에서 이송되는 환자를 대상으로 정보 수집), 환자이송지침, 필요 자원 요청 등의 정보를 중앙응급의료상황실로 전달해야 함	▶ 문구 정비
p.72 나. 현장 내 통신체계	○ PS-LTE를 기본으로 보조적으로 개인 무선통신장비를 통해 교신을 유지해야 함 ○ 현장에 도착한 DMAT, 신속대응반 등 모든 재난의료인력은 <u>현장 내 원활한 교신을 위해 도착 즉시 현장응급의료소장에게 보고하고 연락처를 제공해야 함</u> ○ 긴급구조기관 통신체계 - 긴급구조기관과 현장응급의료소 간 통신체계는 다음과 같이 구성될 수 있음 ① 현장지휘소에 보건소나 DMAT 연락관을 파견 ② 현장응급의료소에 긴급구조기관의 구급담당자가 파견	○ 선착팀은 먼저 재난 현장에서 중앙응급의료상황실, 현장 지휘소, 현장응급의료소 내 통신체계를 확립해야 함 ○ 현장응급의료소와 중앙응급의료상황실 간 통신체계 - PS-LTE, 휴대전화, 모바일 상황실 사용이 가능하며, 모바일 상황실 운영을 위해서는 적절한 인터넷 환경을 확보하여야 함 ○ 현장응급의료소와 현장지휘소 간 통신체계 - 현장지휘소에 연락관 파견 또는 현장응급의료소에 구급담당자를 파견함 - 현장에 출동하거나 출동 중인 신속대응반, DMAT, 응급 의료지원센터는 재난안전통신망 표준운영절차에 따라 공통	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	③ 연락관 파견 없이 통신수단 공유 - 현장응급의료소는 현장지휘소와의 통신을 위해 무선통신 수단을 확보해야 하며, 이를 위해 현장지휘소에 무전기(PS-LTE, UHF 등)를 요청할 수 있고 별도의 사유가 없는 한 현장지휘소에서는 지급해야 함	통화그룹에 합류하여야 함 ○ 현장응급의료소 내 통신체계 - 현장응급의료소 내 통신은 PS-LTE 사용을 기본으로 하되, PS-LTE 사용이 어려운 경우 휴대전화, 무전기 등을 사용함. 통신은 기본적으로 DMAT 행정요원이나 신속대응반원이 담당함	
p.72 다. 통신교육 및 대비	○ DMAT, 신속대응반은 년 2회 이상의 PS-LTE 사용법 및 관리에 대해 교육을 받아야 함(부록 9 참고)	○ PS-LTE를 사용하는 기관은 연 1회 이상 관련 교육을 받고 해당 내용을 기관 내 DMAT, 신속대응반을 대상으로 전파해야 함	▶ 문구 정비
p.75~79 VII. 재난의료 지원 활동 후 재난심리 지원 체계	VII. 재난 정신건강 서비스 및 심리지원 〈본문 참조〉	VII. 재난의료지원 활동 후 재난 심리지원 체계 〈본문 참조〉	▶ 관련 매뉴얼 변경사항 반영
p.83 VIII. 재난 시 병원 원내 반응	* 이 매뉴얼은 부상자를 수용하는 모든 의료기관(권역응급의료센터, 권역외상센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 및 응급실 운영기관)에 적용함	* 이 매뉴얼은 응급의료법에 의거한 응급의료기관(권역응급의료센터, 권역외상센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 등) 및 응급실 운영 의료기관에 적용함. 단, 원외재난대응계획의 수립과 관련한 사항은 권역응급의료센터에 적용되며, 다른 응급의료기관에 대해서는 권장사항으로 운영함	▶ 문구 정비
p.83 • 핫라인의 개설 및 운영	- 재난 등의 발생 시 신속하고 지속적인 연락을 위한 담당자와 전용전화번호를 개설하고 상시 유지 - 핫라인은 다수 환자 수용 시에도 상시 연결이 가능하도록 부상자의 진료업무에서 자유로운 직원이 수신	- 재난 등의 발생 시 신속하고 지속적인 연락을 위해 담당자와 전용전화번호(핫라인)를 개설하고 상시 유지하며, 대외에 공개되지 않도록 관리하여야 함 - 핫라인은 다수 환자 수용 시에도 상시 연결이 가능하도록 부상자의 진료업무에서 자유로운 직원이 수신하는 것을 권장함	▶ 핫라인 규정 신설

구분	현행	개정안	수정사유
p.83 • 지역 내 재난응급의료 체계 참여	- 관할지역 내 <u>응급의료종사자</u> 개인교육, 팀 훈련, <u>지역 훈련</u> 등에 참여(IX 참고)	- 관할지역 내 <u>응급의료종사자</u> 개인교육, 팀 훈련, <u>지역 재난 훈련</u> 등에 참여(IX장 참고)	▶ 문구 정비
p.83 • 의료기관 재난관리체계	- 병원 내 <u>재난대응계획 수립(비상연락망 관리 포함)</u> - <u>주기적인 원내 재난 훈련, 직원들의 재난 교육 등</u>	- <u>재난관리체계(비상연락망 관리 포함) 구축: 재난 시 원내외 의사소통, 인력을 포함한 자원 관리</u> - 정기적, 주기적인 재난 (모의) 훈련, 직원들의 재난 교육 - 재난 발생 시, 최소 72시간 동안 외부의 지원 없이 환자와 의료진의 생존, 재난응급의료대응을 위한 약품, 의료소모품, 의료장비, 식수, 식량, 자체 발전기 등의 자원을 비축해 두는 것을 권장함. 이를 위해 물류, 자원의 관리 체계를 해당 의료기관의 현실에 맞게 운영함.	▶ 문구 정비
p.84 2. 의료기관의 원외 재난대응 계획 수립	〈 <u>신 설</u> 〉 병원의 대응 주요 요소	- 재난대응조직의 구성과 역할 - 재난응급환자 진료(중증도 분류 포함) - 약품, 의료소모품, 의료장비, 식수, 식량의 준비와 보급 [참고사항] 병원의 대응 주요 요소 * Hospital Emergency Response checklist(2011). WHO regional office for Europe	▶ 문구 정비
p.85 가. 재난대응 지휘체계	○ 재난 매뉴얼은 <u>의료기관의 응급실은 물론, 각 중환자실과 병실, 외래, 검사실, 행정부서에 한 부씩 비치하여 재난 발생 시 곧바로 활용할 수 있도록 해야 함</u>	○ 재난 매뉴얼은 <u>응급실, 각 중환자실, 병실, 외래, 검사실, 행정부서에 비치하거나, 원내 홈페이지 게시판 등을 통해 확인할 수 있도록 하여 재난 발생 시 곧바로 활용할 수 있도록 함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.85 • 외부 의사소통	- 대중, 매체, 공공기관과 의사소통을 할 별도의 대변인을 지정함 - 기자실(브리핑룸)은 재난에 따른 현장을 언론과 군중으로부터 통제를 위해 진료구역, 중증도분류 지역, 대기실, 재난대책 상황실 등과 떨어진 별도의 장소에 마련해야 함	- 해당 병원에 언론의 관심이 집중되는 경우, 의료기관의 현실에 맞게 언론과 소통할 직원이나 원내 부서를 지정하는 것을 권장함. 이 경우 언론 브리핑을 위한 장소는 원내 진료구역, 원내 상황실과 분리된 별도의 장소를 준비할 것을 권장함	▶ 문구 정비
p.86 라. 중증도 분류	○ 숙련된 중증도 분류자가 시행할 수 있도록 함 ○ 중증도 분류지역은 응급실, 수술실, 중환자실과 같은 인력, 물자, 시설이 갖춰진 인근에 설치함 ○ 중증도 분류 결과를 잘 알아볼 수 있도록 적절한 중증도 분류표를 사용함	○ 최소 의사 1인, 간호사 또는 응급구조사 1인이 팀을 이루어 재난 응급환자 중증도 분류를 시행할 수 있도록 함. 응급의학과 전문의나 관련 교육을 수료한 간호사 또는 응급구조사가 중증도 분류를 시행하는 것을 권장함. 가능하면 복수의 팀이 중증도 분류를 시행하는 것을 권장함 ○ 중증도 분류지역은 의료기관의 현실에 맞게 응급실 진입로, 주차장 등 적절한 구역에 배치함 ○ 중증도 분류 결과를 잘 알아볼 수 있도록 적절한 중증도 분류표를 사용할 수도 있고, 의료기관의 현실에 맞게 전산 또는 의료기관이 정한 자체 서식을 사용할 수도 있음	▶ 문구 정비
p.86~87 마. 급증 환자 대응 능력	○ 병원의 입원실을 확장할 수 있는 수단을 강구해야 하며, 환자가 넘칠 경우 강당, 로비와 같은 공간을 진료 공간으로 마련할 수 있음 ○ 비응급환자의 진료를 위해 대체진료지역(외래, 귀가 등)을 마련하여 병원의 진료 능력을 증가시킬 수 있으며, 호텔, 학교, 체육관 등의 시설을 환자 진료구역으로 변화시킬 수 도 있음	○ 의료기관의 입원실을 확장할 수 있는 수단. 예를 들면 강당, 회의실, 복도, 로비와 같은 공간을 임시 진료 공간으로 사용할 수 있음 ○ 재난 시 의사의 의학적 판단에 따라 기도 처치, 상처 지혈, 부목 고정과 같은 생명 유지에 필요한 처치를 우선하고, 최소한의 영상의학적, 진단검사의학적 검사를 시행할 수 있음	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	○ 재난 시 검사는 최소로 할 수 있도록 함(예 : X-ray 검사는 C-Spine, Chest AP/PA, Pelvis AP 만 시행, CT 는 Brain non-contrast, Chest/Abdomen/Pelvis contrast, Spine series 만 시행 등) ○ 재난 시 투약은 최소로 할 수 있도록 함 (예: 생명유지 처치우선, 기도삽관, 수분공급, 수혈 등) ○ 임시영안소로 사용가능한 지역을 구성하고, 사체량이 충분히 공급 가능하도록 해야 함	○ 원내 장례식장 외에 임시영안소로 사용할 수 있는 구역을 지정하고 운영함	
p.87 바. 주요 서비스의 지속 제공	○ 물, 식량, 전기, 산소 등의 공급이 적절히 이루어질 수 있도록 해야 함 ○ 의료폐기물, 쓰레기 등의 수집과 폐기가 지속될 수 있도록 함 ○ 중환자와 취약그룹(소아, 노인, 장애인 등)을 위한 서비스가 지속될 수 있도록 필요한 자원을 파악함	○ 식수, 식량, 전기, 의료용 산소 등의 공급이 적절히 이루어질 수 있도록 해야 함 ○ 의료폐기물, 쓰레기 등의 수집과 폐기, 상하수도 관리, 화장실 위생 관리가 지속될 수 있도록 함 ○ 환자 및 의료기관 직원들에게 식수, 식량, 휴게 시간 및 공간을 적절히 제공할 수 있도록 해야 함	▶ 문구 정비
p.87 사. 인력	○ 실습학생, 자원봉사자 등 추가 인력을 훈련하고 모집할 수 있어야 하며, 이 때 이들의 보험, 임시면허증 등의 문제를 해결해야 함 ○ 인력 배치의 예 ○ 직원들에게 물, 식량, 생활공간을 제공할 수 있도록 계획을 수립해야 함	〈삭 제〉 ○ [참고사항] 인력 배치의 예 〈삭 제〉	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.87~88 아. 해당 의료기관의 능력을 초과하는 경우	〈신설〉	○ 재난 시 이송되는 응급환자의 수가 해당 의료기관의 진료 능력을 초과하는 경우, 중앙응급의료센터(중앙응급의료상황실)에 연락을 통해 재난 현장에서 해당 응급의료기관으로 이송을 조정할 수 있도록 함 ○ 재난 시, 해당 의료기관으로 이송되어 응급처치를 시행한 환자 중에 해당 의료기관의 진료 능력을 초과하는 정도의 입원, 중환자실 입원, 수술이 필요한 환자로 판단되는 경우, 중앙응급의료센터(중앙응급의료상황실)에 연락을 통해 진료 가능 의료기관으로 이송이 필요한 환자가 발생하였음을 알리고 전원 조정을 받거나 직접 인근의 의료기관으로 전원 연락을 하며, 이송에 필요한 이송수단과 자원의 가용성을 파악하고 제공해야 함	▶ 문구 정비
p.88 차. 재난 후 복구	○ <u>결과보고서를 작성</u> ○ <u>24~72시간 내에 디브리핑을 시행할 수 있도록 조직함</u> ○ <u>병원 재고를 평가하는 팀을 조직하여 장비 등의 상태 등을 점검</u>	○ <u>재난 대응 이후 결과보고서를 작성하여 의료기관의 장에게 보고하고 관련 직원들에게 공유함</u> - <u>원내 규정으로 정한 시일 내에 재난 대응 사항에 대한 자체 평가를 실시하고, 결과보고서 작성 시 참고</u> 〈삭제〉 ○ <u>재난 대응 이후, 의료인력의 건강 상태(정신건강상태 포함)를 각 부서의 장이 확인하여 진료가 필요하거나 상담, 지지가 필요한 경우 이를 시행하며, 각 관리부서는 의료기관의약품, 의료소모품, 장비, 시설 등의 재고와 상태 등을 점검하고 필요 시 보충, 수리, 보수하며 의료기관의 장에게 보고하고 관련 직원들에게 공유함</u>	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.89 카. 병원 재난대응 지침의 핵심요소(Core) 자가 체크리스트	〈 본문 참조〉	〈 본문 참조〉	▶ 문구 정비
p.93~94 1. 재난응급의료 비상대응 매뉴얼 교육	〈신 설〉 ○ 대상 : 재난거점병원 DMAT 등 현장의료 활동인력 〈신 설〉 ○ 주요내용 〈본문 참조〉 ○ 교육·훈련 시간 : 매년 12시간 이상	○ 정의 : 보건복지부에서 주관하는 재난현장에서 응급의료 지원에 필요한 이론, 실습, 훈련 등에 대한 교육과정으로, 재난응급의료 비상대응매뉴얼에 기반한 한국형 재난의료 지원 교육(Korea Disaster Life Support, 이하 'KDLS')을 말함 ○ 대상 : 권역 DMAT/중앙 DMAT 등 현장응급의료 활동인력 및 보건소장 ○ 종류 : 기초과정*(KDLS-Basic, KDLS-Field), 전문과정**(KDLS-Advanced) 과정으로 구분되며, 그 외에도 강사과정(KDLS-Instructor), 보수과정(KDLS-Renewal)으로 구분함 * (연도별 기초과정 명칭) ('15~'17년, '24년~) KDLS-Basic, ('18~'23년) KDLS-Field ** (현행 전문과정) ('23년~) KDLS-Commander(현장응급 의료소장(보건소장) 과정) ○ 주요내용 〈본문 참조〉 ○ 교육·훈련 시간 : 기초과정의 경우 12시간 이상, 그 외에는 교육과정에 따라 상이함	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	○ 교육·훈련 수료기준 : 전 교육과정 이수(100%) 및 이론평가 60점 이상 득점 - 재난거점병원 DMAT 인력은 필수로 수료해야함 * DMAT 3개 팀을 모두 교육 수료자로 구성 할 수 없을 경우, 자체 비상대응매뉴얼 교육 후 DMAT 인력에 포함시키고, 당해 또는 다음해 실시되는 교육을 반드시 수료하도록 해야 함 〈신 설〉	○ 교육·훈련 수료기준 : 기초과정의 경우 전 교육과정 이수 (100%) 및 이론평가 60점 이상 득점시 수료, 그 외에는 과정별로 상이 - DMAT 활동을 위해서는 기초과정을 이수할 수 있도록 하며, 수료한 사람을 중심으로 출동할 수 있도록 함 - 기초과정 수료자의 경우 3년마다 보수과정에 참여할 수 있도록 함	
p.94 2. 지역 재난응급의료 비상대응 매뉴얼 교육	〈신 설〉	○ 정의: 재난응급의료 비상대응매뉴얼을 근거로 응급의료 지원센터나 재난거점병원에서 주관하는 교육과정	▶ 문구 정비
p.94~95 나. 소방 주관 훈련	○ DMAT과 신속대응반은 연1회 이상 해당 지역 '긴급구조 불시훈련' 또는 '긴급구조 종합훈련'에 참여해야 함 〈본문 참조〉	○ 권역 DMAT과 신속대응반은 연 1회 이상 '다수사상자 구급 대응훈련(또는 긴급구조 종합훈련)' 및 '다수사상자 불시 출동훈련'에 참여해야 함 〈본문 참조〉	▶ 문구 정비
p.95 다. 방사선 비상진료 교육 및 훈련	〈신 설〉	○ 방사선비상진료 신규·보수교육: 방사선비상진료 요원대상 ○ 방사능위기 공동대응과정: 군·경·소방·지자체·유관기관 대상 ○ 방사능위기 구급대응과정: 소방 구급대원·유관기관 대상	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
		○ <u>방사능 방재 훈련</u> 〈본문 참조〉	
p.99 X. 그 밖에 재난유형별 응급의료지 원에 필요한 사항	재난 관련 법률 〈본문 참조〉	특수재난 관련 법률 〈본문 참조〉	▶ 문구 정비
p.100 1. 화학재난	○ 화학 재난 대응에 관한 내용은 ‘ <u>유해화학물질 유출사고</u> <u>위기관리 표준매뉴얼(2020. 09)</u> 및 <u>유해화학물질 유출사고</u> <u>위기대응 실무매뉴얼(2020. 12)</u> ’을 따랐으며, 대응 시 ‘ <u>유해</u> <u>화학물질 유출사고 위기대응 실무매뉴얼</u> ’ 최신 개정판을 참고하여 대응함	○ 화학 재난 대응에 관한 내용은 ‘ <u>화학사고 위기관리 표준매뉴얼</u> (2021. 12) 및 <u>화학사고 위기대응 실무매뉴얼(2022. 5)</u> ’을 따랐으며, 대응 시 ‘ <u>화학사고 위기대응 실무매뉴얼</u> ’ 최신 개정판을 참고하여 대응함	▶ 문구 정비
p.100 가. 정의	- 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 일체의 <u>상황</u> 을 말함(화학 물질관리법 제2조)	- 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 <u>모든 상황</u> 을 말함(화학물질 관리법 제2조)	▶ 문구 정비
p.101 나. 화학재난 신고 및 상황전파 체계	- 소방(119소방본부), 경찰 등 → 화학물질안전원 → <u>환경청</u> , <u>합동방재센터</u> → 환경부 - 환경청, 합동방재센터 → 화학물질안전원 → 환경부 〈그림 14. 화학 재난 상황 전파〉	- 소방(119소방본부), 경찰 등 → 화학물질안전원 → <u>환경청</u> · <u>합동방재센터</u> → 환경부 - <u>환경청·합동방재센터</u> → 화학물질안전원 → 환경부 〈그림 삭제〉	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.101~103 다. 화학재난 지휘 및 대응체계 ~ 라. 화학재난 현장의료대응	<그림 15. 화학재난 지휘 및 대응체계> <그림 16. 화학 사고 대응 절차> <그림 17. 화학재난 대응지역>	<그림 18. 화학재난 지휘 및 대응체계> <그림 19. 화학 사고 대응 절차> <그림 20. 화학재난 대응지역>	▶ 그림 번호 변경
p.104 라. 화학재난 현장의료대응	방호복 종류: 미환경보호청 <본문 참조>	보호복 종류: 미 환경보호청 <본문 참조>	▶ 문구 정비
p.104~105 • 현장의료대응	<그림 신설> - 물질정보가 파악되어 대응수준을 알고 있거나 적절한 수준의 개인보호구 착용 전에는 오염 현장 활동에서 대응은 자제함 - 보호복을 착용하고 오염지역에 활동할 경우 활동시간을 총 30분 이상 초과하지 않고, 활동 중 화학사고로 인한 대원들이 노출되지 않도록 2차 오염방지에 힘씀 * 산소탱크(공기) 2시간~3시간 : 착·탈의 1시간 30분 - Hot zone은 군 인력 등 고도로 훈련된 전문가 그룹만 출입할 수 있으며, 환자 처치는 제한됨 - 제염이 끝난 환자는 Cold zone에서 의료진이 진료하고 레벨 D 수준의 근무복을 착용하면 됨 - 적절한 방호복을 갖추지 못했다면 현장대응은 하지 않는 것이 원칙임 <신 설>	<그림 21. 화학 사고에서의 생존 사슬> - 물질정보가 파악되어 대응 수준을 알고 있으며 적절한 수준의 개인보호구 착용 전에는 오염 현장 활동에서 대응은 금지함 - 높은 수준(level)의 보호복을 착용하고 오염지역에서 활동 시 활동시간은 총 30분을 초과하지 않도록 하고, 활동 중 화학사고에 대원들이 노출되지 않도록 2차 오염방지에 힘씀 - Hot zone은 화학 물질 식별 및 일차적인 구조가 집중되는 공간이며 현장 안전과 개인보호장비 착용의 한계로 환자 처치는 제한됨 - 제염/제독이 필요하다면 warm zone과 cold zone의 경계에서 시행하되 가급적 빨리 시행하여야 효과적임 <삭 제> 제염 / 제독 종류 화학물질 및 해독제 예시	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
p.106 • 방사선 비상	〈신설〉	방사선 비상 의 종류	▶ 비상 종류 신설
p.107 나. 방사선재난 신고 및 상황전파 체계	○ 의료인들이 방사능재난 또는 방사선 피해자가 의심되는 경우 국가방사선비상진료센터 24시간 응급전화로 신고 가능 (유선전화: 02-970-2300)	○ 의료인들이 방사능재난 또는 방사선 피해자가 의심되는 경우 국가방사선비상진료센터 24시간 응급전화로 신고 가능 (유선전화: 02-3399-5959)	▶ 문구 정비
p.109 • 방사선비상 진료기관	〈신설〉	방사선 비상진료기관별 역할	▶ 진료기관 역할 신설
p.110 • 현장응급의료 개요	〈신설〉	- 방사선 물질 관련 사고에 대해서는 방사선 비상진료체계를 우선 가동하고, 방사선 비상진료체계에 의한 대응 부족 시 출동 요청 - 현장 대응하는 모든 인력 및 의료기관에서 피폭된 환자에 대응하는 모든 인력은 피폭량 판독을 위해 개인선량계를 착용하여야 함. 개인선량계를 좌측 흉부에 착용하는 것이 권장됨	▶ 대응인력 보호원칙 신설
p.111~112 • 환자 흐름도에 따른 현장방사선 비상진료소 운영	〈신설〉	- 방사선학적 피해자의 분류 방법은 의학적 비오염 손상으로 인한 피해자 분류와 차이가 있음 〈그림27. 방사선학적 피해자의 오염 전 분류〉	▶ 중증도분류 신설

구분	현행	개정안	수정사유
p.112~113 • 현장응급 의료소에서 방사능 오염자 발견 시 조치 요령	〈신 설〉 - 방사선 계측장비를 보유하고 있는 현장에 파견된 관계기관 (군·경·소방·방사선비상진료기관 등)에 지원을 요청하여 오염검사 및 대응요원의 피폭 정도에 대한 평가 실시함 〈신 설〉	- 기본적으로 방사선비상진료기관은 오염환자에 대한 처치를 담당하며, 보건소와 응급의료기관에서 파견된 DMAT의 역할은 오염되지 않은 사상자에 대한 중증도분류·응급처치·이송임 - 대응요원의 피폭량을 감시하기 위한 개인선량계 및 방사능 대량 노출 시 오염 여부를 신속하게 판단하기 위한 이동식 외부오염감시기 및 표면오염감시기 활용이 필요함. 이를 위해 방사선 계측장비를 보유하고 있는 관계기관(군·경·소방·방사선비상진료기관 등)에게 관련 장비 지원 요청 - 현장의 제염/제독은 화학 재난시의 방법을 따름. 탈의 및 습식 제염으로 오염의 95% 이상을 감소시킬 수 있음 - 탈의 시 시트 3장을 사용하여 통나무 굴리기와 의복 재단을 이용하여 오염된 의복을 제거하고 탈의 후 전신 계측이 필요함. 습식 제염시에는 전신 제염 -> 방사선 파편 제거 -> 개방 상처 -> 신체개구부 -> 계측시 가장 오염도가 높은 피부 순으로 시행함 - 방사선학적 상해자의 주요 관찰 대상인 임상적 증상 및 징후는 구토, 오심, 설사, 홍반 또는 발적, 림프구수 분포 5가지임 - 대량 피폭 환자의 처치는 원자력의학원 혹은 방사선비상진료소와 상의가 필요함. 방사선 사상자의 증상 및 징후	▶ 문구 정비

구분	현행	개정안	수정사유
	- 방사선비상진료체계가 활성화되기 전 단계에서는 한국원자력 의학원 사고접수 응급전화(02-3399-5959)로 연락하여 후송병원 배정 요청함	- 방사선비상진료체계가 활성화되기 전 단계에서는 한국원 자력의학원 사고접수 응급전화(02-3399-5959)로 연락 하여 후송병원 배정 요청하며, 오염되지 않고 피폭만 된 환자는 특별한 절차 없이 이송하되 오염된 환자의 이송시에는 원자력의학원 혹은 방사선비상진료소와 상의가 필요함	
p.114 나. 감염병재난 신고 및 상황전파 체계	○ <u>위기징후 감시 및 전파</u>	○ <u>생물테러 감시 및 전파</u> 〈그림 28. 생물테러 감시체계와 운용〉	▶ 문구 정비
p.115	다. 감염병재난 지휘 및 대응체계	〈삭 제〉	
p.115 다. 감염병재난 의료대응	라. 감염병재난 의료대응 <u>〈신 설〉</u> - 초동대응요원은 2인 1조로 Level A급 착용 후 현장에 투입함 • Level A급 장비는 생물테러 감염병 오염 의심 장소 및 미확인 물체를 확인하기 위해 착용하는 최고 수준의 호흡기, 피부 등에 대한 보호 필요시 현장 투입 전 착용을 원칙으로 함 • Level C급 장비는 다중탐지키트 검사 결과에 따라 착용하며, 피부, 호흡기 모두 낮은 수준의 보호 필요시 현장 투입 전 착용을 원칙으로 함	라. 감염병재난 의료대응 ○ 생물테러감염병 발생 시 대응 - 소방에서 환경검체 채취 후, 3중용기에 밀봉하여 보건기관 (예. 보건환경연구원)에 전달 <u>〈삭 제〉</u>	▶ 문구 정비

구분	현 행	개 정 안	수정사유
p.116 • 신종감염병 및 대유행 감염병 개인보호장비 착용원칙	• 신종감염병 및 대유행 감염병 개인보호장비 착용원	• 신종감염병 및 대유행 감염병 개인보호장비 착용원칙	▶ 문구 정비
p.119~158 부록	본문참조	본문참조	▶ 문구 정비



I. 개요

1. 목적	3
2. 적용 범위	3
3. 근거법률 및 관계 법령	3
4. 용어 정의	4
5. 의료지원이 필요한 재난 등	6
6. 가행사 등 대규모 행사의 응급의료지원	7
7. 재난 등에서의 의료대응 단계	8

II. 기관별 역할과 지휘체계

1. 기관별 역할	11
가. 대비(평상시 역할): 사고 발생의 감시 및 재난 대응체계 대비 활동	11
나. 대응(재난 시 역할): 현장 출동, 현장의료, 재난의료체계 가동, 장기화대비	13
다. 대응단계별 기관별 주요 활동	15
2. 재난지휘체계	16
가. 국가재난대응체계	16
나. 재난 시 현장의료 지휘체계(현장응급의료소)	20
다. 신속대응반/재난의료지원팀(DMAT) 체계	20
라. 평시/재난 시 보고체계	21

III. 재난현장의 응급의료체계

1. 재난상황 접수 및 전파	25
2. 출동요청 및 출동	27
가. 출동대기	27
나. 출동기준	27
다. 출동요청	27
라. 출동	28



3. 선착팀(신속대응반, DMAT) 도착	29
가. 현장지휘체계의 확인 및 연계(C, Command & Control)	29
나. 현장 안전 확보(S, Safety)	30
다. 통신체계 구성(C, Communication)	30
라. 현장 의료수요 파악(A, Assessment)	31
마. 현장응급의료 시행장소 선정(P, Place)	31
바. 현장응급의료소 설치 요건	31
4. 후착팀 합류	32
5. 현장응급의료 활동	33
가. 현장응급의료소의 구성과 운영	34
나. 현장응급의료소 활동(3T)	34
다. 보건소	38
라. 시·도	38
마. 응급의료지원센터	39
6. 현장 응급의료지원 활동의 종료	39
7. 활동의 종료 후 조치사항	40
8. 기록	40
가. 현장기록	40
나. 결과보고서	41
9. 기타 현장 활동 시 주의사항	41
가. 인력	41
나. 의약품	41
다. 언론 대응	41

IV. 재난현장의 응급의료지원 인력의 구성 및 운영

1. 신속대응반	46
가. 보건소장	46
나. 출동 기준	46
다. 인원 구성	46
라. 복장	46



마. 운영	47
바. 출동 방법	47
사. 역할	47
아. 교육훈련	47
2. 권역 DMAT	48
가. 재난의료책임자	48
나. 출동 기준	48
다. 인원 구성	48
라. 복장	48
마. 운영	48
바. 출동 방법	49
사. 역할	49
아. 교육훈련	49
3. 중앙 DMAT	50
가. 출동 기준	50
나. 출동 인원	50
다. 복장	50
라. 운영	50
마. 교육훈련	50
바. 역할	51
4. 재난 등의 발생 시 응급의료지원	51

V. 재난현장의 응급의료지원 물품의 비축과 관리

1. 응급의료지원 물품의 정의	55
2. DMAT 물품	56
3. 현장응급의료소 물품	59
4. 응급의료지원 물품의 관리	59
가. 관리책임자	59
나. 보관	60



다. 불출	60
라. 점검	60
5. 신속대응반 물품 구성	61
6. 이동형 병원	62

VI. 재난현장의 응급의료지원 통신체계

1. 핫라인과 비상연락망 구축 및 점검	69
가. 핫라인 구성	69
나. 비상연락망	69
다. 핫라인 및 비상연락망 취합·점검	69
2. 상황접수 및 전파체계	70
3. 재난현장에서의 통신체계	71
가. 중앙응급의료상황실과의 통신체계	71
나. 현장 내 통신체계	72
다. 통신교육 및 대비	72

VII. 재난의료지원 활동 후 재난 심리지원 체계

1. 재난의료지원 활동 후 재난 심리지원 체계	75
2. 재난 정신건강 서비스 실행	77
3. 재난 시 대응	77
가. 재난 정신건강 서비스 지원 절차	77
나. 현장 대응	78
다. 재난 발생 후 회복	79

VIII. 재난 시 병원 원내 반응

1. 재난 등의 대비	83
2. 의료기관의 원외재난대응계획 수립	84
가. 재난대응지휘체계	84
나. 의사소통	85



다. 안전과 보안	86
라. 중증도 분류	86
마. 급증 환자 대응 능력	86
바. 주요 서비스의 지속 제공	87
사. 인력	87
아. 해당 의료기관의 능력을 초과하는 경우	87
자. 물류와 물자 관리	88
차. 재난 후 복구	88
카. [참고사항] 병원 재난대응 지침의 핵심요소(Core)	
자가 체크리스트	89

IX. 재난현장의 응급의료 지원에 대한 교육과 훈련

1. 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육	93
2. 지역 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육	94
3. 유관기관 교육 및 합동 훈련	94
가. 재난대응 안전한국훈련	94
나. 소방 주관 훈련	94
다. 방사선 비상진료 교육 및 훈련	95

X. 그 밖에 재난유형별 응급의료지원에 필요한 사항

1. 화학재난	100
가. 정의	100
나. 화학재난 신고 및 상황전파 체계	101
다. 화학재난 지휘 및 대응체계	101
라. 화학재난 현장의료대응	103
2. 방사선 재난	106
가. 정의	106
나. 방사선재난 신고 및 상황전파 체계	106
다. 방사선재난 지휘 및 대응체계	107
라. 방사선재난 현장의료대응	110



3. 감염병 재난	114
가. 정의	114
나. 감염병재난 신고 및 상황전파 체계	114
다. 감염병재난 의료대응	115

XI. 부록

1. 현장응급의료 인력의 복장	119
2. 현장 의료지원 가용인력의 사전 등록	120
3. 중증도분류표 서식	121
4. 병원별 수용능력표	122
5. 사상자 이송현황	123
6. 환자등록지(예시)	124
7. 신속대응반 활동보고서	125
8. DMAT 활동 보고서	129
9. 재난거점병원 시설·장비 현황	132
10. PS-LTE 사용방법(사이버텔브릿지)	138
11. PS-LTE 사용방법(블루버드)	145
12. 화학사고 대응기관 연락처	153
13. 방사선비상진료기관 연락처	154
14. 재난 대비·대응 활동 체크리스트	156

I 장

개요



1. 목적
2. 적용 범위
3. 근거법률 및 관계법령
4. 용어 정의
5. 의료지원이 필요한 재난 등
6. 국가행사 등 대규모 행사의 응급의료지원
7. 재난 등에서의 의료대응 단계

I

개요

1 목적

이 매뉴얼은 재난을 비롯한 다수사상자사고에 대비 또는 대응하여 사고가 발생한 때부터 현장에서 응급환자의 이송이 완료될 때까지의 현장 응급의료에 관한 기본적인 사항을 정하는 것을 목적으로 함

2 적용 범위

- 재난·다수사상자사고에 있어 현장 및 의료기관 등에서 응급의료의 제공에 관한 사항은 타 법규에 별도로 정하여지지 않는 한, 이 매뉴얼에 따름
- 이 매뉴얼은 재난·다수사상자사고의 예방·대비·대응·회복을 주관하거나, 이에 관여하는 모든 정부기관, 공공기관, 응급의료기관 및 구급차등의 운영자와 그 소속직원에 대하여 적용함
- 이 매뉴얼은 국내에서 발생한 사고에 대하여 적용하며, 해외재난에 대하여는 「해외긴급 구호에 관한 법률」과 동 법률에 근거한 별도의 매뉴얼에 따름

3 근거법률 및 관계 법령

- 근거법률
 - 「응급의료에 관한 법률」(이하 “응급의료법”이라 함) 제15조의2(비상대응매뉴얼), 같은 법 시행령 제8조의2(비상대응매뉴얼의 내용)
- 관계법령
 - 응급의료법 제18조(환자가 여러 명 발생한 경우의 조치), 제25조(중앙응급의료센터), 제26조(권역응급의료센터의 지정), 제27조(응급의료지원센터의 설치 및 운영), 같은 법 시행령 제8조의3(비상대응매뉴얼의 교육 등), 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치), 제10조(다수의 환자발생에 대한 조치계획의 수립)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- 「재난 및 안전관리 기본법」(이하 “재난안전법”이라 함) 제3조(정의), 제49조(중앙긴급구조통제단), 제50조(지역긴급구조통제단), 제51조(긴급구조), 제52조(긴급구조현장지휘), 제55조(재난대비능력 보강)
- 「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」(이하 “긴급구조현장지휘규칙”이라 함) 제20조에서 제25조(제5장 현장응급의료소의 설치·운영)

4 용어 정의

- “재난 등”이란 “재난”과 재난으로 선포되지 않은 “다수사상자사고”를 말함
- “재난”이란 재난안전법 제3조제1호 및 제2호에 따른 재난을 말함

재난의 정의(재난안전법 제3조 및 같은 법 시행령 제2조)

- “재난”이란 국민의 생명·신체·재산과 국가에 피해를 주거나 줄 수 있는 사건으로서
 - 1) 자연재난: 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 낙뢰, 가뭄, 폭염, 지진, 황사, 조류 대발생, 조수, 화산활동, 소행성·유성체 등 자연우주물체의 추락·충돌, 그 밖에 이에 준하는 자연현상으로 인하여 발생하는 재해
 - 2) 사회재난: 화재·붕괴·폭발·교통사고(항공사고 및 해상사고를 포함한다)·화생방사고·환경오염 사고 등으로 인하여 발생하는 광범위한 피해(국가 또는 지방자치단체 차원의 대처가 필요한 인명·재산의 피해, 그 밖에 행정안전부장관이 재난관리를 위해 필요하다고 인정하는 피해)와 국가핵심기반의 마비, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 또는 「가축전염병 예방법」에 따른 가축전염병의 확산, 「미세먼지 저감 및 관리에 관한 특별법」에 따른 미세먼지 등으로 인한 피해를 말함

- “다수사상자사고(Mass Casualty Incident, MCI)”란 동시에 다수의 사상자가 발생하였거나, 추가로 사상자가 발생할 우려가 있어 응급의료의 제공을 위해 별도의 의료자원 동원 등의 조치가 필요한 사건·사고를 말함
- “재난관리책임기관”이란 재난관리업무를 하는 다음 기관을 말함
 - 중앙행정기관 및 지방자치단체
 - 지방행정기관·공공기관·공공단체 및 재난관리의 대상이 되는 중요시설의 관리기관 등으로서 대통령령으로 정하는 기관(재난안전법 시행령 [별표 1의2])
- “재난관리주관기관”이란 재난이나 그 밖의 각종 사고에 대하여 그 유형별로 예방·대비·대응 및 복구 등의 업무를 주관하여 수행하도록 대통령령으로 정하는 관계 중앙행정기관을 말함(재난안전법 시행령 [별표1의3])

- “긴급구조”란 재난이 발생할 우려가 현저하거나 재난이 발생하였을 때에 국민의 생명·신체 및 재산을 보호하기 위하여 긴급구조기관과 긴급구조지원기관이 하는 인명구조, 응급처치, 그 밖에 필요한 모든 긴급한 조치를 말함
- “긴급구조기관”이란 소방청·소방본부 및 소방서를 말하며, 해양에서 발생한 재난의 경우에는 해양경찰청·지방해양경찰청 및 해양경찰서를 말함
- “긴급구조지원기관”이란 긴급구조에 필요한 인력·시설 및 장비, 운영체제 등 긴급구조 능력을 보유한 기관이나 단체로서 대통령령으로 정하는 기관과 단체를 말함(재난안전법 시행령 제4조, 재난안전법 시행규칙 [별표1])
- “중앙응급의료상황실”이란 응급의료법 제25조에 따라 재난 등의 발생 시 응급의료 관련 업무의 조정과 지원을 위해 중앙응급의료센터 내에 설치·운영하고 있는 상황실을 말함
- “현장응급의료소”란 긴급구조현장지휘규칙 제20조에 따라 재난현장에 출동한 응급의료 관련자원을 총괄·지휘·조정·통제하고, 사상자를 분류·처치·이송하기 위해 재난현장에 설치하는 의료소를 말함
- “임시의료소”란 의료소장(또는 신속대응반, DMAT)이 재난현장에 도착하여 현장응급 의료소를 운영하기 전까지 소방공무원이 운영하는 의료소를 말함(긴급구조현장지휘 규칙 제20조제10항)
- “구급지휘팀”이란 다수사상자 발생 재난 응급의료 현장을 지휘·조정·통제하고, 구급활동 등을 지원하기 위한 팀을 말함
- “신속대응반”이란 재난 등의 발생 시 신속한 현장의료대응을 위해 보건소장이 평시에 구성하여 재난 시 운영하는 현장 활동팀을 말함
- “재난거점병원”이란 재난 등의 발생 시 현장에 재난의료지원팀 파견이 가능하고 다수의 환자 수용이 가능하도록 예비병상·전문인력·재난의료지원물품 등이 준비된 의료기관으로서 보건복지부장관이 정하는 기관을 말함
 - “권역재난의료책임자”(이하 “재난의료책임자”)란 재난거점병원에서 권역 내 재난의료 관련 업무를 총괄하는 병원 내 책임자를 말함
 - “재난의료관리자”란 응급의료지원센터 직원으로 권역 내 재난의료관리 업무를 조정·관리하는 재난의료전담인력을 말함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- “재난의료지원팀”(Disaster Medical Assistance Team:이하 ‘DMAT’)이란 재난 등의 발생 시 의료지원을 위하여 사전 또는 사후에 조직된 의료팀을 말함
- “재난의료지원차량”이란 현장응급의료소 설치에 필요한 천막(텐트), 장비, 의료장비, 의료소모품 등을 이송할 수 있도록 재난거점병원에 배치된 차량을 말함
- “재난의료 핫라인”이란 재난 등의 발생 시 신속한 전파와 의사소통을 위한 전국의 관계기관 간의 상호 연락처를 말함
- “재난안전통신망”(Public Safety - Long Term Evolution:이하 ‘PS-LTE’)이란 재난관리책임기관·긴급구조기관 및 긴급구조지원기관이 재난 및 안전관리업무에 이용하거나 재난현장에서의 통합지휘에 활용하기 위하여 구축·운영하는 통신망을 말함
- “모바일상황실”이란 재난 등의 발생시 사고정보와 사상자 발생 현황 등 관련 정보를 관계기관(보건복지부, 지자체, 보건소, 응급의료기관, 중앙응급의료센터, 응급의료지원센터 등)과 공유하기 위하여 만들어진 단체 대화방을 말함

5 의료지원이 필요한 재난 등

- 모든 재난에 의료대응이 필요하지는 않으며, 재난으로 선포되지 않은 다수사상자사고에서도 의료대응이 필요할 수 있음
- 재난관리에는 예방·대비·대응 및 복구가 포함되며, 이 매뉴얼은 대비와 대응 단계의 의료지원에 관한 사항을 포함함
- 재난의료대응수준은 재난의 유형과 규모에 따라 다르며, 초기 대응수준은 중앙응급의료상황실이 재난관리주관기관 혹은 재난관리책임기관과 협의하여 결정하고, 이후에는 재난 등의 진행에 따라 보건소장, 시·도 및 보건복지부가 지속적으로 결정
- 보건복지부장관, 시·도지사, 시장·군수·구청장은 재난 등의 발생 시 응급의료종사자에게 응급의료 업무에 종사할 것을 명하거나, 의료기관의 장 또는 구급차등을 운용하는 자에게 의료시설을 제공하거나 응급환자 이송 등의 업무에 종사할 것을 명할 수 있음
- 응급의료종사자, 의료기관의 장 및 구급차등을 운용하는 자는 정당한 사유가 없으면 이를 거부할 수 없음

환자가 여러 명 발생한 경우의 조치(응급의료법 및 같은 법 시행령)

- 응급의료에 관한 법률 제18조(환자가 여러 명 발생한 경우의 조치)
 - ① 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)은 재해 등으로 환자가 여러 명 발생한 경우에는 응급의료종사자에게 응급의료 업무에 종사할 것을 명하거나, 의료기관의 장 또는 구급차등을 운영하는 자에게 의료시설을 제공하거나 응급환자 이송 등의 업무에 종사할 것을 명할 수 있으며, 중앙행정기관의 장 또는 관계 기관의 장에게 협조를 요청할 수 있다.
 - ② 응급의료종사자, 의료기관의 장 및 구급차등을 운영하는 자는 정당한 사유가 없으면 제1항에 따른 명령을 거부할 수 없다.
 - ③ 환자가 여러 명 발생하였을 때 인명구조 및 응급처치 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.
- 응급의료에 관한 법률 시행령 제9조(다수의 환자발생에 대한 인명구조 및 응급처치)
 - ① 보건복지부장관 또는 시·도지사는 재해 등으로 환자가 여러 명 발생한 경우에는 법 제18조에 따라 응급의료기관 및 관계기관에 대한 지휘체계를 확립하고 그 사상자의 규모, 피해지역의 범위, 사고의 종류 및 추가적인 사고발생의 위험도 등을 고려하여 신속하고 적절한 인명구조 및 응급처치가 될 수 있도록 해야 한다.
 - ② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장(자치구 구청장을 말한다. 이하 같다)은 다수의 환자가 발생한 사실을 알게 되거나 보고를 받은 때에는 지체없이 보건복지부장관에게 이를 보고하여야 한다.
 - ③ 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다수의 환자가 발생한 때에는 사고 발생일부터 사고수습 종료일까지 매일 1일 활동상황을 보건복지부장관에게 보고하여야 하며, 사고수습이 종료된 경우에는 지체없이 종합보고를 하여야 한다.
- 응급의료에 관한 법률 시행령 제10조(다수의 환자발생에 대한 조치계획의 수립)
 - ① 법 제18조제3항의 규정에 따라 보건복지부장관 또는 시·도지사는 다수의 환자발생에 대비하여 환자발생의 원인 및 규모에 따른 적절한 조치계획을 미리 수립하여야 한다.
 - ② 제1항의 조치계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
 - 1. 응급의료 인력·장비 및 시설의 편성과 활용
 - 2. 관계기관의 협조체계 구축
 - 3. 응급의료활동훈련

6 국가행사 등 대규모 행사의 응급의료지원

- 대규모 인명피해 발생 가능성이 있는 국가행사 등 대규모 행사 시에는 보건복지부 또는 시·도지사가 해당 지자체 및 응급의료기관에 응급의료지원을 요청할 수 있으며, 지원 규모 및 형태는 행사 규모에 따라 보건복지부 또는 시·도지사가 결정함

7 재난 등에서의 의료대응 단계

구 분	판단 기준	비고
관심 (Blue)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수사상자 발생 가능성이 있는 경우 2. 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상	징후활동 감시
주의 (Yellow)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 다수의 사상자가 이미 발생한 경우 2. 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상	능동감시 경고전파
경 계 (Orange)	1. 소방 대응 1단계 이상으로 10명 이상의 사상자가 이미 발생하고 추가 사상자 발생 위험이 현저하게 높아 의료대응 개시가 필요한 주의 (Yellow)단계 해당 상황/사건 2. 다수의 중증환자가 이미 발생하였거나 5명 이상의 중증환자 발생 가능성이 현저히 높으며 상황이 장기화될 우려가 있어 현장에서 초기 의료대응이 중점적으로 필요한 경우 3. 다수사상자사고에서 재난관리주관기관 및 재난관리책임기관의 의료대응 요청	의료대응 개 시
심각 (Red)	1. 일상적인 응급의료서비스로는 대응할 수 없는 명백한 재난 등	의료대응 확 대

(관심 2.) 다수사상자 발생 가능성이 있는 사고/현상의 예시는 다음과 같다.

- 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해의 진행
- 군중 운집(mass gathering) 행사 등의 개최

(주의 2.) 다수사상자 발생으로의 전개가 예측되는 사고/현상의 예시는 다음과 같다.

- 해당 시간의 예측 수용인구수가 20명 이상인 다중이용시설의 화재, 붕괴, 침수 등
- 다중교통사고, 군중 운집 행사에서의 사상자 발생
- 태풍, 홍수, 지진, 해일 등 자연재해에서 사상자 발생
- 화학물질의 누출, 방사선 시설에서의 사고 등으로 인구집단의 노출 확인
- 국지전/테러 발생으로 사상자 발생
- 운항/운행 중인 여객선박, 여객항공기, 여객열차 및 대형승합차의 추락, 침몰, 탈선 및 전복 등의 확인

II 장

기관별 역할과 지휘체계



1. 기관별 역할
2. 재난지휘체계

II

기관별 역할과 지휘체계

1 기관별 역할

가. 대비(평상시 역할): 사고 발생의 감시 및 재난 대응체계 대비 활동

구분	대비활동
보건복지부	• 재난의료 총괄 계획 및 운영 • 비상대응매뉴얼 제작 배포, 교육 훈련 계획 수립 • 재난 등의 발생 시 응급의료지원 계획 수립 및 시행 • 재난의료대비를 위한 지원 및 조정 • 재난의료자원의 조정 및 배치 • 유관기관 협력체계 유지 및 조율
중앙응급의료센터 (국립중앙의료원)	• 보건복지부 산하 실무 활동 • 중앙응급의료상황실 24시간 운영 - 24시간 재난상황 감시(재난상황 수신 및 확인) - 전국 재난의료 핫라인 구축 및 관리 - 재난의료 대응자원정보의 실시간 감시 - 모바일 상황실 운영 • 중앙 DMAT 조직·운영 • 권역 DMAT 운영 관리·지원 • 재난의료교육훈련 프로그램 개발 및 시행 • 재난의료지원 물품 비축 및 관리 • 국가행사 응급의료 지원 • 시도별 재난의료관리업무의 지원(응급의료지원센터) - 재난거점병원의 재난교육, 훈련, 정보관리 업무 지원 - 재난의료 핫라인 구축 및 관리 - 응급의료종사자에 대한 재난 교육, 훈련 지원 - 재난의료대비를 위한 업무 및 질 향상 활동 지원 • 기타 재난의료대응에 필요한 지원
시·도	• 재난 등의 발생 시 응급의료지원 계획 수립 및 시행 • 관계기관(경찰서, 군부대 등)간 협조체계 유지

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

구분	대비활동
	• 재난의료 핫라인 및 비상연락망* 구성 및 점검 • 재난대응자원(인력, 시설, 장비 등) 현황 파악 • 지역 비상대응매뉴얼 제작 및 배포, 교육·훈련 계획 수립 • 필요 시 지역 DMAT 운영 • 지역 내 재난의료 자원의 조정·배치 • 다수환자 발생 대비 조치계획 수립·운영
시·군·구 (보건소)	• 관계기관(경찰서, 소방서, 해양경찰서, 군부대 등)간 협조체계 유지 • 재난의료 핫라인 및 비상연락망* 구성 및 점검 • 재난대응자원(인력, 시설, 장비 등) 현황파악 • 신속대응반 구성 및 출동체계 유지 • 신속대응반 구성원의 교육·훈련 참가
소방	• 119 종합상황실을 통한 통합감시체계 운영 - 24시간 재난상황 감시 - 재난 핫라인 운영, 상황 전파(중앙응급의료센터 중앙응급의료상황실) - 신속대응반 및 DMAT 출동 요청 등 중앙응급의료센터와의 협조체계 유지 • 재난 대비 긴급구조대응 계획 수립 및 시행 • 긴급구조통제단 운영 • 교육·훈련 시행 - 재난 대비 긴급종합구조훈련 시행 - 관계기관 합동 재난훈련 - 임시의료소 및 현장응급의료소 설치·운영 훈련 • 재난대응자원(인력, 시설, 장비 등) 관리, 운영
권역응급의료센터 (재난거점병원)	• 재난의료책임자의 지정 • DMAT 구성·운영 및 출동체계 유지 • 원내 재난 의료대응계획 수립 및 비상연락망* 관리 • 권역 내 재난교육 및 훈련 - 원내 및 원외 재난 대응 교육, 훈련 - 응급의료기관, 소방, 시·도, 보건소 등의 관계기관 교육, 훈련 • 권역 내 재난의료대응자원 관련 정보 수집 및 보고 • 재난의료지원 시설·장비 및 물품 관리 • 응급의료기관의 활동
응급의료기관 및 응급실 운영기관	• 재난의료핫라인의 운영 및 관련 정보 제공 • 병원 내 재난대응체계 유지(병원 내 재난대응계획 수립, 비상연락망 관리 등) • 필요 시 지역 DMAT 구성 운영 • 관할 지역 내 재난의료 교육·훈련 참여
민간이송업	• 재난의료핫라인의 운영 및 관련 정보 제공(보건소/응급의료지원센터에 보고)

* 비상연락망은 기관 내 비상 연락체계를 말함

나. 대응(재난 시 역할): 현장 출동, 현장의료, 재난의료체계가동, 장기화대비

구분	대응활동
보건복지부	• 국가단위 재난의료지원 총괄 - 재난 발생현황 종합, 필요한 의료지원 규모 결정 등 • 부처 및 유관기관 간 협력 • 재난상황의 장기화 가능성 대비 • 재난의료자원의 조정 및 배치(예비병상 가동 포함)
중앙응급의료센터 (국립중앙의료원)	• 중앙응급의료상황실 24시간 운영 - 초기 대응수준 결정, 상황전파 및 대응의 유도 - 관계기관 핫라인 가동, 대응 조치 확인 - 실시간 응급의료자원정보의 수집 및 제공 - 전국 재난의료 핫라인 구축 및 관리 - 재난의료 대응자원정보의 실시간 감시 • 재난의료물자의 지원 • 필요 시 중앙 DMAT 파견 • 지역 내 재난응급의료 관련 업무의 조정 및 지원(응급의료지원센터) - 재난 등 발생 시 현장 출동 및 현장의료에 관한 신속대응반, DMAT 업무 지원
시·도	• 시·도 비상진료대응반 구성·운영(의약품, 혈액 등의 수급·지원, 인근 시·군·구 간 부상자 이송·치료 조정, 영안실 마련) • 지역 DMAT 파견 결정 • 시·군·구간 사상자 이송, 치료 조정 • 기타 재난의료 전반적 지원
시·군·구 (보건소)	• 의료기관 간 부상자 이송·치료 조정 • 사망자의 관리 • 신속대응반 출동 • 현장응급의료소 운영 • 사상자 현황 정보 수집 및 관리
소방	• 신속한 상황 보고 및 전파 • 초기대응 및 긴급구조통제단 운영 • 현장지휘소, 임시의료소 설치 운영 • 신속대응반, DMAT 도착 시 현장응급의료소 합류·운영 • 재난대응 자원(인력, 장비, 시설) 동원 • 특수재난의 경우 재난 대응 자원 지원 • 필요 시 관계기관 지원요청 • 필요 시 항공구조구급대 동원 • 현장 긴급구조활동 시행

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

구분	대응활동
권역응급의료센터 (재난거점병원)	• 재난현장의료(DMAT 파견) • 중증응급환자를 중심으로 진료 제공 및 환자 수용 • 재난 발생 시 여유병상 확보 및 병상정보, 환자현황 등 실시간 정보 제공 • 재난 등의 상황 장기화 준비(인력, 물품 등) • 기타 응급의료기관의 역할 • 필요 시, 원내 재난대책본부 혹은 부서 가동
응급의료기관 및 응급실 운영기관	• 재난 시 여유병상 확보 및 병상정보, 환자현황 등 실시간 정보의 제공 • 재난 시 부상자의 진료 • 요청 시 구급차, 응급의료전용헬기 등 이송수단 출동 • 현장 의료지원 요청 시 의료인력 파견(지역 DMAT 등) • 의료기관 자체의 피해(환자안전, 직원안전, 시설 및 설비) 확인 및 이상 시 중앙응급의료상황실로 보고(핫라인) • 필요 시 원내 재난대책본부 혹은 부서 가동
민간이송업	• 요청 시 구급차 출동 • 현장응급의료소의 지시에 따른 이송 및 결과 보고

다. 대응단계별 기관별 주요 활동

구 분	중앙응급의료센터	보건소	DMAT	응급의료기관	이송업체
관심 (Blue)	• 상황감시 • 지역별 응급의료 자원확인	• 핫라인·비상 연락망 확인	• 핫라인·비상 연락망 확인	• 핫라인·비상 연락망 확인	• 핫라인·비상 연락망 확인
주의 (Yellow)	• 인근기관 상황 전파 • 출동대기 요청 • 주기적 상황감시	• 필요시 출동대기 • 비상연락망 가동	• 필요시 출동대기 • 비상연락망 가동	• 비상연락망 가동	• 비상연락망 가동
경 계 (Orange)	• 대응요청 • 현장출동요청 • 실시간 응급자원 정보수집/제공 • 인근병원 수용 대비 요청 • 사상자 추적 • 조치사항통보 • 대응 정보 수집 및 공유 • (필요 시) 응급의료지원 센터 현장출동	• 신속대응반 출동 • 비상소집 • 사상자 현황 조사 • 조치사항 보고	• 출동 • 본진 소집 • 조치사항 보고	• 원내대응 개시 • 비상소집 • 수용환자 보고 • 피해상황 현황 보고	• 출동대기
심각 (Red)	• 상황실 확대 편성 • 실시간 응급자원 정보수집/제공 • 사상자 추적 • 조치사항 통보 • 필요 시 추가 자원 동원 • 필요 시 중앙 DMAT 파견 • 인근지역 지원 확보 • 물품 지원	• 현장응급의료소 운영 • 현장지휘소 연락 체계 유지 • 비상근무체계 돌입 • 필요 시 지원 요청 • 사상자 현황 조사 지속 • 조치사항 보고	• 현장의료 • 본진 출동 • 필요 시 지원 요청 • 조치사항 보고	• 비상근무체계 돌입 • 수용환자 현황 보고 지속	• 사상자 이송 • 조치사항 보고

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

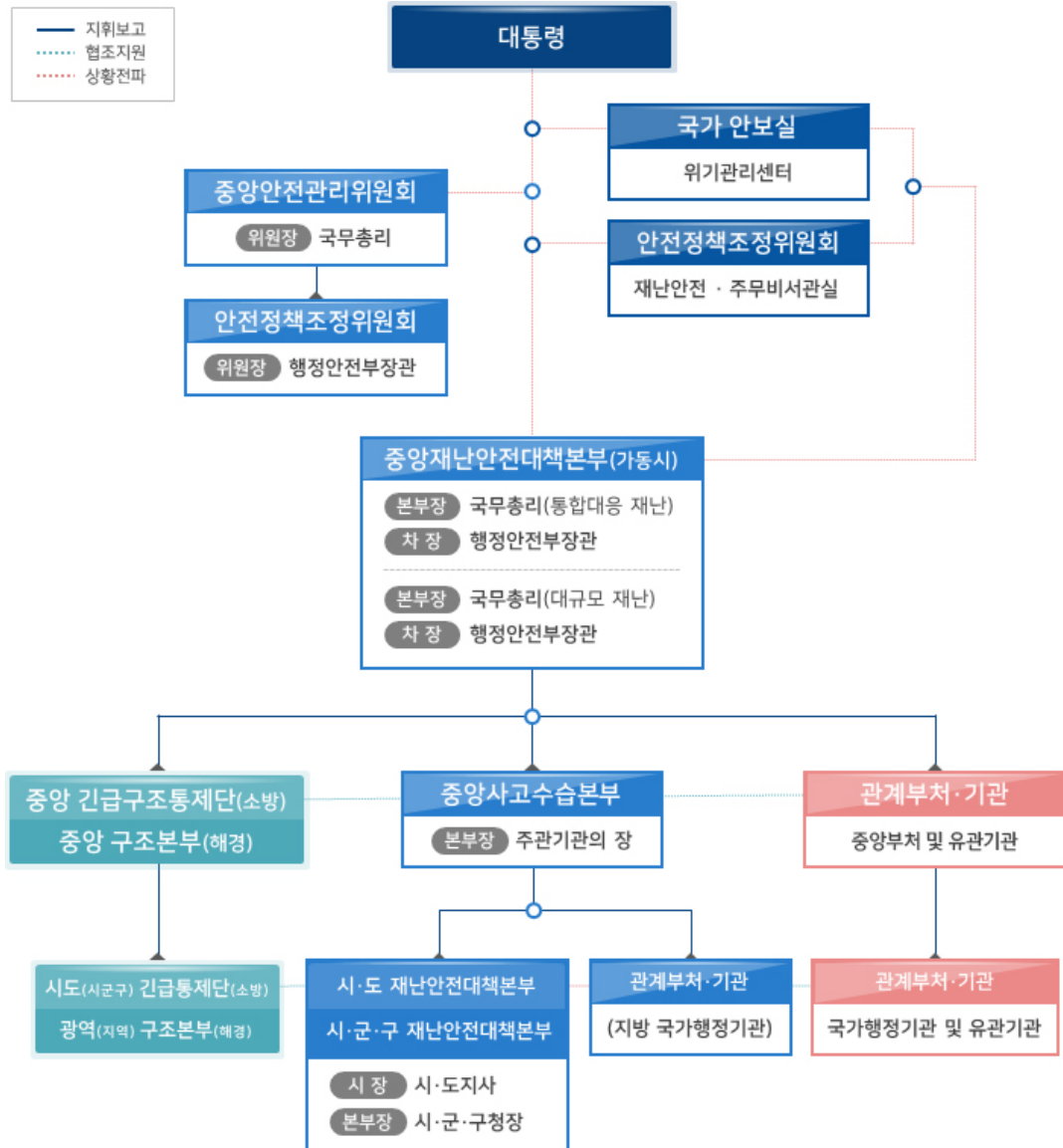
IX

X

XI

2 재난지휘체계

가. 국가재난대응체계



〈그림 1. 국가재난관리 체계도〉

구분	내용
중앙안전관리위원회	• 재난 및 안전관리에 관한 중요 정책에 관한 사항 심의·총괄 - 국가안전관리기본계획 및 집행계획 심의 - 재난사태 및 특별재난지역 선포 심의 - 중앙행정기관 간 재난 및 안전관리 업무 협의·조정 - 국가안전보장 관련 사안 협의
지역안전관리위원회	• 지역별 재난 및 안전관리에 관한 사항을 심의·조정 - 시·도지사 소속으로 시·도 안전관리위원회 - 시장·군수·구청장 소속으로 시·군·구 안전관리위원회
중앙재난안전대책본부	• 대규모 재난의 대응·복구(이하 수습) 등에 관한 사항을 총괄·조정 - 중앙재난안전대책본부장은 대규모 재난이 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우에는 실무반을 편성하고, 중앙재난안전대책본부상황실을 설치하는 등 해당 대규모 재난에 대하여 효율적으로 대응하기 위한 체계를 갖추어야 함 * 단, 해외재난의 경우에는 외교부장관이, 방사능재난의 경우에는 중앙방사능방재대책본부의 장이 각각 중앙대책본부장의 권한을 행사함 * 국무총리가 본부장인 경우, 국무총리가 필요하다고 인정하여 지명하는 중앙행정기관의 장은 행정안전부 장관, 외교부 장관(해외 재난의 경우에 한정), 중앙방사능방재대책본부장(방사능 재난의 경우에 한정)과 공동으로 차장이 될 수 있음
지역재난안전대책본부	• 관할 구역 내 재난의 수습 등에 관한 사항을 총괄·조정 - 재난현장의 총괄·조정 및 사고수습체계 구축 - 수습·복구의 종합적인 대응방안 강구 - 지역 내 재난관리책임기관의 장에게 행정·재정상의 조치 및 업무협조 요청
중앙 및 지역 사고수습본부	• 주관기관의 장 소속하에 설치 • 중앙재난안전대책본부의 사고수습 지원 및 협조 - 중앙수습지원단 구성·파견 협조 • 재난정보의 수집·전파, 상황관리, 재난발생 시 초동조치 및 지휘 등을 위한 수습본부 상황실을 설치·운영 • 중앙사고수습본부장은 지역사고수습본부를 운영할 수 있으며, 지역사고수습본부의 장은 중앙사고수습본부장이 지명함
중앙긴급구조통제단	• 긴급구조에 관한 사항의 총괄·조정, 기관 간 역할분담 및 지휘통제 등 - 국가 긴급구조대책의 총괄·조정 및 지휘·통제 - 기관 간 역할 분담 등 현장 활동계획의 수립·진행
지역긴급구조통제단	• 지역 긴급구조에 관한 사항 총괄·조정, 기관 간 역할 분담 및 지휘통제 등 - 지역 긴급구조대책의 총괄·조정 및 지휘·통제 - 지역 기관 간 역할 분담 등 현장 활동계획의 수립·진행

I

II

III

IV

V

VI

VII

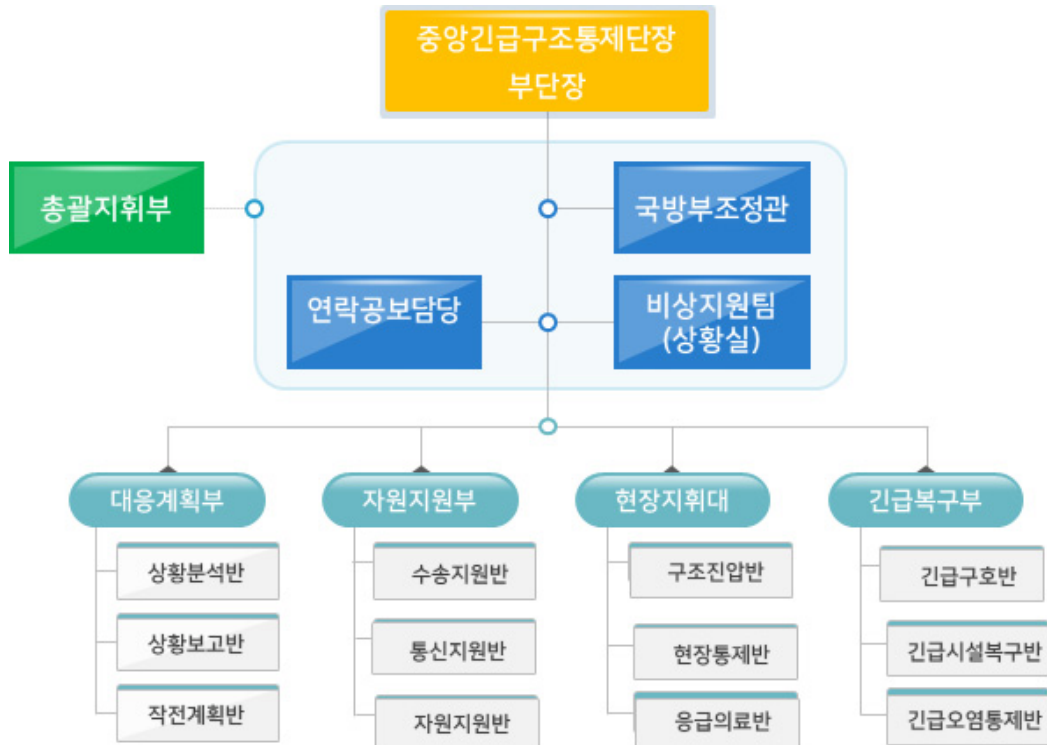
VIII

IX

X

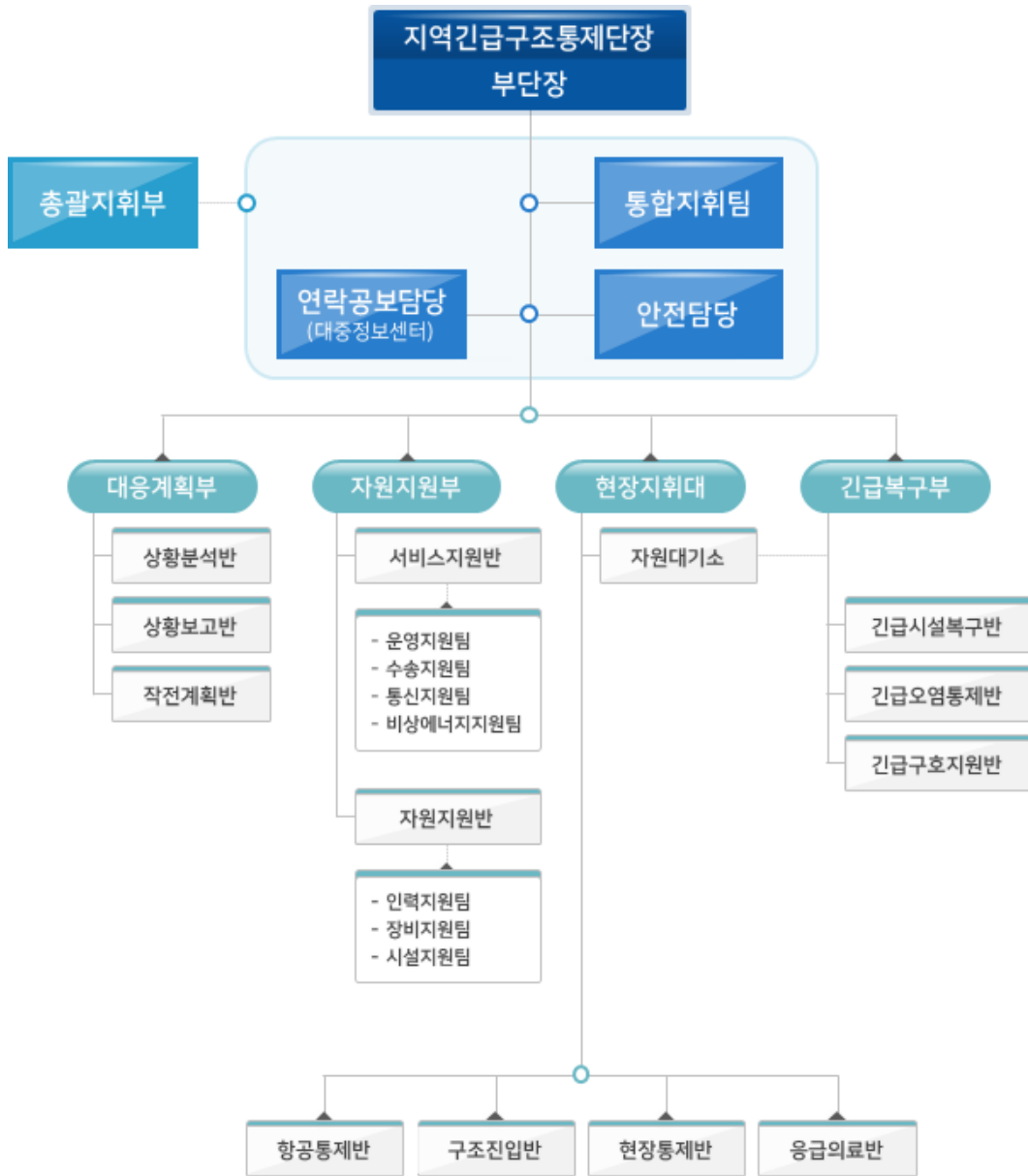
XI

• 중앙긴급구조통제단의 구성



〈그림 2. 중앙긴급구조통제단 조직도〉

- 지역긴급구조통제단의 구성



〈그림 3. 지역긴급구조통제단 조직도〉

나. 재난 시 현장의료 지휘체계(현장응급의료소)

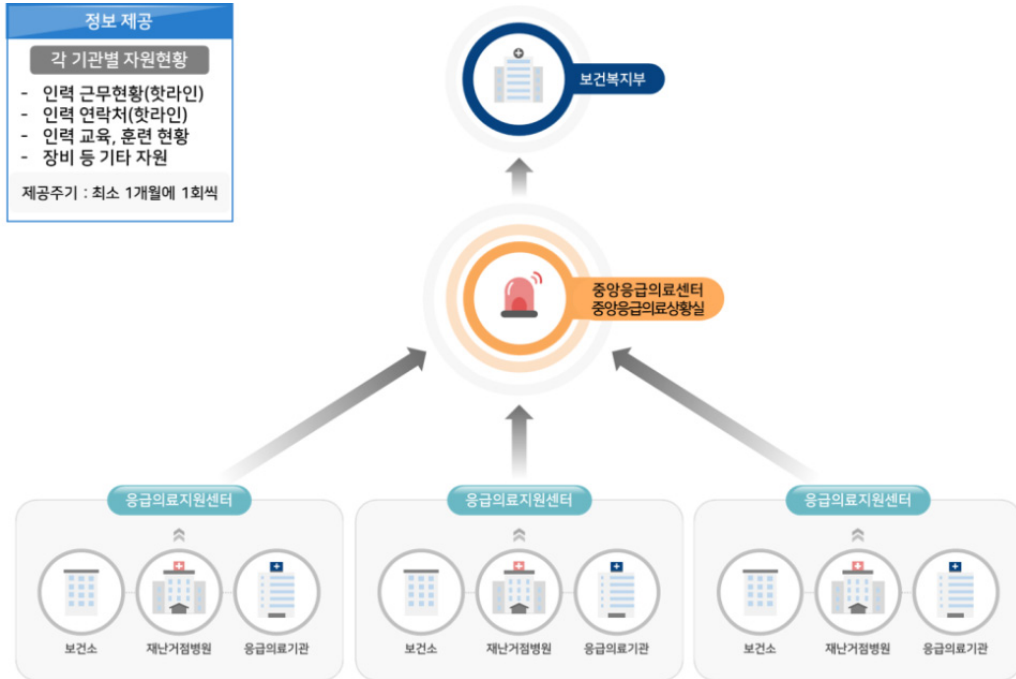
- 육상·내수면·해수면 상황에 따른 현장지휘체계
 - 육상·내수면 재난 등의 발생 시 긴급구조통제단(소방) 지휘
 - 해수면 재난 등의 발생 시 구조본부(해경) 지휘
- 긴급구조통제단장은 재난현장에 출동한 응급의료관련자원을 총괄·지휘·조정·통제하고, 사상자를 분류, 처치 또는 이송하기 위하여 사상자의 수에 따라 재난현장에 적정한 현장응급의료소를 설치·운영하여야 하며, 이를 위해 종합병원과 응급의료기관에 응급의료기구의 지원과 의료인 등의 파견을 요청할 수 있음
- 현장응급의료소장은 보건소장이며, 관할 보건소장 도착 전에는 권역응급의료센터장, 응급의료지원센터장, 지역응급의료센터장이 역할을 대신할 수 있음
- 위 각 기관장의 역할은 기관장의 권한과 책임을 위임받은 해당 기관의 소속 직원이 대신할 수 있음
- 현장응급의료소에는 소장 1명과 분류반, 응급처치반, 이송반, 운영지원반을 두며, 현장응급의료소장은 긴급구조통제단장의 지휘를 받아 의료소의 운영 전반에 관하여 지휘·감독함

다. 신속대응반/재난의료지원팀(DMAT) 체계

- 신속대응반 : 보건소에서 구성하는 현장 활동팀으로 중앙응급의료상황실에서 출동 요청하며, 지자체, 소방에서도 출동 요청 가능함
- 중앙 DMAT : 국가 단위에서 조직된 DMAT으로 보건복지부 및 중앙응급의료센터가 출동 결정함
- 권역 DMAT : 특정 지역 단위에서 조직된 DMAT으로 중앙응급의료상황실에서 출동 요청함
- 지역 DMAT : 재난거점병원 외 응급의료기관 등에서 운영하는 DMAT으로 필요 시 시·도나 의료기관에서 자체로 구성할 수 있음

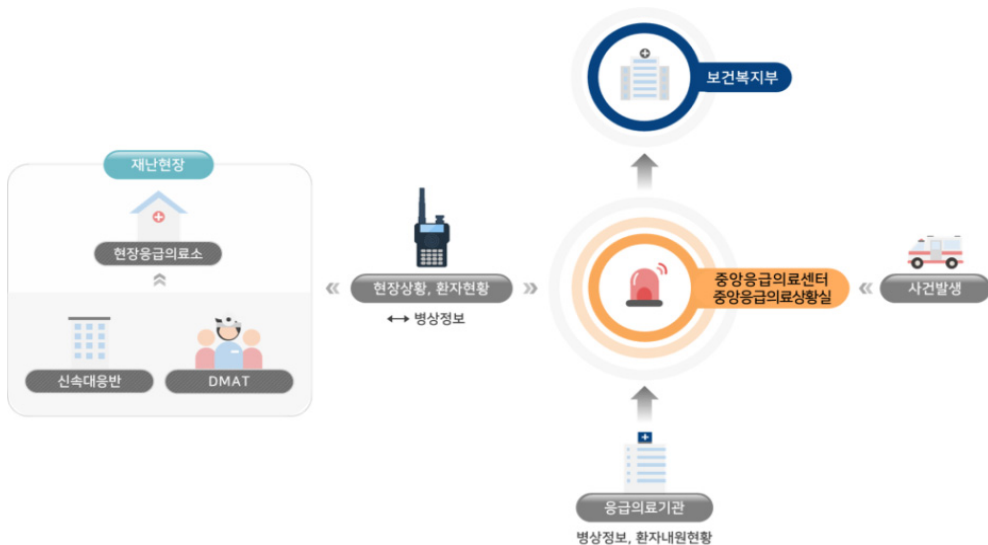
라. 평시/재난 시 보고체계

- 평상시 재난 대비 보고체계



〈그림 4. 평상시 재난 대비 보고체계〉

- 재난 시 보고체계



〈그림 5. 재난 시 보고체계〉



보건복지부

Ministry of Health and Welfare

III 장

재난현장의 응급의료체계



1. 재난상황 접수 및 전파
2. 출동요청 및 출동
3. 신착팀(신속대응반, DMAT) 도착
4. 후착팀 합류
5. 현장응급의료 활동
6. 현장 응급의료지원 활동의 종료
7. 활동의 종료 후 조치사항
8. 기록
9. 기타 현장활동 시 주의사항

III

재난현장의 응급의료체계

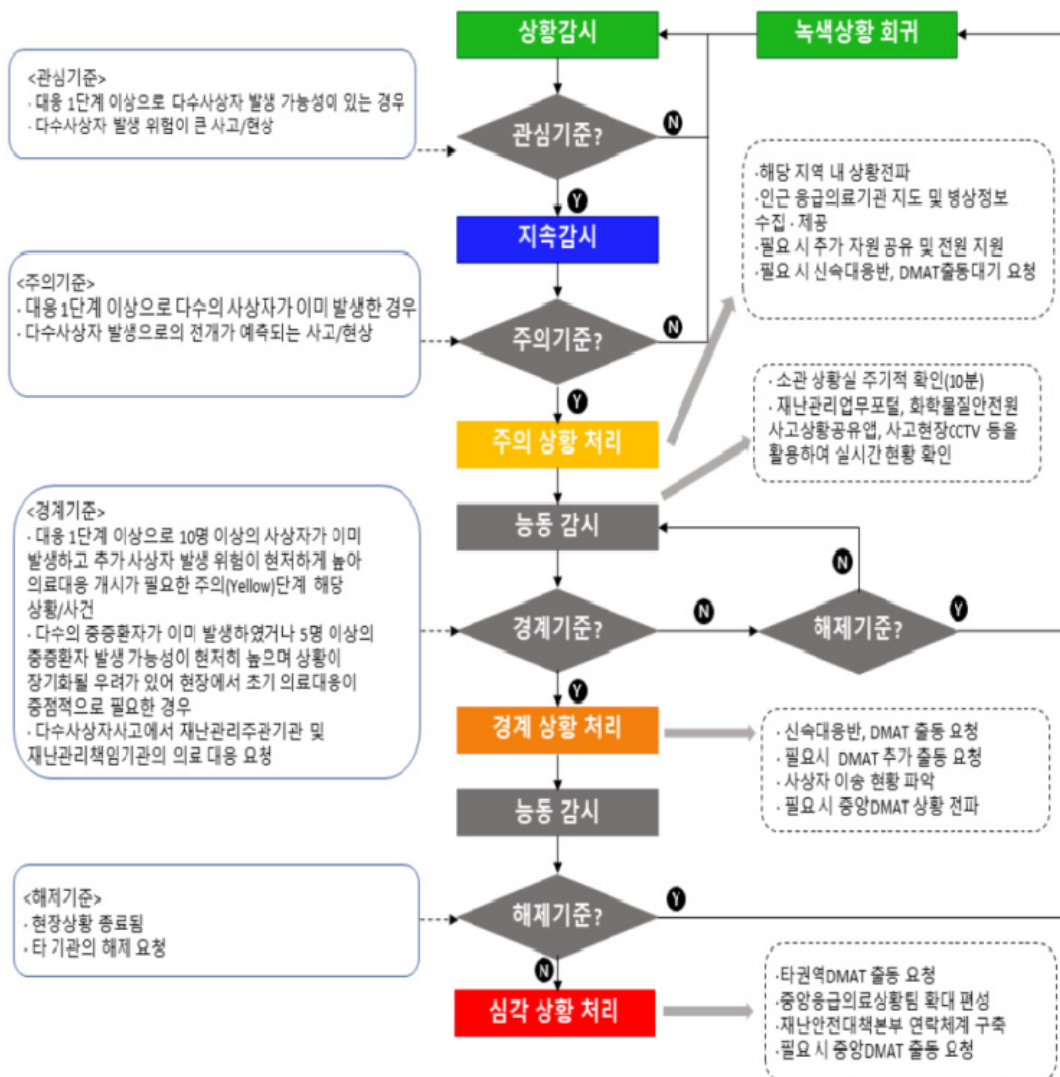


〈그림 6. 재난 등의 발생 시 활동 흐름 단계별 요약〉

1 재난상황 접수 및 전파

- 중앙응급의료상황실은 의사와 상황요원이 24시간 교대근무하며 재난상황을 모니터링 하고, 재난 등의 발생 시 상황의 전파, DMAT 출동요청, 재난대응기관 간 통신, 정보 수집 및 제공, 환자 현황 집계 등의 역할을 수행함
- 소방청, 소방본부(상황실 및 구급상황관리센터)는 재난관련 정보(발생장소, 재난종류와 규모, 추정 사상자 수, 인명대피현황 및 예측수용인구 수, 대응 진행상황 등)의 갱신 및 현장의료지원 필요 시 중앙응급의료상황실로 즉시 전달해야 함
- 수신한 상황은 중앙응급의료상황실에서 운영하는 모바일 상황실(보건복지부(재난의료과 및 비상안전기획관), 시·도, 보건소, 중앙응급의료센터, 재난의료책임자, 응급의료 지원센터)에 메시지로 전파함. 실제 상황 발생 시 신속대응반 및 DMAT 등 관련자를 초대하여 상황 전파함

- 중앙응급의료상황실은 아래와 같은 재난 발생 시에는 보건복지부에 핫라인으로 즉시 상황전파 함
 - 보건복지 관련 시설에서 발생한 사고(병원, 요양원 등)
 - 기타 대규모 재난 (Code Orange(경계 상황) 발령 건)
- 접수한 상황은 Code Blue(관심 상황), Yellow(주의 상황), Orange(경계 상황), Red(심각 상황)로 각각 처리됨



〈그림 7. 재난상황 흐름도〉

2 출동요청 및 출동

가. 출동대기

- 재난 등 상황 발생 초기이거나, 현장 상황에 대한 정보 수집이 충분하지 않아 신속대응반이나 DMAT 출동 결정을 바로 내릴 수 없는 경우 중앙응급의료상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, PS-LTE 등)을 통해 상황을 전파하고 출동 대기를 요청할 수 있음
- 신속대응반과 DMAT은 모바일 상황실에 초대되며, 출동 대기 상태임을 알림

나. 출동기준

- Code Orange(경계 상황)이상의 단계 또는 그 외의 단계에서 예측되는 상황을 고려한 중앙응급의료상황실의 요청
- 보건소장 및 재난의료책임자의 판단
 - ※ 긴급구조기관의 대응단계 변경 시 신속대응반 및 DMAT의 출동규모도 변경할 수 있음
 - ※ 방사선 물질 관련 사고에 대해서는 방사선 비상진료체계를 우선 가동하고, 방사선 비상진료 체계에 의한 대응 부족 시 출동 요청
 - ※ 사상자 중 중증 환자 다수 발생으로 전문적인 현장의료대응이 요구될 시 DMAT 출동 고려

다. 출동요청

- 재난관리주관기관 및 재난관리책임기관은 중앙응급의료상황실로 신속대응반 혹은 DMAT의 출동을 요청할 수 있음
- 신속대응반 혹은 DMAT의 출동이 결정된 경우 중앙응급의료상황실은 핫라인(유선전화, 무선전화, PS-LTE 등)을 통해 신속대응반 또는 DMAT의 출동을 요청하고 보건복지부에 보고할 수 있음
- 기관 자체 판단에 따라 신속대응반 혹은 DMAT의 출동을 결정한 경우 중앙응급의료상황실에 유선으로 통보하고, 모바일 상황실을 통해 관계기관에 출동상황을 공유해야 함
- 현장이 안전하지 않다고 판단되는 경우 출동 기준에 부합하더라도 출동 요청을 하지 않을 수 있음
- 상황에 따라 현장 대응이 아닌 원내 대응이 더 효율적인 경우 출동 기준에 부합하더라도 출동 요청을 하지 않거나 타 병원으로 출동 요청이 가능함(예. 현장에서 재난거점병원

까지의 거리가 짧아 현장 출동보다 원내에서 더 많은 환자를 수용하는 것이 효율적인 경우, 사고 현장과 가까운 응급의료기관에 환자 쏠림으로 인해 의료진이 부족한 경우 등에는 DMAT이 현장이 아닌 해당 의료기관으로 출동하여 활동)

- 출동 요청은 관할 지역 신속대응반과 재난거점병원(시도경계와 무관하게 가장 가까운)에 요청되며, 발생지점이 2개 이상 재난거점병원과의 거리가 모호한 경우(예상도착시간 차이가 5분 이내) 관할 지역의 DMAT을 우선으로 요청할 수 있음
- 관할 구역 내 다수 사고 발생 시 추가 출동명령이 필요할 경우 중앙응급의료상황실에서 근거리 순으로 DMAT 출동 요청을 할 수 있음
- 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 대응이 예상되는 재난 등의 경우 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 중앙 DMAT의 출동을 결정할 수 있음
- 응급의료지원센터는 중앙응급의료상황실의 출동지시가 있을 경우 현장으로 출동하며, 중앙응급의료상황실은 신속대응반만 출동한 경우에도 현장 상황에 따라 지역응급의료지원센터의 출동을 요청할 수 있음. 관할 지역의 응급의료지원센터가 부재하거나 야간·공휴일의 경우 다른 지역의 응급의료지원센터 출동을 요청할 수 있음
- 출동요청 시 중앙응급의료상황실은 최대한 현장관련 정보(정확한 발생 장소, 재난의 종류, 현장의 위험성 현황, 현장도달 경로, 사상자 수 등)를 수집하여 신속대응반과 DMAT에게 전달함. 또한 가능하면 현장지휘관의 연락처와 소재를 파악하여 신속대응반과 DMAT에 전달하고, 출동사항을 관계기관 상황실과 현장지휘관에게 전달함

라. 출동

- 출동요청을 받은 신속대응반은 출동요청 즉시 1개 팀을 출동하도록 해야 함(인력 구성은 IV장 참조)
- 출동요청을 받은 DMAT은 출동대기 장소에 인력 소집, 현장의료 물품의 적재 등 출동 준비를 마치고 즉시 목표장소로 출동을 개시함(출동목표시간은 출동요청 10분 이내)
- 재난거점병원은 병원에서 근무 중인 인력으로 DMAT 1팀을 구성하여 출동(인력 구성은 IV장 참조)하며, 필요 시 2시간 이내에 2팀이 출동할 수 있도록 권역 DMAT의 인력풀을 유지하도록 함(동시 최대 2개 팀 출동가능)

- 출동요청이 있는 경우 즉시 출동이 가능하도록 비상연락망 체계를 갖추어야 하며, 지정된 물품보관소에 즉시 출동할 수 있도록 구성된 재난의료지원물품을 보관, 유지, 관리해야 함
- 신속한 출동을 위해 긴급자동차(병원 구급차/민간이송업 등) 및 응급의료전용헬기 등을 이용할 수 있으며, 단, 현장의료지원의 필요성에 따라 재난의료지원차량은 준비되는 대로 출동
- 출동 시 중앙응급의료상황실에 출발시각과 예상 도착시간, 출동인력 현황을 보고함(예. 1시 56분 의사 1명, 간호사 1명, 구조사 1명, 행정 1명 총 4명 출발, 2시 30분 도착 예정)
- 출동 시 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하도록 함

3 선착팀(신속대응반, DMAT) 도착

현장 선착팀의 임무

- 현장 지휘체계의 확인 및 연계(C, Command&Control)
- 현장 안전 확보(S, Safety)
- 통신체계 구성(C, Communication)
- 현장 의료수요 파악, 필요 시 후발대 요청(A, Assessment)
- 현장응급의료 시행장소 선정(P, Place)

가. 현장지휘체계의 확인 및 연계(C, Command & Control)

- 신속대응반 또는 DMAT 중 가장 먼저 현장에 도착한 선착팀은 현장지휘소장(시·군·구 긴급구조통제단장)에게 도착을 보고(구두, 무선 등)해야 하며, 가능하면 구급대장이나 구급지휘팀장, 임시의료소장에게도 도착을 알림. 다만, 긴급구조통제단이 가동되기 전이라면 보건소장의 지시에 따름
- 소방에서 임시의료소를 운영중이었다면, 보건소장은 임시의료소 운영에 관한 사항(사상자 현황, 임시의료소에서 조치한 분류, 처치, 이송 현황 및 현장 상황 등)이 기록된 구급현장인계인수서를 받아야 함. 단, DMAT이 먼저 도착한 경우 DMAT 팀장이 받을 수 있음. 현장응급의료소로 전환 시 현장응급의료소장은 임시의료소장과 논의하여 운영인력의 역할을 재조정해야 함

- 현장응급의료소장은 보건소장 > 권역응급의료센터장 > 응급의료지원센터장 > 지역응급의료센터장이 할 수 있음. 현장응급의료소장은 현장응급의료소의 의료적 기능(중증도분류, 응급처치 등 환자진료와 관련된 임무의 지휘)을 DMAT 팀장에게 위임 가능함

재난현장지휘체계

- 긴급구조기관(소방청, 소방본부 및 소방서, 해양경찰청, 지방해양경찰청, 해양경찰서)이 재난대응의 중심기관이며 긴급구조지원기관(보건복지부, 종합병원, 응급의료기관, 보건소 등)은 긴급구조기관의 재난대응을 지원하는 역할을 수행
- 재난 현장의 '현장지휘관'은 중앙/지역통제단장이 되며 중앙통제단장은 소방청장이, 지역통제단장은 소방본부장/소방서장이 맡음. 통제단장은 종합병원, 응급의료기관에 지원과 의료인 파견을 요청할 수 있음
- 현장응급의료소장은 관할 지역 보건소장이 원칙임

나. 현장 안전 확보(S, Safety)

- 재난 현장이 의료팀이나 환자, 요구조자에게 잠재된/명확한 위험(추가 사고 위험, 화학 물질 등)이 있는지 현장지휘소에서 반드시 확인해야 함. 만약 의료팀이 안전하지 않다고 판단된다면(적절한 보호장구 부재 등) 위험 요소가 제거되기 전까지는 활동을 시작하면 안됨

다. 통신체계 구성(C, Communication)

- 선착팀은 먼저 재난 현장에서 중앙응급의료상황실, 현장지휘소, 현장응급의료소 내 통신체계를 확립해야 함
- 현장응급의료소와 중앙응급의료상황실 간 통신체계
 - PS-LTE, 휴대전화, 모바일 상황실 사용이 가능하며, 모바일 상황실 운영을 위해서는 적절한 인터넷 환경을 확보하여야 함
- 현장응급의료소와 현장지휘소 간 통신체계
 - 현장지휘소에 연락관 파견 또는 현장응급의료소에 구급담당자를 파견함
 - 현장에 출동하거나 출동 중인 신속대응반, DMAT, 응급의료지원센터는 재난안전통신망 표준운영절차에 따라 공통통화그룹에 합류하여야 함(VI장 참고)
- 현장응급의료소 내 통신체계
 - 현장응급의료소 내 통신은 PS-LTE 사용을 기본으로 하되, PS-LTE 사용이 어려운 경우 휴대전화, 무전기 등을 사용함. 통신은 기본적으로 DMAT 행정요원이나 신속대응반원이 담당함

라. 현장 의료수요 파악(A, Assessment)

- 신속대응반 및 DMAT은 관할 지역 내에서 다수의 사상자가 발생하거나 발생할 것으로 우려되는 사고를 최초 인지한 경우에는 시·도와 중앙응급의료상황실에 즉시 통보하고 필요한 경우 응급의료지원을 요청
- 선착팀은 전체 피해자 예상 규모, 환자 중증도, 기이송된 환자 규모 및 향후 예상되는 요구조자, 이송자원 현황 등 현장 상황에 대한 파악을 하여 재난현장의 의료수요를 평가하고, 추가 인력, 장비, 물품이 필요한지에 대해 종합하여 중앙응급의료상황실에 보고
- 보건복지부 및 중앙응급의료상황실은 동시에 많은 의료 인력이 필요한 경우 다수 권역 DMAT, 재난거점병원이 아닌 응급의료기관에게 출동을 요청할 수 있으며, 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 다수 권역 DMAT 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상 장기 대응이 필요하다고 판단하는 경우 중앙 DMAT의 출동을 결정할 수 있음
- 보건소와 중앙응급의료상황실은 사고 발생 지역 관할 시·도에 현장 응급의료지원에 필요한 자원 등에 대한 지원 요청을 할 수 있음
- 후착팀은 인력 구성으로 시간이 소요됨에 따라 선착팀은 후착팀 파견 여부를 신속히 판단하여 중앙응급의료상황실에 요청해야 시간을 단축할 수 있음

마. 현장응급의료 시행장소 선정(P, Place)

- 현장응급의료 시행장소는 현장지휘소와 상의하여 선정
- 이미 현장지휘소에 현장응급의료소가 설치된 경우 합류해서 활동
- 현장지휘소나 긴급구조통제단 구성 전인 경우 보건소장의 지시를 따름
- 현장응급의료소 설치가 필요하지 않다고 판단한 경우에는 환자집결장소만 정할 수 있음

바. 현장응급의료소 설치 요건

- 요구조자의 구조가 수시간 이상 지속될 것이 예상되는 경우, 이송자원의 상대적 부족으로 현장의 중환자 처치시간이 수십 분 이상 지속될 것이 예상되는 경우, 다수사상자로 인해 환자의 분류 및 구역 배정이 필요한 경우 현장응급의료소 설치를 결정함
- 현장응급의료소는 기존의 건물을 이용할 수 있으면 이용하고, 건물이 없는 경우 천막을 설치함. 천막 설치도 불가능한 경우 노천 활동을 시행함(건물>천막>노천)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- 재난 현장 인근에 의료기관이 있어 환자와 구급차의 접근과 집결이 용이한 경우 현장응급의료소로 활용할 수 있음

현장응급의료소 천막 설치 장소 선정

- 현장응급의료소 천막의 면적을 확인하고 천막 설치에 적절한 면적이 먼저 확보되어야 함
- 무엇보다도 의료진의 안전이 확보된 곳이어야 함
- 구급차 동선과 구조되어 나오는 환자 동선이 교차하는 곳에 자리를 잡아야 하며, 구급차 동선이 복잡해지지 않도록 해야 함
- 우천 시라면 배수가 잘되는 곳을 선택해야 함
- 화재, 화학재난 등의 경우 바람을 등지는 방향으로 설치해야 함
- 전기, 수도가 가까워야 하며, 가능한 한 그늘로 선택함

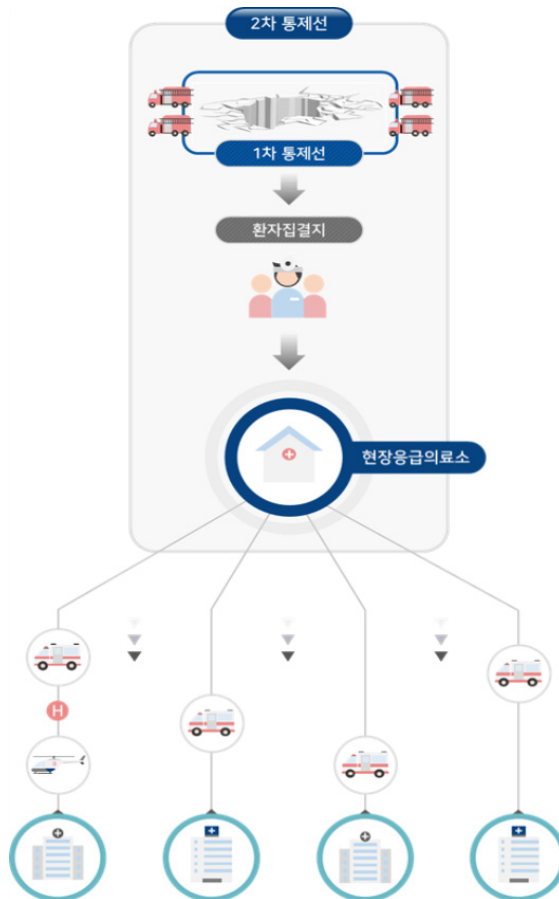
4 후착팀 합류

- 후착팀으로 합류하는 DMAT이나 신속대응반은 현장에 도착하여 가장 먼저 현장응급의료소장에게 보고하고, 현장응급의료소장 부재 시 선착팀에 도착을 알림
- 선착팀은 합류하는 DMAT이나 신속대응반에게 현장 상황에 대한 정보를 제공해야 함
- 필요 시 재난의료지휘체계를 재정립하여 지휘권을 양도할 수 있음
- 현장응급의료소장에게 임무를 부여받고 DMAT의 업무를 개시함. 현장응급의료소장에게 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 DMAT이 부여하거나 혹은 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정함

선착팀	후착팀
• 출동 요청 시 신속하게 현장으로 출동	• 재난의 규모가 크거나, 구조시간이 지체되는 경우 후착팀으로 현장 출동
• 출동요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게 (10분 이내 목표) 출동하여 안전하게 현장에 도착하도록 함	• 출동 요청 시 신속대응반은 즉시, DMAT은 신속하게 출동(1팀: 10분 이내 목표, 2팀: 2시간 이내 목표)하여 안전하게 현장에 도착하도록 함
• DMAT 혹은 신속대응반 중 가장 먼저 도착한 선착팀은 현장지휘소에 도착을 알린 후, 현장응급의료소장의 권한을 인계받음	• 현장응급의료소장에게 도착을 보고하고, 지휘권의 우선순위에 따라 현장응급의료소장의 담당자를 재조정 • 현장응급의료소장에게 임무를 부여받기 어려운 경우 선착 DMAT이 부여하거나 DMAT 간에 상의하여 임무를 결정
• 현장응급의료소장은 현장지휘체계의 확인 및 연계, 현장 안전 확보	• 후착팀도 다시 현장 안전 확보 • 통신체계 합류

선택팀	후착팀
• 통신체계 구성 • 현장 의료수요 파악 • 현장응급의료 시행장소 선정 • 추가 인력 요청 여부를 판단	
• 분류반과 처치반, 이송반, 운영지원반에 인력을 배치하되, 현장응급의료소 인력이 3인 이하인 경우에는 분류반과 처치반을 통합해 운영하고 분류반 활동에 좀 더 중점을 둠 • 이송반에 1인 이상을 배치하되 중앙응급의료 상황실과의 모바일 상황실과 통신하며 현장응급 의료소장에 보고하는 역할을 겸함	• 현장응급의료소장은 현장의 상황에 따라 선택팀과 후착팀을 포함하여 분류반, 이송반, 처치반, 운영 지원반의 인력을 재조정하여 배치

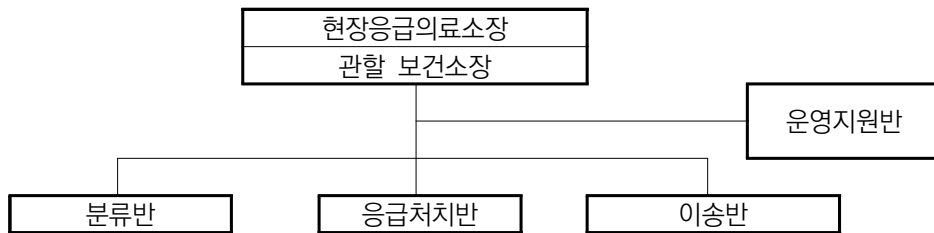
5 현장응급의료 활동



〈그림 8. 현장 재난의료활동 모식도〉

가. 현장응급의료소의 구성과 운영

- 긴급구조현장지휘규칙 제20조제4항 및 제7항에 따라 의료소에는 소장 1인과 분류반, 응급처치반, 이송반을 두고 각 반에는 반장을 두되 반장은 의료소 요원 중에서 의료소장이 임명함



- 분류반 : 환자 중증도 분류를 담당하며 최소 1인 이상 배치하며, 의사, 간호사 또는 1급 응급구조사를 배치함(긴급구조현장지휘규칙 제22조제2항)
- 응급처치반 : 응급처치를 담당하며 최소 1인 이상 배치, 현장에 초기 인원이 부족할 경우, 분류반과 응급처치반을 통합한 2인으로 구성해서 운영 가능함
- 이송반 : 중증도 분류에 따라 이송할 병원을 지정하고, PS-LTE 및 모바일 상황실의 연락을 담당하며 최소 1인 이상 배치함
- 운영지원반 : 현장응급의료소의 행정 업무(현장기록, 사상자 현황 파악, 상황실 정보 보고, 추가자원 동원 등)를 수행. 응급의료지원센터가 현장에 도착한 경우 운영지원반의 업무를 지원할 수 있음

나. 현장응급의료소 활동(3T)

- 중증도분류(T, Triage)
 - 재난 등의 현장에서 발생한 사상자를 검진하여 사상자의 상태에 따라 사망·긴급·응급·비응급의 4단계로 분류함
 - 소생 가능성이 매우 희박한 심정지 환자 또는 현장응급의료소의 역량을 초과하는 다수의 심정지 환자가 발생한 경우 의사(구급지도의사 포함) 지도에 따라 개별 또는 다수의 심정지 환자에 대한 심폐소생술을 유보할 수 있음
 - 중증도분류는 MASS(Move, Assess, Sort, Send), SALT(Sort, Assess, Life-saving interventions, Treatment/transport), START(Simple Triage And Rapid Treatment)법 등을 사용할 수 있음

- 분류된 사상자에게는 부록3의 중증도 분류표를 가슴부위 등 잘 보이는 곳, 부상이 없는 곳에 부착함
- 중증도 분류표를 부착한 사상자 중 긴급·응급환자는 응급처치반으로, 사망자와 비응급환자는 이송반으로 인계함. 다만, 현장에서의 응급처치보다 이송이 시급하다고 판단되는 환자의 경우 이송반으로 인계 가능함
- 환자의 상태의 변화, 시간의 흐름에 따라 사상자에 대한 재분류를 시행함



〈그림 9. SALT 다중손상 중증도 분류법〉



〈그림 10. START 분류〉

• 응급처치(T, Treatment)

- 응급처치반은 분류반이 인계한 긴급·응급환자에 대한 응급처치를 담당하고, 이 경우 긴급·응급환자를 이동시키지 아니하고 응급처치반 요원이 이동하면서 응급처치를 할 수 있음(긴급구조현장지휘규칙 제23조)
- 응급처치반장은 우선순위를 정하여 응급처치를 실시하고, 현장에서의 수술 등을 위하여 의료인 등이 추가로 요구되는 경우에는 현장응급의료소장에게 지원을 요청함
- 처치의 수준은 MASS, SALT법, START법에서 제시하는 것 외에 별도로 정함
- 응급처치는 DMAT 및 신속대응반이 현장에 가져간 재난의료지원물품을 기본으로 사용하며, 부족 시 구급차에 있는 물품을 활용함. 추가적인 물품이 필요한 경우 현장응급의료소장을 통해 통제단장에게 요청 후 중앙응급의료상황실에 보고
- 환자의 의학적 상태를 파악하고, 환자에게 시행한 응급처치 내용과, 환자의 이송병원 선정에 관련된 의학적 의견(예: 중환자실, 인공호흡기, 헬기 이송 등)을 중증도 분류표에 기재함

- 필요한 경우 중증도를 재분류하고, 중증도 분류표와 환자를 이송반에 인계함
- 분류반에서 이송반으로 바로 인계된 환자, 이송이 지체되어 현장 대기가 길어진 환자, 비응급 환자 등에 대해서도 필요 시 응급처치를 시행함
- 이송(T, Transportation)
 - 이송반은 사상자를 이송할 수 있도록 구급차 및 영구차를 확보 또는 통제하고, 각 의료기관과 긴밀한 연락체계를 유지하며 분류반 및 응급처치반이 인계한 사상자를 이송조치 함
 - 실시간 병상정보, 수용능력 확인 및 의료기관별 환자 이송 현황은 중앙응급의료상황실 모바일 상황실이나 현장지휘소, 소방본부 상황실(구급상황관리센터)로부터 정보를 수집함
 - 부록 4의 ‘병원별 수용능력표’를 준용하여 병원별 중상자와 경상자 수용능력을 실시간으로 조사하고, 이송병원 선정에 참고함. 이송병원 선정 시에는 분산 이송을 고려하여 실시함
 - 사상자의 이송 우선순위는 긴급환자, 응급환자, 비응급환자, 사망자 순임
 - 이송자원 선택 시 긴급환자는 소방구급차, 비응급환자나 사망환자는 민간이송업 구급차 우선으로 함
 - 사상자를 이송하려는 이송반장 또는 이송반원은 부록5의 사상자 이송현황을 작성하고 보관해야 함
 - 이송반은 사상자 이송현황을 파악하여 중앙응급의료상황실로 수시 전송함
 - 선정된 이송병원명, 구급차 차량번호 또는 구급차 소속, 현장출발시간 등을 기재하여 중증도 분류표 작성을 완성하고, 1부는 이송반에 나머지 1부는 의료기관이 보관할 수 있도록 환자와 함께 인계함
- 헬기 이송
 - 환자가 원거리 이송이 필요하거나 응급수술 등을 위해 권역외상센터로 이송이 필요할 때 헬기 사용 고려함
 - 환자이송에는 응급의료전용헬기, 소방헬기, 국방부헬기, 산림청헬기, 해양경찰청헬기 등이 사용 가능하며, 현장지휘소에 요청하거나 중앙응급의료상황실, 소방 상황실로 요청함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- 헬기 탑승 금기사항은 없는지 요청 전에 반드시 확인함

헬기 이송의 의학적 금기사항

- 응급의료 전용헬기 운용 지침이나 외국의 가이드라인에도 절대적인 의학적 금기사항은 없음
- 상대적인 금기사항으로 감압병, 기흉, 기뇌증, 장마비 등이 있으나, 이는 군 수송기나 민간항공기 등 고도가 높은 항공기에서 연구되고 있음
- 단, 헬기 이송 중에는 중재술 시행이 제한되므로, 헬기 이송 전 가능한 한 모든 중재술을 시행해야 함

다. 보건소

- 보건소는 관할 지역 내 재난 등에 대비하여 의사/간호사/응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상으로 구성된 신속대응반을 편성
- 보건소는 관할 지역 내에서 재난 등의 발생을 통보받거나 직접 인지한 경우 보건소장의 결정에 따라 즉시 신속대응반의 일부 또는 전부가 현장에 출동하거나 중앙응급의료 상황실, 지자체, 보건복지부의 요청에 따라 즉시 출동함
- 관할 보건소의 보건소장이 현장응급의료소장임
- 신속대응반의 주 업무는 DMAT 도착 전 선착팀으로서 현장 상황 파악, 재난현장의 의료수요를 평가하여 중앙응급의료상황실에 보고하고, 현장응급의료소장인 보건소장을 보좌하여 현장응급의료소 운영을 지원하는 것임
- 현장응급의료소 운영지원의 주 업무는 현장응급의료소 운영사항을 기록하고, 사상자의 현황 정보 수집, 상황실에 정보 보고, 재난의료 수행에 필요한 추가 자원(인력, 물자 등) 동원 등 행정 지원을 주로 수행함
- DMAT보다 먼저 도착한 경우 필요 시 중증도 분류, 응급처치 등 현장응급의료를 시행할 수 있으며, DMAT 도착 이후에도 DMAT과 합류하여 진료를 시행할 수 있음
- 정확한 사상자 이송 현황 파악을 위해 신속대응반을 제외한 보건소 직원을 이송의료 기관에 파견할 수 있음

라. 시·도

- 시·도에서는 상황 접수 즉시 시·도 비상진료대응반(또는 이 지침에 따라 해당 업무를 실시할 수 있는 임시 조직, 이하 같다)을 설치함

- 시·도 비상진료대응반은 관할 보건소 및 중앙응급의료상황실과 현장 상황을 공유하면서 관할 지역 내 의료자원 현황을 신속히 파악하고 시·도의 지원 계획을 수립
- 시·도 비상진료대응반은 관할 보건소와 중앙응급의료상황실로부터 수집·보고된 정보 또는 지원 요청에 따라 현장 응급의료지원 인력의 추가 동원, 의약품, 혈액 등의 수급 및 지원, 인근 시·군·구 간 부상자 이송 등을 조정함
- 시·도 비상진료대응반은 관할 지역의 소방본부, 경찰청, 군(軍)부대 등 관계기관 간 협조체계를 유지

마. 응급의료지원센터

- 평시 재난의료관리자는 재난거점병원 - 보건소 - 시·도 공무원 - 중앙응급의료상황실 등 재난의료 관계기관 간 협력을 지원
 - 재난거점병원의 재난교육, 훈련, 정보 관리, 재난의료 핫라인 관리 등 재난의료 대비 및 질 향상 활동
- 재난발생 시 재난현장에서 보건소 신속대응반과 DMAT의 현장응급의료소 운영지원 업무 수행
- 또한 재난 현장활동이 장기화되며 DMAT이 교체될 때 업무의 인수·인계를 지원함

6 현장 응급의료지원 활동의 종료

- 재난 상황이 종료되어 현장에서 추가 환자 발생이 없거나 응급의료지원 수요가 없는 경우에는 보건소장이 통제단장에게 현장 응급의료지원 활동 종료 건의를 할 수 있음
- 재난안전법 제52조에 따라 통제단장이 긴급구조 활동의 종료를 결정하거나 의료소 철수를 지시한 경우 보건소장은 의료소 철수 및 현장 응급의료지원 활동을 종료함
- 긴급구조통제단이 설치되지 않았거나 통제단장 또는 현장지휘관의 현장 지휘가 없는 경우에는 현장에 출동한 보건소장이 DMAT 팀장 또는 중앙응급의료상황실과 협의하여 활동을 종료함
- 의료소 철수 및 현장 응급의료지원 활동 종료가 결정되어 철수하는 경우 신속대응반 및 DMAT은 철수 시각, 철수 인원 등을 중앙응급의료상황실에 통보하여야 함
- 의료소의 철수에 따라 신속대응반과 DMAT은 현장 응급의료지원 활동을 종료하고 소속 기관으로 복귀함

7 활동의 종료 후 조치사항

- 응급의료법 시행령 제9조에 따라 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다수의 환자가 발생한 때에는 사고 발생일로부터 사고수습 종료일(지역재난안전대책본부가 설치된 경우 사고수습종료일은 지역재난안전대책본부 운영종료일로 봄)까지 매일 1일 활동상황을 보건복지부장관에게 통보하여야 하며, 사고 수습이 종료된 경우에는 지체 없이 종합하여 통보하여야 함
- 보건소장은 의료소 운영결과를 시·도 및 보건복지부에 보고해야 함
- 보건소, 재난거점병원 및 중앙응급의료센터는 사고수습 종료 후 1주일 이내에 의료장비와 소모품, 약물 및 기타 장비의 소독·점검 후 고장이나 부족한 장비를 보수·보충해야 함
- 현장에 출동했던 보건소, 재난거점병원, 응급의료지원센터는 사고수습 종료 후 선착팀 및 현장응급의료 활동에 대한 자체 평가를 실시하여야 하며, 그 결과는 기관별로 유지하여야 함

8 기록

가. 현장기록

- 재난현장에 도착한 DMAT, 신속대응반 등은 최대한 많은 기록을 남길 수 있도록 노력해야 하며 가능하다면 사진 및 동영상 촬영이나 녹취를 시행함
- 중증도 분류표 서식은 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 붙임 서식을 참고로 함(부록 3 참고)
 - 중증도 분류표는 환자를 인식하고 이동 경로를 파악하며 종사자 간 환자 정보를 공유하는 소중한 자료이므로, 반드시 모든 환자에게 중증도 분류표를 적용함을 원칙으로 함
 - 환자의 인적사항을 바로 파악할 수 없는 경우가 있으므로, 반드시 중증도 분류표에 번호를 기입해야 함. 번호는 중증도 분류표에 미리 기입되어 있는 것을 쓰는 것이 좋으나 그렇지 않은 경우 현장에서 통일된 방법으로 기입하도록 함
(예 : 발생연도/발생지역/중증도분류자/번호 : 05용인CMI0001)
- 병원별 수용능력표는 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 별지 제1의3 서식을 참고하여 병원별 중상자와 경상자의 수용 능력을 파악하여 기입하도록 함(부록 4 참고)

- 사상자 이송현황은 긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 별지 제2호 서식에 따라 기입하도록 함(부록 5 참고)
- 현장 대응이 길어지는 경우 환자 등록지를 활용할 수 있음(부록 6 참고)

나. 결과보고서

- 신속대응반은 신속대응반 활동보고서(부록 7 참고), DMAT은 DMAT 활동보고서(부록 8 참고)를 작성하여 사고수습종료일 1주일 이내에 응급의료지원센터에 제출해야 함
- 응급의료지원센터는 응급의료지원센터에서 작성한 결과보고서와 신속대응반 및 DMAT의 자료를 취합하여 중앙응급의료상황실로 제출해야 함
- 중앙응급의료상황실은 중앙응급의료상황실에서 작성한 결과보고서와 취합된 자료를 보건복지부 및 관할 시·도에 제출해야 함

9 기타 현장 활동 시 주의사항

가. 인력

- 의료인은 의료기관 내에서 의료업을 하여야 하나 응급환자 진료, 국가나 지방자치단체의 장이 공익상 필요하다고 인정하여 요청하는 경우(의료법 제33조). 또한 의료기관의 장은 그 의료기관의 환자를 진료하는 데에 필요하면 해당 의료기관에 소속되지 아니한 의료인에게 진료하도록 할 수 있음(의료법 제39조)

나. 의약품

- 재해가 발생하여 사실상 의료기관이 없게 되어 재해 구호를 위하여 조제하는 경우 약사는 의사 처방전 없이 조제할 수 있음(약사법 제23조)
- 재해가 발생하여 사실상 약국이 없게 되어 재해 구호를 위하여 조제하는 경우 의사는 약사 없이 직접 조제할 수 있음(약사법 제23조)

다. 언론 대응

- 재난 현장에서는 언론 공개 통로가 통일되어야 하며 원칙적으로 현장지휘소의 업무, 따라서 언론 인터뷰나 취재요청이 들어올 경우 현장지휘소에서 허가할 경우 언론 취재에 응할 수 있음

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI



보건복지부

Ministry of Health and Welfare

IV 장

재난현장의 응급의료지원 인력의 구성 및 운영



1. 신속대응반
2. 권역DMAT
3. 중앙DMAT
4. 재난 등의 발생 시 응급의료지원

Ⅳ

재난현장의 응급의료지원 인력의 구성 및 운영

응급의료종사자의 재난 현장 활동 의무

- 응급의료법 제18조에 따라 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 재해 등으로 환자가 여러 명 발생한 경우에는 응급의료종사자에게 응급의료 업무에 종사할 것을 명하거나, 의료기관의 장 또는 구급차 등을 운용하는 자에게 의료시설을 제공하거나 응급환자 이송 등의 업무에 종사할 것을 명할 수 있으며, 응급의료종사자, 의료기관의 장 및 구급차 등을 운용하는 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따른 명령을 거부할 수 없음
- 긴급구조현장지휘규칙 제13조에 따라 지역통제단장의 파견요청이 있는 경우 보건소, 권역응급의료센터, 지역응급의료센터 중 지역통제단장이 지정하는 기관 또는 센터는 지역통제단장이 지휘하는 통합지휘팀에 연락관을 파견해야 함
- 긴급구조현장지휘규칙 제20조에 따라 현장응급의료소 설치를 위해 종합병원과 응급의료기관에 응급의료기구의 지원과 의료인 등의 파견을 요청할 수 있음

구분	신속대응반	권역 DMAT	중앙 DMAT
출동 개시 (요청 후)	즉시	1팀 10분 이내 출동 목표 2팀 2시간 이내 출동 목표 3팀 12시간 이내 교대	3시간 이내
출동요청	중앙응급의료상황실, 소방, 지자체, 보건소장, 보건복지부	중앙응급의료상황실, 소방, 지자체, 보건소, 재난의료책임자	보건복지부, 중앙응급의료센터
인원 구성	의사/간호사/응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상	팀당 의사 1인, 간호사/응급구조사 2인, 행정요원 1인	사고 유형 및 규모에 따라 구성
운영	현장상황이 12시간 이상 길어지면 인력 교체를 위한 팀 파견	현장상황이 12시간 이상 길어지면 인력 교체를 위한 팀 파견	복지부 및 중앙응급의료센터가 판단하여 후발대 파견 가능
역할	응급의료 및 사상자 현황 수집 등	현장응급의료소 내 의료활동 등	현장의료활동 등
물품	신속대응반 물품	1팀 DMAT bag 2팀 현장응급의료소 물품	DMAT bag 현장응급의료소 물품 필요 시 이동형 병원
이동	긴급자동차 등	1팀 긴급자동차 등 2팀 재난의료지원차량	긴급자동차 등

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1 신속대응반

가. 보건소장

- 해당 지역의 재난의료 준비 및 대응에 관해 책임이 있으며, 소방 및 DMAT과 긴밀한 관계를 유지해야 함
- 신속대응반이 신속히 출동할 수 있도록 2개팀을 구성해야 함
- 현장응급의료소 설치 지역의 관할 보건소장은 현장응급의료소장이 됨
- 현장응급의료소장은 보건소장 > 권역응급의료센터장 > 응급의료지원센터장 > 지역응급의료센터장이 할 수 있음
 - 위 각 기관장의 역할은 기관장의 권한과 책임을 위임받은 해당 기관의 소속 직원이 대신할 수 있음
- 현장응급의료소장은 통제단장의 지휘를 받아 응급의료자원의 관리, 사상자의 분류, 응급처치, 이송 및 사상자 현황 파악, 보고 등의 현장응급의료소의 운영 전반을 지휘·감독함
- 현장응급의료소장은 재난의료 인력이 현장에 추가로 도착할 경우 이들을 포함하여 현장응급의료소의 반을 재구성할 수 있음

나. 출동 기준

- 재난 등의 발생 시 해당 지역 보건소의 인력으로 편성된 신속대응반이 즉시 출동하는 것을 원칙으로 함

다. 인원 구성

- 의사/간호사/응급구조사 2~3인, 행정요원 2인 이상으로 구성
- 신속대응반은 출동 요청을 받은 즉시 1개 팀을 구성 및 출동하는 것을 목표로 하며, 현장 활동 시간이 12시간을 넘게 되는 경우 교대팀이 투입될 수 있도록 보건소별로 총 2개 팀 이상을 구성함

라. 복장

- 현장에 출동하는 신속대응반은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 신속대응반을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함
- 현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함

마. 운영

- 재난 등의 발생으로 출동 요청을 받은 신속대응반은 가능한 즉시 1개 팀을 출동하도록 해야 함
- 현장 활동이 12시간 이상 길어질 경우 인근 보건소 인력 지원 등을 통해 교체팀을 파견할 수 있음
- 신속대응반은 재난 등의 발생 관할 지역 보건소에서 출동하는 것을 원칙으로 하나 재난의 유형이나 규모에 따라 인근 보건소의 신속대응반이 출동 요청될 수 있음

바. 출동 방법

- 보건소는 지정된 물품보관소에 즉시 출동할 수 있도록 구성된 재난 물품을 보관해야 함
- 재난 현장으로 출동 지시가 발생한 경우 보관 중인 재난 물품을 지참하고 즉시 현장으로 출동해야 함
- 이동 방식은 긴급자동차 등을 이용해 출동해야 함
- 신속대응반이 출동한 경우 출발 시각, 예상 도착시간, 출동 인력 현황을 즉각 중앙응급의료상황실에 보고해야 함

사. 역할

- 현장응급의료소 운영
- 사고 현장의 인명피해 규모 파악 및 상황 전파
- DMAT 등 의료지원 요청 여부 결정 및 중앙응급의료상황실로 보고
- 부상자 진료 등 현장 응급의료 활동 수행
- DMAT 도착 시 임무 부여 및 협업 수행
- 긴급구조통제단장이 현장응급의료소를 설치한 경우 설치 지원 및 운영
- 사상자 현황 정보 수집 및 관리

아. 교육훈련

- 보건소장 등은 현장응급의료소장을 위한 별도의 교육 프로그램을 이수해야 함
- 신속대응반 구성 인력은 관련 교육 프로그램을 이수해야 하며, 해당 보건소 및 시·도, 시·군·구, 소방 등 유관기관에서 진행되는 재난 대비 훈련에 연 1회 이상 참여해야 함
- 신속대응반 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 보건소에서 등록하고 관리해야 함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2 권역 DMAT

가. 재난의료책임자

- 해당 재난거점병원의 재난의료의 준비 및 대응에 관해 책임이 있으며, 소방, 보건소 등 재난 대응 및 지원 기관과 긴밀한 관계를 유지해야 함
- 권역 DMAT이 출동 요청에 따라 신속하게 출동할 수 있도록 월 단위로 당직 DMAT 명단을 확보하고, 이를 위한 권역 DMAT 인력풀을 관리해야 함
- 재난 등의 발생 시 직접 현장에 출동하지 못하는 경우, 출동한 DMAT 팀장에게 현장 대응에 관한 권한 위임을 할 수 있음

나. 출동 기준

- 재난 등의 발생으로 출동 요청이 있을 경우 재난거점병원의 인력으로 편성된 권역 DMAT이 10분 이내 출동하는 것을 목표로 함

다. 인원 구성

- 1개 팀당 의사 1인, 간호사/응급구조사 2인, 행정요원 1인으로 4명을 구성하되, 행정요원이 동행하기 어려운 경우 이를 제외한 3인으로 구성 가능함
- 재난거점병원은 3개 팀을 구성하고 동시 최대 2개 팀이 출동할 수 있도록 권역 DMAT의 인력풀을 유지하도록 함

라. 복장

- 현장에 출동하는 권역 DMAT은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 권역 DMAT을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함
- 현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함

마. 운영

- 권역 DMAT 1팀은 원칙적으로 당일 당직 근무중인 응급의학과 등 전문의, 간호사, 응급구조사를 중심으로 편성하도록 하여 출동 요청 후 10분 이내 출동을 목표로 함
- 현장 상황에 따라 인력, 의료물품 등의 추가 지원이 필요한 경우 2시간 이내 2팀을 파견할 수 있으며, 현장 활동이 12시간을 넘게 되는 경우에도 교체팀을 파견할 수 있도록 함

- 권역 DMAT은 재난 등의 발생 지역에서 근거리 순으로 출동하는 것을 원칙으로 하되, 재난 등의 유형이나 규모에 따라 달리 적용할 수 있음

바. 출동 방법

- 재난거점병원은 지정된 물품보관소에 즉시 출동할 수 있도록 구성된 재난 물품을 보관해야 함
- 재난 등 현장으로 출동 지시가 발생한 경우 권역 DMAT은 보관 중인 재난 물품을 지참하고 즉시 현장으로 출동(목표시간 10분 이내)해야 하며, 이동 방식은 긴급자동차(예 119 구급차, 병원 앰블런스 등) 등을 이용해 출동함
- 재난의료지원차량이 출동하는 경우 재난의료지원차량 물품 기준에 맞춰 모두 적재 후 출동함(차량의 출동 및 중단 여부는 재난의료책임자가 결정함)
- 권역 DMAT이 출동한 경우 재난의료책임자는 출발시각, 예상 도착시간, 출동 인력 현황을 즉각 중앙응급의료상황실에 보고해야 함

사. 역할

- 사고 현장의 인명피해 규모 파악 및 상황 전파
- 추가 의료지원 요청 여부 결정 및 중앙응급의료상황실로 보고
- 부상자 진료 등 현장 응급의료 활동 수행

아. 교육훈련

- 권역 DMAT 구성 인력(재난의료책임자 포함)은 관련 교육 프로그램(재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육 등)을 이수해야 함
- 재난거점병원은 지역 내 소방-보건소-의료기관 등 관련 기관이 참여하는 재난대응 교육·훈련을 연 2회 이상 주관하여 실시하고, 연 3회 이상 외부기관이 주관하는 훈련에 참여해야 함
- 권역 DMAT 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 소속 기관에서 등록하고 관리해야 함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

3 중앙 DMAT

가. 출동 기준

- 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 대응이 예상되는 재난 등의 경우 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 중앙 DMAT의 출동을 결정할 수 있음
- 국립중앙의료원 등의 인력으로 편성된 중앙 DMAT은 출동 요청이 발생한 후 3시간 이내 출동하는 것을 원칙으로 함

나. 출동 인원

- 의사, 간호사/응급구조사, 행정요원을 기본으로 하되, 사고 유형 및 규모에 따라 인원 및 직렬 구성 가능

다. 복장

- 현장에 출동하는 중앙 DMAT은 현장응급의료인력임을 인식할 수 있는 복장(부록 1 참고)을 착용하고 현장출입을 위한 출입증(부록 2 참고)을 반드시 패용하여, 유관기관이 중앙 DMAT을 쉽게 인식할 수 있도록 해야 함
- 현장응급의료인력 복장에는 직종과 역할을 구분할 수 있는 표식이 있어야 함

라. 운영

- 중앙응급의료센터장은 의사, 간호사, 약사, 응급구조사, 의료기사 등이 포함된 중앙 DMAT 인력풀을 구성·운영하여 출동에 대비하여야 함
- 최초 중앙 DMAT은 3시간 이내 출동을 목표로 하며, 보건복지부 및 중앙응급의료센터는 재난 등의 유형과 규모를 감안하여 추가 지원 규모 및 출동 준비 시간을 조정할 수 있음

마. 교육훈련

- 중앙 DMAT 구성 인력은 관련 교육 프로그램(재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육 등)을 이수해야 함
- 중앙 DMAT 구성 인력은 소속기관 및 유관기관에서 진행되는 재난 대비 훈련(이동형 병원 운영 훈련 등)에 참여해야 함

- 중앙 DMAT 구성 인력의 교육·훈련 참여 실적은 중앙응급의료센터에서 등록하고 관리해야 함

바. 역할

- 부상자 진료 등 현장 응급의료 활동 수행
- 이동형 병원 운영 및 병원 내 응급의료 활동 수행

4 재난 등의 발생 시 응급의료지원

- 응급의료법 제30조의2 및 제18조에 따라 권역외상센터와 응급의료기관은 대형 재난 등의 발생 시 응급의료 지원 업무를 수행하는 재난거점병원의 역할을 수행할 수 있음
- 응급의료법 제18조 및 동법 시행령 제10조에 따라 시·도지사는 다수의 환자발생에 대비하여 환자 발생의 원인 및 규모에 따른 적절한 조치계획을 수립해야 함
- 재난거점병원 및 보건소는 DMAT과 신속대응반으로 투입가능한 인력의 명단을 매달 중앙응급의료센터로 제출해야 함
- 응급의료기관은 재난 등의 발생 시 사상자 이송에 대비한 병원 내 대응체계 운영, 재난의료지원물품 공급 등 각 기관별로 부여된 역할을 수행하기 위한 재난대응계획을 수립·운영하여야 함
- 재난거점병원 외 응급의료기관은 의료기관의 역량에 따라 현장 응급의료지원을 위한 지역 DMAT을 편성하여 운용할 수 있으며, 중앙응급의료상황실의 상황 전파에 따라 부상자 이송에 대비하여 응급실과 의료진, 병상 등을 준비하여야 함
- 재난거점병원의 권역 DMAT이 출동할 시에는 해당 병원에서 '출장'으로 행정처리를 해야 하며 이에 따른 행정비용은 병원이 부담함
- 보건복지부는 현장 응급의료지원 업무 중 발생한 상해 등에 대비하여 출동 인력을 대상으로 보험가입 등을 할 수 있고 이에 대한 비용을 부담함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI



보건복지부

Ministry of Health and Welfare



재난현장의 응급의료지원 물품의 비축과 관리



1. 응급의료지원 물품의 정의
2. DMAT 물품
3. 현장응급의료소 물품
4. 응급의료지원 물품의 관리
5. 신속대응반 물품 구성
6. 이동형 병원

V

재난현장의 응급의료지원 물품의 비축과 관리

1 응급의료지원 물품의 정의

- ‘응급의료지원 물품’이란 재난 상황 시 의료지원을 위해 현장에 출동하는 DMAT 소속 팀원 개인물품 DMAT Bag을 포함하여 재난거점병원에서 보유(재난의료지원차량 포함)하고 있는 현장응급의료소 등 재난현장에 지원하는 물품 일체를 말함
- ‘개인물품’이란 DMAT 구성원별로 휴대해야 하는 물품으로, 재난현장에서 응급통신을 위한 무선통신장비(PS-LTE), 재난현장출입증 및 소속 및 임무가 표시되어 있는 유니폼, 야간 식별이 가능한 전등 등의 장비를 말함
- ‘외상처치물품’은 재난 상황 시 발생하는 외상환자의 처치를 원스톱으로 끝낼 수 있는 물품리스트의 일체를 말함. 모든 물품은 되도록 1회용을 사용하도록 권장함(예: 정맥로 및 수액세트, 기관삽관 장비 세트 등)



정맥로 및 수액세트의 예



골내주사세트의 예

- ‘이동형 병원’은 다수 권역 DMAT의 대응 역량을 초과하거나, 3일 이상의 장기적인 의료지원이 필요한 경우 재난 현장에 설치하는 의료소로, 이동이 가능한 형태로 일정 기간 자급자족이 가능하며 필요에 따라 규모의 확장 및 축소 운영이 가능한 시설과 장비 등을 말함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

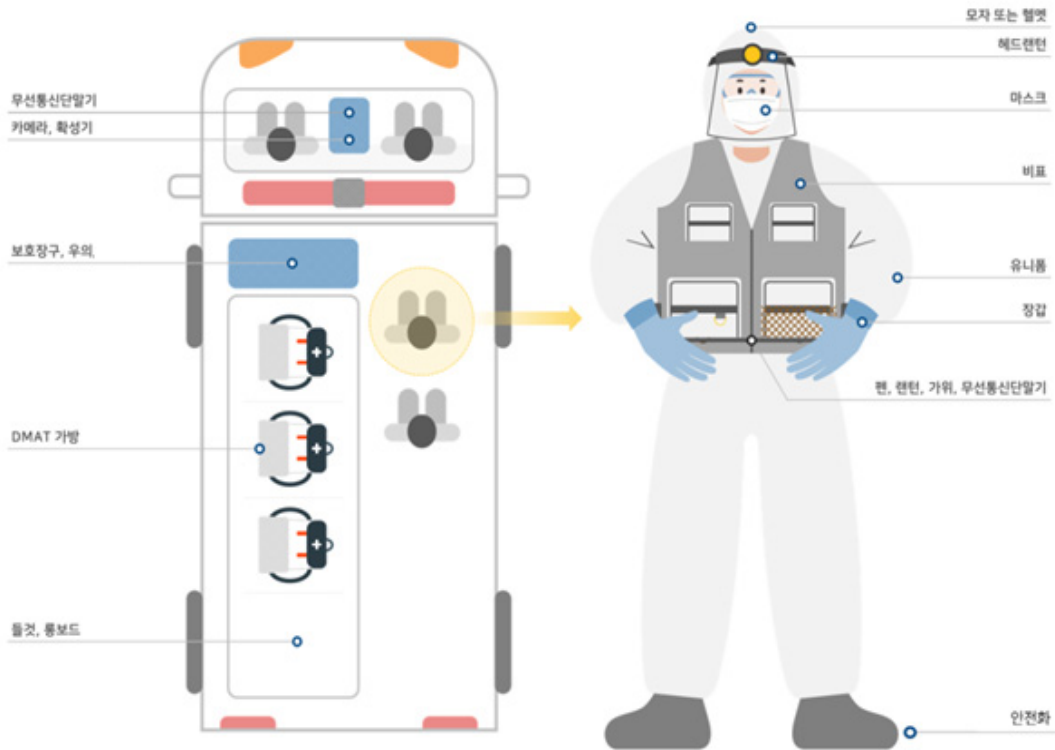
IX

X

XI

2 DMAT 물품

- DMAT 1차팀은 구성원별 DMAT bag을 가지고 긴급자동차 등으로 이동



〈그림 11. DMAT 1차팀 출동 물품의 예〉

- DMAT 개인 물품
 - 보호복 : 활동복 또는 표준 복장(부록1), 모자 또는 헬멧, 필요 시 우의, 헤드랜턴, 안전화
 - 통신수단 : PS-LTE단말기, 무전기 등
 - 랜턴, 글로브, 마스크, 가위, 팬 등
 - 재난출입증(비표)
- DMAT bag
 - DMAT bag은 DMAT 물품을 4개의 가방으로 나누어 보관함
 - 물품은 초기 중증도분류 및 분산이송, 10명 정도 중증외상 환자 진단과 처치에 초점을 맞추고 개인별 12~20kg, 4명 기준 48~80kg 이내의 물품으로 준비함

- 다음의 DMAT bag 구성안은 각 DMAT에서 구성해야 하는 권장안이며, 각 DMAT의 판단에 따라 품목의 종류나 수량을 변동시킬 수 있으며, 같은 기능을 가진 다른 물품으로 교체도 가능함
- 필요에 따라 가방 2, 3, 4의 내용물을 혼합하여 배치도 가능함
- 각 DMAT bag의 구성품은 일회용이나 경량의 물품으로 대체하여 최소한의 무게가 되도록 권고함
- 특수재난(화학, 방사능 재난 등)시에는 가능한 개인보호장구 등을 포함하여 추가물품을 구성해 출동하거나 현장 도착 전 특수구조대나 관련 기관에서 공급받을 수 있도록 조치하여야 함

구분	DMAT bags	
가방 1 (행정물품)	중증도분류표 50 환자등록지 50 병원별수용능력표 1 사상자이송현황표 1 비상대응매뉴얼 핸드북 4 비상연락처 4 안전구역설치띠 롤 3 디지털카메라 1	물품목록 4 약품목록 4 메모지 1 스카치테이프/청테이프 각 1개 클립보드 4 필기도구, 수정테이프 4 현장응급의료소 운영일지 10 확성기 1
가방 2 (의료물품)	펜라이트 3 청진기 3 체온계 1 혈당측정기 1 혈압계 1 설압자 20 이동식 감염폐기물통 1 감염폐기물 비닐, 박스 1 플라스터 3	산소포화도측정기 1 휴대형 초음파 진단 장치 1 흡인기 1 휴대용간이인공호흡기 1 접이식 들것 1 담요 2 젤리 1 골반고정대 1 일회용 비디오 후두경 1
가방 3 (외상처치물품)	경추 고정세트 3 KED 1 기관 삽관 장비세트 3 윤상갑상선절개술 세트 1 폐쇄식 흉관 삽관세트 1	정맥로 및 수액세트 5 골내주사 세트 1 상처소독 세트 10 상하지 부목 세트 각 10 지혈대 5
가방 4 (의약품)	수액제제(생리식염수, 5% 포도당용액, 에피네프린 10 하트만용액 등) 주사용 비마약성진통제 주사용 항히스타민제	니트로글리세린(설하용) 흡입용 기관지 확장제

※ DMAT bag 외 별도 탑재 물품: 휴대용 간이 인공호흡기, 접이식 들것, KED 또는 긴척추고정판



DMAT bag 외부 예시



DMAT bag 내부 예시

※ DMAT bag 표준구성이며, 물품 구성은 사용자의 편의에 따라 재편성 가능함

- 재난의료지원차량
 - 재난 현장 상황에 따라 필요한 경우 재난의료책임자 또는 중앙응급의료상황실은 재난의료지원차량을 권역 DMAT과 함께 출동시킬 수 있음
 - 재난의료지원차량에 구비해야 하는 장비 및 물품은 부록 9 표 2와 같음

3 현장응급의료소 물품

- 현장응급의료소 물품은 기존 재난의료지원차량(부록 9 참고)에 있는 물품에 추가물품으로 구성하며, 약품이나 외상처치 물품, 기타 처치물품 등은 환자 규모에 맞춰 조정하며, 일회용품은 우선으로 구성함
- 현장응급의료소 물품은 중증 환자 40명 처치 기준 및 재난현장 출동기준 72시간정도 외부의 지원 없이 현장응급의료소가 기본적 응급의료 기능을 수행할 수 있는 수준을 맞춰야 함
- 추가적인 물품이 필요한 경우 현장응급의료소장을 통해 통제단장에게 요청 후 중앙응급의료상황실에 보고

4 응급의료지원 물품의 관리

가. 관리책임자

- DMAT bag의 경우 DMAT을 운영하는 기관에서 관리하여야 하고, 현장응급의료소 물품의 경우 재난거점병원의 재난의료책임자가 주책임자가 되어 응급의료지원 물품 관리를 함
- 물품은 주 및 부관리자를 지정하고 이동식 시설, 장비별 관리대장을 작성하고 월별로 정상작동여부를 기록하며, 날인하여야 함. 소모품의 경우 유효 기간이 유지될 수 있도록 분기별 1회 점검하여 교체함
- 장비대장에는 장비명, 규격, 고유번호, 관리번호, 제작연도, 제작자, 소유자, 관리책임자 정/부, 설치일자, 내용연수, 점검현황, 점검자, 특별점검현황 등이 있어야 함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

나. 보관

- 산소탱크 용량은 분기별 1회 점검을 기본으로 하되, 출동 전 점검하여 용량이 적을 경우 응급실 산소탱크와 즉시 교환이 가능해야 함. DMAT 철수 후에는 1주일 이내에 다시 점검해야 함
- 응급의료지원 물품의 보관은 서늘한 장소에 24시간 접근이 가능하며 언제든지 불출 가능한 장소에 보관하여야 함
- 의약품의 경우에는 DMAT을 운영하는 기관의 의약품 관리 지침에 따라 보관하고 별도의 관리대장을 사용해서 보관함
- 소독물품의 경우에는 유효기간에서 1개월 이상 여유를 두고 재소독을 시행해야 함
- 재사용이 가능한 의료기기의 경우에는 감염관리 지침에 따라 소독절차를 거쳐야 함
- 의료장비의 경우에는 의료기기 질 관리규정에 맞게 장비 정도관리를 하여야 함(예: 혈당측정기 주 1회, 모니터 월 1회 등)

다. 불출

- 재난 발생시 DMAT 팀장 또는 재난의료책임자가 불출의 권한을 가짐. 또한 지자체장, 보건소장, 중앙응급의료센터장이 불출을 요구할 수 있고 특별한 사유가 없는 한 이에 응해야 함

라. 점검

- 재난의료지원차량을 포함한 응급의료지원 물품 점검은 반기별 1회 시·도, 응급의료지원센터와 재난거점병원에서 공동 점검을 시행함
- 공동 점검 실시 후 점검결과를 응급의료지원센터에서 취합 후 시·도, 재난거점병원 등에 공유함
- 보건복지부는 매뉴얼 개정시마다 응급의료지원 물품의 기준에 대해 전문가 자문 조사를 실시하고 이 결과에 따라 항목을 조정하여야 함

5 신속대응반 물품 구성

- 신속대응반 개인물품
 - 보호복 : 활동복 또는 표준 복장(부록1), 모자 또는 헬멧, 필요 시 우의, 헤드랜턴, 안전화
 - 통신수단 : PS-LTE단말기, 무전기 등
 - 랜턴, 글로브, 마스크, 가위, 펜 등
 - 재난출입증(비표)
- 신속대응반 bag

구분	신속대응반	
가방 1 (행정물품)	중증도분류표 50	스카치테이프/청테이프 각 1개
	환자등록지 50	클립보드 4
	병원별수용능력표 1	필기도구, 수정테이프 4
	사상자이송현황표 1	디지털카메라 1(또는 휴대전화 등 대체 장 비 1)
	신속대응반 활동보고서 10	확성기 1
	비상대응매뉴얼 핸드북 4	노트북 1
	비상연락처 3	프린터기 1
	물품목록 3	화이트보드 3
	약품목록 3	보드마커 9
	메모지 1	
가방 2 (의료물품)	펜라이트 3	이동식 감염폐기물통 1
	청진기 3	감염폐기물 비닐, 박스 1
	체온계 1	플라스터 3
	혈당측정기 1	접이식 들것 1
	혈압계 1	담요 2
	설압자 20	
가방 3 (외상처치물품)	상처소독 세트 10	상하지 부목 세트 각 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

6 이동형 병원

- 이동형 병원 규모 및 구성
 - 쉘터(컨테이너) 17동, 프레임텐트 15동, 차량 2대 등을 모듈 형태로 운영하며, 기본 50병상 규모이나 최대 확장 시 100병상 구축 가능
 - 응급실, 수술실, 중환자실 등이 포함



〈그림 12. 이동형 병원 구성〉



〈그림 13. 이동형 병원 주요 시설 및 전개 사진〉

- 이동형 병원 출동 규모

- 필요 출동 규모에 따라 Level I~Ⅲ의 3단계로 구분

구분	주요 내용			
Level I	출동모듈	• 소생응급실, 관찰응급실		
	예상 재난상황	• 규모가 파악되지 않은 재난 상황의 초기 대응 • 국지적 재난으로 교통이 원활하지 않고 주변에 큰 의료기관이 없거나 포화 상태 • Level II~III 설치 전 현장 진료 기능 수행		
	목표 진료범위	• 응급 처치 및 이송, 이송 전 현장 처치 시행 * 현장 전문소생 및 중소규모 응급실 수준		
	운영 병상	• 응급실 10병상		
	출동 인력	• 5명 * 응급의학과 전문의 1, 간호사/응급구조사 2, 행정 2		
	출동 목표 시간	• 준비 60분 + 이동시간		
	설치 목표 시간	• 30분 이내		
Level II	출동 모듈	• 소생응급실, 관찰응급실, X-ray실(서버실) • 분류 및 접수, 외래 및 약국, 입원실(4동)		
	예상 재난상황	• 국지적 재난으로 환자 이송 및 보급품 이송은 유지되는 상황 • 소수의 요구조자와 다수의 mass-crowding 발생 상태		
	목표 진료범위	• Level I 기능 • 외래진료 및 입원환자 수용 • 수술 필요 환자는 응급처치나 최소한의 응급수술(damage control surgery) 후 이송		
	운영 병상	• 응급실 10병상, 입원실 36병상		
	출동 인력	• 28명 (단위: 명)		
		직종	인원	비고
		의사	3	응급의학과 전문의 1 내, 외과계 전문의 1/1
		간호사/응급구조사	15	
		행정요원	10	기획, 물류 등
	출동 목표 시간	• 준비 120분 + 이동시간		
설치 목표 시간	• 8시간 이내			

* Level II 출동규모는 탄력적으로 변형 가능

구분	주요 내용			
Level III	출동모듈	• 이동형 병원 전체 모듈 - 소생응급실, 관찰응급실, 분류 및 접수, 외래 및 약국, 입원실(4동), 진단검사실, X-ray실, CT실, 수술실, 중환자실, 중앙공급실, 복도 모듈, 화장실 2동, 숙소 2동, 행정실 1동, 조리실 1동, 식당 1동, 발전실 2동, 급수실 1동, 오페수실 1동, 에어텐트 2동, 창고 6동		
	예상 재난상황	• 광범위 대규모 재난으로 도로 및 인근 의료기관 인프라 붕괴나 마비 상태 • 지원 단체와 재난구호물품 등의 지원까지 상당 시일 소요 예상 (파견지 자급자족 필요)		
	목표 진료범위	• Level II 기능 • 진료 및 진단(혈액 검사, 방사선 및 CT 촬영 등) • 응급 수술 및 수술 후 중환자 집중 감시 • 생활 시설 운영		
	운영 병상	• 응급실 10병상, 입원실 36병상, 중환자실 4병상 * 입원실은 최대 100병상까지 확대 가능		
	출동 인력	• 70명 (단위: 명)		
		직종	인원	비고
		의사	8	응급의학과 전문의 2 내, 외과계 전문의 1/1 수술실 4(신경외과, 정형외과, 일반외과, 마취과)
		간호사	24	
응급구조사		4		
진료지원		10	약사, 의료기사 등	
행정요원	24	기획, 물류 등		
출동 목표 시간	• 준비 240분 + 이동시간			
설치 목표 시간	• 20시간			

- 보건복지부와 중앙응급의료센터는 재난 등의 유형 및 규모에 따라 필요한 이동형 병원 모듈의 출동을 결정할 수 있으며, 이동형 병원 설치를 위한 부지 선정을 위하여 통제단장에게 협조를 요청할 수 있음
- 이동형 병원 설치 및 운용 등에 관한 내용은 관련 매뉴얼을 참고하여 운영함



보건복지부

Ministry of Health and Welfare

VI 장

재난현장의 응급의료지원 통신체계



1. 핫라인과 비상연락망 구축 및 점검
2. 상황접수 및 전파체계
3. 재난현장에서의 통신체계

VI

재난현장의 응급의료지원 통신체계

1 핫라인과 비상연락망 구축 및 점검**가. 핫라인 구성**

- 핫라인은 재난발생시 보건복지부, 시·도, 중앙응급의료센터, 병원, 보건소 등 간의 신속하고 일관성 있는 대응을 유도하는 통합 연락체계로, 대외에 공개되지 않도록 관리하여야 함
- 핫라인은 유선전화, 무선전화, PS-LTE 등을 사용할 수 있음
- 권역 DMAT, 신속대응반, 중앙 DMAT, 재난의료책임자는 무선 전화 핫라인이 필수
- 응급의료기관은 응급실 업무전화와 다른 회선을 지정해야 하며, 의료역량의 실시간 제공, 부상자 수용의 실시간 현황을 파악하여 보고할 수 있는 자가 핫라인을 담당하여야 함

나. 비상연락망

- 비상연락망은 기관 내 비상연락체계임
- 재난 상황이 발생할 경우 각 기관별 내부적으로 상황 전파를 하고 인력을 모으는 연락 방법임
- 각 기관의 모든 구성원은 비상연락망을 상시 유지하되, 유지방법은 기관의 여건에 따름

다. 핫라인 및 비상연락망 취합·점검

- 시·도, 보건소, 응급의료기관, 민간이송업 등의 기관은 핫라인 및 비상연락망 현황을 매달, 필요시 응급의료지원센터로 제출해야 함. 응급의료지원센터는 취합된 조사표를 중앙응급의료상황실로 제출하며, 중앙응급의료상황실에서는 전국의 핫라인 및 비상연락망 현황을 취합·관리함
- 모든 구성원은 핫라인 및 비상연락망 변동 시 응급의료지원센터를 통해 중앙응급의료상황실에 그 즉시 알려야 함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

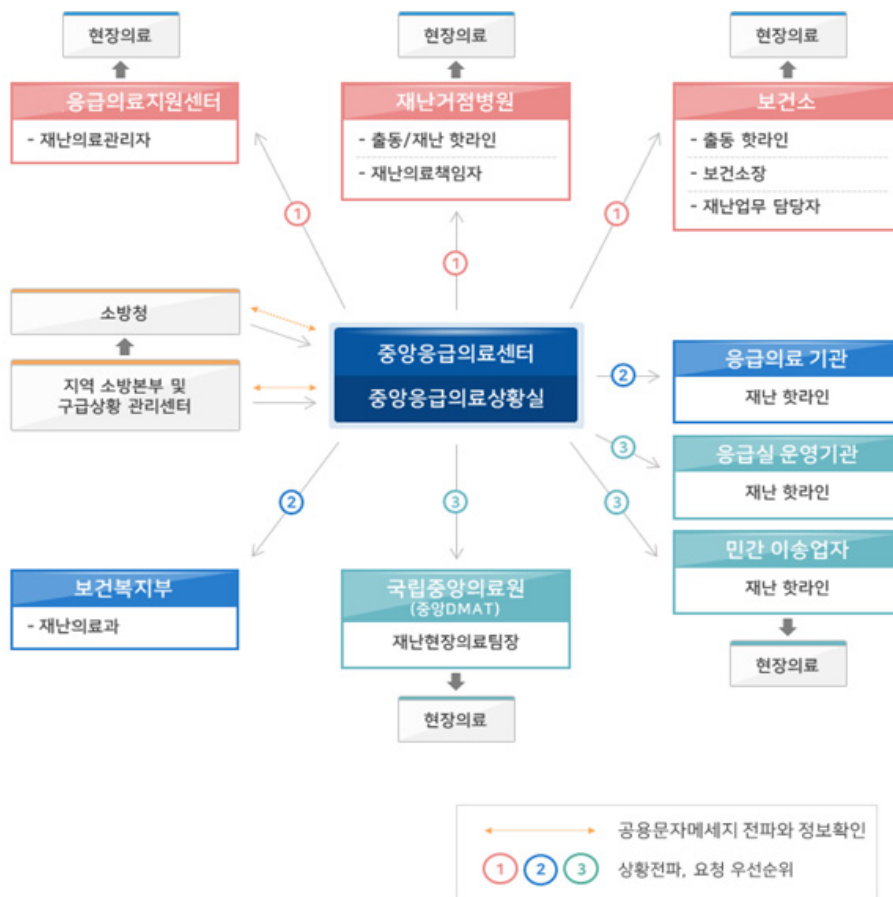
X

XI

- PS-LTE 핫라인의 경우 응급의료지원센터가 점검 주체가 되어 매월 점검하고, 중앙응급의료센터 재난안전통신망 사업 담당 부서로 결과를 제출함

2 상황접수 및 전파체계

- 보건소, 시·도, 보건복지부, 의료기관 등이 재난 등의 상황을 인지하거나 신고를 접수한 자는 접수 즉시 중앙응급의료상황실로 전파해야 함
- 중앙응급의료상황실은 언론 모니터링, 재난 및 각종 사고 발생 현황을 24시간 모니터링 하고 다수의 인명피해가 우려되는 경우 즉시 보건복지부, 관할 시·도 및 보건소, 사고지역 인근 응급의료기관 등에 상황을 전파함
- 중앙응급의료상황실은 신속한 상황 전파를 위해 휴대전화기 등 개인 무선통신장비 또는 응급의료 무선통신장비(PS-LTE)를 활용하여 다음 체계도에 따라 상황을 전파함



〈그림 14. 상황 전파 체계도〉

3 재난현장에서의 통신체계

가. 중앙응급의료상황실과의 통신체계

- 중앙응급의료상황실의 대응
 - 중앙응급의료상황실은 보건복지 관련기관 사고 또는 기타 대규모 재난 발생 시에는 즉시 핫라인으로 보건복지부에 상황을 통보해야 함
 - 중앙응급의료상황실은 현장에 신속대응반 및 DMAT 출동을 요청한 경우 즉시 재난의료대응 관계기관에 전파해야 함
 - 중앙응급의료상황실은 24시간 운용하고, 재난 등의 발생 시 신속한 상황 대응을 위해 필요한 관계기관(소방, 시·도, 보건소, 응급의료기관 등)과 직접 연락할 수 있는 핫라인 정보를 확보해야 함
- 현장과의 통신
 - 신속대응반 및 DMAT은 시·도 또는 중앙응급의료상황실로부터 현장 활동 사항의 보고를 요청받은 경우 휴대전화기 등 개인 무선통신장비 또는 PS-LTE를 활용하여 보고하여야 함
 - 관할 보건소장 또는 신속대응반이 현장에 도착하기 전에 DMAT이 먼저 도착한 경우, 중앙응급의료상황실은 보건소장에게 현장 상황을 공유·전파하여 보건소장이 개인 무선통신장비 또는 PS-LTE 등의 통신으로 현장 응급의료지원 활동을 지휘할 수 있도록 지원함
 - 통신의 불능 등으로 의료진이 긴급구조통제단장 또는 현장지휘관, 보건소장의 지휘를 받을 수 없거나 중앙응급의료상황실과 정보공유가 불가능한 경우에는 현장에 출동한 현장응급의료소장의 지휘에 따라 현장 응급의료지원 활동을 수행함
 - 중앙응급의료상황실에서 개설한 모바일 상황실에 접근한 모든 개인은 자신의 이름과 소속을 확인이 가능한 형태의 아이디로 변경해야 함(예: ○○병원 DMAT 팀장 홍길동)
 - 중앙응급의료상황실은 재난지역 인근 의료기관의 병상정보 현황, 실시간 환자이송 현황(의료기관 대상으로 정보 수집), 자원 투입상황 등의 정보를 수집하여 확인 가능한 수단으로 현장 의료진에게 전달해야 함
 - 현장 의료진은 DMAT 활동(출동, 현장도착, 현장활동개시, 활동내용, 철수 등), 환자이송현황(현장에서 이송되는 환자를 대상으로 정보 수집), 환자이송지침, 필요 자원 요청 등의 정보를 중앙응급의료상황실로 전달해야 함

나. 현장 내 통신체계

- 선작팀은 먼저 재난 현장에서 중앙응급의료상황실, 현장지휘소, 현장응급의료소 내 통신체계를 확립해야 함
- 현장응급의료소와 중앙응급의료상황실 간 통신체계
 - PS-LTE, 휴대전화, 모바일 상황실 사용이 가능하며, 모바일 상황실 운영을 위해서는 적절한 인터넷 환경을 확보하여야 함
- 현장응급의료소와 현장지휘소 간 통신체계
 - 현장지휘소에 연락관 파견 또는 현장응급의료소에 구급담당자를 파견함
 - 현장에 출동하거나 출동 중인 신속대응반, DMAT, 응급의료지원센터는 재난안전 통신망 표준운영절차에 따라 공통통화그룹에 합류하여야 함
- 현장응급의료소 내 통신체계
 - 현장응급의료소 내 통신은 PS-LTE 사용을 기본으로 하되, PS-LTE 사용이 어려운 경우 휴대전화, 무전기 등을 사용함. 통신은 기본적으로 DMAT 행정요원이나 신속대응반원이 담당함

다. 통신교육 및 대비

- PS-LTE를 사용하는 기관은 연 1회 이상 관련 교육을 받고 해당 내용을 기관 내 DMAT, 신속대응반을 대상으로 전파해야 함
- 현장에 출동하는 모든 재난 인력은 재난 상황 시 원활하고 지속적인 통신을 위해 전원 관리용 보조 배터리를 추가로 확보하고 있어야 함

VII 장

재난의료지원 활동 후 재난 심리지원 체계



1. 재난 정신건강 서비스 운영 및 대응체계
2. 재난 정신건강 서비스 실행
3. 재난 시 대응

VII

재난의료지원 활동 후 재난 심리지원 체계

- 재난 정신건강 서비스 및 심리지원에 관한 내용은 국가트라우마센터 '재난 정신건강 서비스지원을 위한 현장 대응 지침서'의 내용을 발췌함
- 현장응급의료 재난 정신건강 지원은 응급의료법 시행령 제8조의2제5항에 따른 재난피해자 중 초기에 긴급한 심리치료가 필요한 대상자의 선정 및 심리치료방법에 관한 내용을 다룸

1 재난 정신건강 서비스 운영 및 대응체계

- 재난 정신건강 서비스 제공을 위한 기관별 협력 추진체계



〈그림 15. 재난 정신건강서비스 제공을 위한 65기관별 협력 추진체계〉

• 재난 정신건강 서비스 의사결정 체계

재난의 단계 및 규모	결정주체	조치사항
관심	재난 유형을 고려하여 예방에 대한 관심이 필요 • 시군구 보건소 • 기초정신건강복지센터	① 재난 발생 정보 수집 ① 재난 상황 모니터링 ② 매뉴얼·서식 등 초기대응 준비
주의 (소규모)	지역재난안전대책본부가 설치되지 않은 경미한 재난이나 소방, 경찰 등 유관기관의 요청이 있는 일상적 사고 (화재, 교통사고 등) • 시군구보건소 • 기초정신건강복지센터	① 재난 관련 정보 수집 ① 재난 상황 모니터링 ② 재난 정신건강 서비스 계획 수립 ③ 재난 심리지원 활동
	재난 피해지역(또는 재난 피해자 거주지 기준)이 2개 이하 자치구일 경우 • 시군구보건소 • 기초정신건강복지센터	
	재난 피해지역(또는 재난 피해자 거주지 기준)이 3개 이상 자치구일 경우 • 시군구보건소 • 광역정신건강복지센터	
경계 (중규모)	지역재난안전대책본부 (이하 '시·도대책본부')가 설치되는 재난 • 시도 지방자치단체 • 광역정신건강복지센터 • 권역 트라우마센터	① 재난 관련 정보 수집 ① 재난 상황 모니터링 ② 대응체계 구축 ② 통합심리지원단 구성(필요시) ③ 재난 심리지원활동
심각 (대규모)	중앙재난안전대책본부가 설치되는 재난 또는 인명·재산의 피해 정보가 경제적으로 광범위하여 주무부처의 장 또는 지역재난안전대책본부의 본부장이 자체 심리회복 지원역량을 초과한다고 판단하여 요청하는 경우 • 보건복지부 • 국가트라우마센터	① 재난 관련 정보 수집 ① 재난 상황 모니터링 ② 대응체계 구축 ② 통합심리지원단 구성 ③ 현장 재난 심리지원본부 가동 ③ 현장 상담소 운영 ③ 마음 안심버스 운영 ③ 홍보 및 언론 모니터링

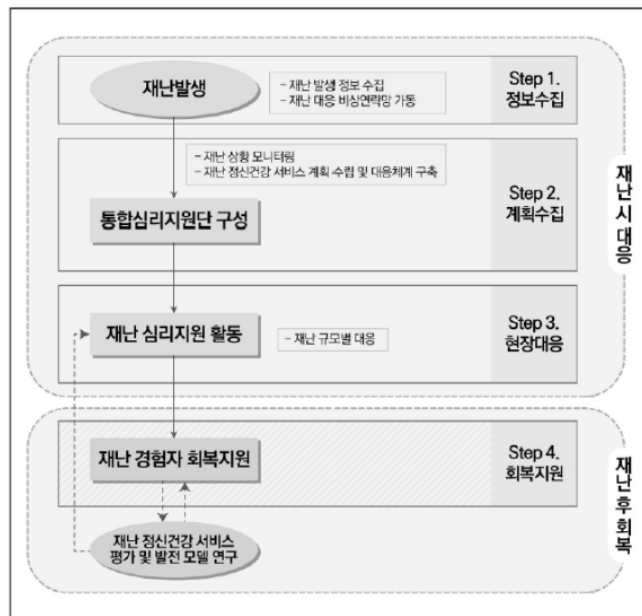
※ 출처 : 재난 정신건강 실무자를 위한 표준 매뉴얼

2 재난 정신건강 서비스 실행

구분		내용
1단계	정보수집	- 재난 규모 및 발생상황 확인 - 재난 경험자 현황 파악 - 인적, 물적 가용 자원 확인
2단계	계획수립	- 관계부처, 관련기관 협업체계 구축 - 재난심리지원 서비스팀 구성 - 현장상황실 및 상담공간 설치 - 업무분장, 보고체계, 위기대응 실행계획 확립
3단계	현장대응	- 심리적응급처치(PFA), 안정화 기법 - 위기개입 - 고위험군 선별 - 의료기관, 관련 센터 등 연계
4단계	종료 및 중장기관리	- 지속 관리기관 선정 - 재난 경험자 모니터링 등 회복 프로그램 운영 - 재난 대응인력 소진관리 및 전문교육

3 재난 시 대응

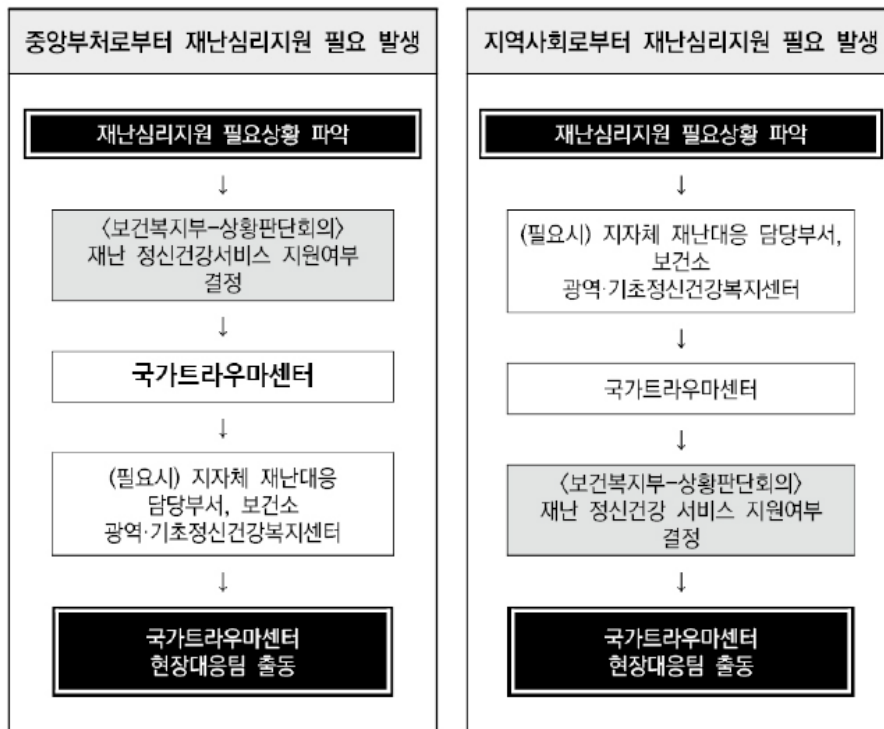
가. 재난 정신건강 서비스 지원 절차



〈그림 16. 재난 정신건강 서비스 지원 흐름도〉

나. 현장 대응

- 재난심리지원 활동
 - 정신건강의학 전문/전공의, 정신건강전문요원 1,2급 등으로 구성된 재난 정신건강 지원인력과 행정 지원 인력을 필요 시 현장에 파견하고 현장 재난심리지원본부 가동과 현장 상담소 등을 운영할 수 있음



〈그림 17. 재난심리지원 필요 상황 시 현장 출동 절차〉

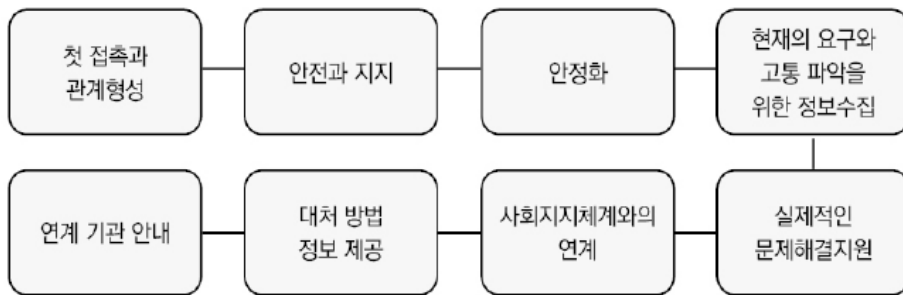
- 심리적 응급처치

재난이나 테러를 경험한 직후에 나타날 수 있는 초기 고통을 줄이고 단기적 적응과 장기적 기능 회복을 목표로 함
- 심리적 응급처치의 기본 목표
 - 안전한 장소에서 재난 경험자와 공감적인 관계 수립을 통해 신체적, 감정적인 안정감, 실질적인 도움과 정확한 정보를 제공하며 사회적 지지체계와 연결함
 - 현장요원은 유연하고 개방적인 태도로 재난 경험자의 구체적인 요구와 염려를 살피면서 심리적 응급처치를 제공하고 자신의 능력과 한계를 인식함

• 심리적 응급처치의 일반적 행동 지침

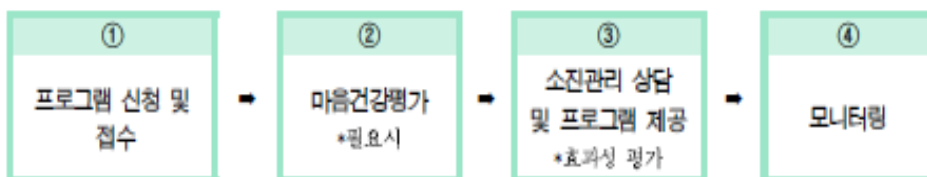
구분	내용
현장 기본 지침	• 현장 도착하여 상황 관찰 후 도움이 필요한지 여부를 묻기 • 첫 접촉의 가장 효과적인 방법은 실질적 도움을 제공하는 것 • 생존자가 현장 요원에 대해 침해 혹은 방해받았다고 여기지 않는다는 점을 충분히 관찰한 후 첫 접촉이 이루어져야 함 • 가능한 천천히 말하고 간단하고 구체적인 표현을 사용 • 생존자의 행동에서 강점을 찾아내어 인정하기 • 반드시 정확한 정보만 제공
현장 주의 사항 (피해야 하는 행동)	• 생존자들을 병리화하지 않고 은연 중에 낮추어 대하지 않음 • 디브리핑을 위해 사건에 대해 자세하게 설명하라고 하지 않음 • 충격적 경험이나 애도 반응을 다루지 않음 • 확실하지 않은 정보는 전달하지 않음

- 심리적 응급처치의 8가지 핵심 활동



다. 재난 발생 후 회복

- 재난대응인력 소진관리 프로그램: 재난대응업무로 인한 개인의 높은 스트레스와 소진에 대한 이해와 관리, 예방 및 대처능력 향상 프로그램 운영
 - 지원 대상: 구급·구조대원, 응급구조사, 의사, 간호사, 의료진, 재난심리지원 실무자, 행정공무원, 소방 및 경찰 공무원, 자원봉사자 등 재난대응 관련 업무 종사자
 - 신청 및 접수 : 개인별 또는 기관/단체를 통한 신청·접수





보건복지부

Ministry of Health and Welfare

VIII 장

재난 시 병원 원내 반응



1. 재난 등의 대비
2. 의료기관의 원외재난대응계획 수립

VIII

재난 시 병원 원내 반응

- 이 매뉴얼은 응급의료법에 의거한 응급의료기관(권역응급의료센터, 권역외상센터, 지역응급의료센터, 지역응급의료기관 등) 및 응급실 운영 의료기관에 적용함. 단, 원외재난대응계획의 수립과 관련한 사항은 권역응급의료센터에 적용되며, 다른 응급의료기관에 대해서는 권장사항으로 운영함

1 재난 등의 대비

- 핫라인의 개설 및 운영
 - 재난 등의 발생 시 신속하고 지속적인 연락을 위해 담당자와 전용전화번호(핫라인)를 개설하고 상시 유지하며, 대외에 공개되지 않도록 관리하여야 함
 - 핫라인은 다수 환자 수용 시에도 상시 연결이 가능하도록 부상자의 진료업무에서 자유로운 직원이 수신하는 것을 권장함
 - 중앙응급의료센터(중앙응급의료상황실)는 평시 일정 주기마다, 유사시 수시로 핫라인 가동 여부를 확인
- 지역 내 재난응급의료체계 참여
 - 관할지역 내 응급의료종사자 개인교육, 팀 훈련, 지역 재난 훈련 등에 참여(IX장 참고)
- 의료기관 재난관리체계
 - 재난관리체계(비상연락망 관리 포함) 구축: 재난 시 원내외 의사소통, 인력을 포함한 자원 관리
 - 정기적, 주기적인 재난 (모의) 훈련, 직원들의 재난 교육
 - 재난 발생 시, 최소 72시간 동안 외부의 지원 없이 환자와 의료진의 생존, 재난응급 의료대응을 위한 약품, 의료소모품, 의료장비, 식수, 식량, 자체 발전기 등의 자원을 비축해 두는 것을 권장함. 이를 위해 물류, 자원의 관리 체계를 해당 의료기관의 현실에 맞게 운영함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

2 의료기관의 원외재난대응계획 수립

- 의료기관은 규모에 적합한 원외재난대응계획을 수립·운용하여야 하며 계획에는 아래의 사항을 반드시 포함하여야 함
 - 비상연락망의 유지와 비상소집체계
 - 재난대응조직의 구성과 역할
 - 재난응급환자 진료(중증도 분류 포함)
 - 여유 병상, 장비 및 시설의 확보
 - 수용 가능한 환자의 유형과 수
 - 수용 불가 환자의 전원 방법
 - 환자의 수용/처리 상태 보고선(핫라인)의 지속 운용
 - 약품, 의료소모품, 의료장비, 식수, 식량의 준비와 보급
 - 원외재난대응계획의 세부 사항은 아래의 요소를 참고하여 작성하되, 의료기관의 규모에 따라 탄력적 작성이 가능함

[참고사항] 병원의 대응 주요 요소

1. 지휘와 조정(Command and control)
2. 의사소통(Communication)
3. 안전과 보안(Safety and security)
4. 중증도 분류(Triage)
5. 급증 환자 대응 능력(Surge capacity)
6. 주요 서비스의 지속 제공(Continuity of essential services)
7. 인력(Human resources)
8. 물류와 물자 관리(Logistics and supply management)
9. 재난 후 복구(Post-disaster recovery)

* Hospital Emergency Response checklist(2011). WHO regional office for Europe

가. 재난대응지휘체계

- 재난 등의 발생 시, 평상 시의 인사, 물류, 계약 등의 업무를 대신할 수 있는 대책본부를 두며, 대책본부장은 의료기관 내 모든 부서에 대한 지휘 권한을 가져야 함
- 대책본부장은 재난의 규모에 따라 응급의료를 책임지는 자, 진료부서를 책임지는 자 또는 의료기관 전체를 책임지는 자가 할 수 있음. 평시 운영을 위한 규정과 규칙을

벗어나 신속한 의사결정과 집행을 위하여 대책본부의 구성과 권한은 의료기관 내 상위 규정에 명시되어야 함

- 대책본부는 평시 소위원회로 운영할 수 있음. 재난준비 소위원회는 재난대응을 위한 인력, 장비, 장소, 내·외부 관계기관 연락망을 구성하는 매뉴얼을 정비해야 하며, 상황에 맞도록 매년 이를 보완해야 함
- 재난 매뉴얼은 응급실, 각 중환자실, 병실, 외래, 검사실, 행정부서에 비치하거나, 원내 홈페이지 게시판 등을 통해 확인할 수 있도록 하여 재난 발생 시 곧바로 활용할 수 있도록 함
- 재난 발생 시 대책본부는 확대 운영하여야 하며, 기본적으로 기획, 물류, 진료, 행정업무를 총괄할 수 있어야 함

나. 의사소통

- 외부 의사 소통
 - 해당 병원에 언론의 관심이 집중되는 경우, 의료기관의 현실에 맞게 언론과 소통할 직원이나 원내 부서를 지정하는 것을 권장함. 이 경우 언론 브리핑을 위한 장소는 원내 진료구역, 원내 상황실과 분리된 별도의 장소를 준비할 것을 권장함
 - 대중, 매체, 직원, 공공기관으로 나가는 모든 정보는 재난대책상황실의 검토를 거쳐야 함
 - 핫라인: 정부, 공공기관, 인근 병원, 소방 등에 적절하고 제시간에 정보를 수집하여 보고할 수 있도록 체계를 마련해야 함. 특히 중앙응급의료상황실에 여유 병상 현황, 재난사상자 내원 현황 등을 실시간으로 정보를 제공할 수 있도록 노력함
 - 보건소, 소방상황실, 경찰 등 공공기관에는 해당법률에 따라 환자 개인정보(환자의 이름, 성별, 연령, 손상 정도 등)의 제공이 가능함
 - 통신수단(위성전화, 무선통신, 유선전화, 인터넷, 페이지, 무전기 등)은 1차와 백업수단이 모두 사용 가능하도록 해야 함
 - 홈페이지와 콜센터는 원내 현황과 계획을 숙지하고 이용자에게 고지하여야 함
- 내부 의사 소통
 - 환자 우선순위(입원, 퇴원, 중증도 분류 방법, 감염 방지, 통제 방법)에 대한 결정들이 모든 관련 직원들에게 전달되도록 하여야 함

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

- 정보와 방침의 전달자는 전달하고자 하는 정보/방침이 일선 직원까지 제대로 전달되는지 확인하여야 함
- 원외 혹은 원내재난발생으로 의료수요가 공급을 훨씬 초과하는 상황이 발생할 경우 응급운영센터(emergency operations center, EOC)를 설치하여 외부기관과 협력하여야 하고 내부직원들을 호출(SMS, 원내게시판, 유/무선통신 수단 등)하여 소집하고 대비하게 함
- 병원 내 재난안전대책본부 대내외 협력 및 소통을 위한 준비 시 의료진이 치료에 집중할 수 있도록 홍보담당자를 한 명 지정하여 단일화시킴

다. 안전과 보안

- 출입구, 중증도 분류 지역, 주차장 등 환자 유입 지역은 조기에 통제를 시작해야 함
- 병원 직원과 환자, 방문자를 구별할 수 있도록 수단을 사용함
- 특수재난(화학, 생물학, 방사선 재난)에 있어서는 접촉지역, 접촉인원을 구분하고 동선을 분리하여야 함

라. 중증도 분류

- 최소 의사 1인, 간호사 또는 응급구조사 1인이 팀을 이루어 재난 응급환자 중증도 분류를 시행할 수 있도록 함. 응급의학과 전문의나 관련 교육을 수료한 간호사 또는 응급구조사가 중증도 분류를 시행하는 것을 권장함. 가능하면 복수의 팀이 중증도 분류를 시행하는 것을 권장함
- 중증도 분류지역은 의료기관의 현실에 맞게 응급실 진입로, 주차장 등 적절한 구역에 배치함
- 중증도 분류 결과를 잘 알아볼 수 있도록 적절한 중증도 분류표를 사용할 수도 있고, 의료기관의 현실에 맞게 전산 또는 의료기관이 정한 자체 서식을 사용할 수도 있음

마. 급증 환자 대응 능력

- 병원의 모든 자원을 고려하여 최대 진료 능력을 계산해야 함
- 의료기관의 입원실을 확장할 수 있는 수단. 예를 들면 강당, 회의실, 복도, 로비와 같은 공간을 임시 진료 공간으로 사용할 수 있음

- 재난 시 의사의 의학적 판단에 따라 기도 처치, 상처 지혈, 부목 고정과 같은 생명 유지에 필요한 처치를 우선하고, 최소한의 영상의학적, 진단검사의학적 검사를 시행할 수 있음
- 내원 환자 수가 병원의 공급능력을 초과할 경우 신속한 의사결정을 통해 적극적인 타 병원 이송을 원칙으로 하며, 또한 이 경우 중앙응급의료상황실에 알려 현장 이송을 조정할 수 있도록 하고, 환자 이송에 필요한 이송 수단과 자원의 가용성을 파악해야 함
- 원내 장례식장 외에 임시영안소로 사용할 수 있는 구역을 지정하고 운영함

바. 주요 서비스의 지속 제공

- 식수, 식량, 전기, 의료용 산소 등의 공급이 적절히 이루어질 수 있도록 해야 함
- 의료폐기물, 쓰레기 등의 수집과 폐기, 상하수도 관리, 화장실 위생 관리가 지속될 수 있도록 함
- 환자 및 의료기관 직원들에게 식수, 식량, 휴게 시간 및 공간을 적절히 제공할 수 있도록 해야 함

사. 인력

- 비상연락망을 주기적으로 업데이트하고 직원의 부재를 모니터해야 함
- 직원을 적절히 배치하고, 본인이 아프거나 가족이 부상당하거나 이유로 직원이 가족에게 가야 하는 경우 해당 직원은 병원 재난대응에서 배제해야 함
- [참고사항] 인력 배치의 예

구분	긴급환자	응급환자	비응급환자
환자 비율 (전체 환자 중)	15~25%	25~35%	50%
의사 인력 (환자 : 의사)	1:2	3:1	10:1
간호사 인력 (환자 : 간호사)	1:2	3:2	5:1
행정 인력 (환자 : 행정)	1:1	3:1	5:1

아. 해당 의료기관의 능력을 초과하는 경우

- 재난 시 이송되는 응급환자의 수가 해당 의료기관의 진료능력을 초과하는 경우, 중앙응급의료센터(중앙응급의료상황실)에 연락을 통해 재난 현장에서 해당 응급의료기관으로 이송을 조정할 수 있도록 함

- 재난 시, 해당 의료기관으로 이송되어 응급처치를 시행한 환자 중에 해당 의료기관의 진료 능력을 초과하는 정도의 입원, 중환자실 입원, 수술이 필요한 환자로 판단되는 경우, 중앙응급의료센터(중앙응급의료상황실)에 연락을 통해 진료 가능 의료기관으로 이송이 필요한 환자가 발생하였음을 알리고 전원 조정을 받거나 직접 인근의 의료기관으로 전원 연락을 하며, 이송에 필요한 이송수단과 자원의 가용성을 파악하고 제공해야 함

자. 물류와 물자 관리

- 비품, 물품, 약품의 부족을 즉시 알 수 있는 시스템을 수립해야 함
- 주요 물자와 약품의 소비를 가장 발생 가능성이 높은 재난 시나리오를 사용하여 예측해야 함
- 주요 물자와 약품의 지속적인 공급을 위해 지역의 공급자나 국가기관, 공공기관들과 상의해야 함
- 물자의 비축을 위해 공간을 마련해야 하며, 냉장보관 약품도 안전하게 보관될 수 있도록 해야 함

차. 재난 후 복구

- 재난 대응 이후 결과보고서를 작성하여 의료기관의 장에게 보고하고 관련 직원들에게 공유함
 - 원내 규정으로 정한 시일 내에 재난 대응 사항에 대한 자체 평가를 실시하고, 결과보고서 작성 시 참고
- 재난 대응 이후, 의료인력의 건강 상태(정신건강상태 포함)를 각 부서의 장이 확인하여 진료가 필요하거나 상담, 지지가 필요한 경우 이를 시행하며, 각 관리부서는 의료기관의 약품, 의료소모품, 장비, 시설 등의 재고와 상태 등을 점검하고 필요 시 보충, 수리, 보수하며 의료기관의 장에게 보고하고 관련 직원들에게 공유함

카. [참고사항] 병원 재난대응 지침의 핵심요소(Core) 자가 체크리스트

연번	내용	반영여부	
		있다	없다
1	병원의 재난 정책을 사전에 심의하는 재난위원회(Hospital Emergency / Disaster Committee)가 있는가?		
2	병원 외부로부터 재난상황정보가 들어오는 일원화된 수신 담당자가 있는가?		
3	수신 담당자가 재난상황에 대한 정보를 받으면 보고해야 할, 병원재난대응지침(계획)을 활성화시킬 수 있는 권한을 가진 책임자(Chief Medical Superintendent / Incident commander)가 있는가?		
4	재난 시 운영되는 일원화된 명령체계(Incident Command System)가 있는가?		
5	병원 내 상황을 외부로 전파할 대외담당관이 있는가?		
6	재난 시 병원 내 조직 간의 통신 계획이 있는가?		
7	재난 시 환자급증(Surge)에 대응하기 위해 장소, 인력, 물자를 효율적으로 운영하는 계획이 있는가?		
8	재난 시 중증도 분류를 전담하는 조직과 그 조직의 운영계획이 있는가?		
9	간호 서비스를 효율적으로 제공할 수 있는 계획이 있는가?		
10	영상의학과, 임상해부병리 등의 비진료과가 임상의료를 지원하는 계획이 있는가?		
11	의료용품을 효율적으로 제공할 수 있는 계획이 있는가?		
12	통신, 이송, 식품, 위생, 식수와 전기 등의 물자(Logistic)를 효율적으로 제공할 수 있는 계획이 있는가?		
13	모든 정보를 통합하여 각 부서로부터 정보를 모으거나 혹은 부서로 정보를 주거나 병원 내외부로 정보를 전달하는 상황실(Control room)이 있는가?		
14	재난 시 환자치료구역 설정(환자접수구역, 소생구역, 관찰구역, 경환자처치 구역, 기존 정규수술을 모두 취소하고 새로운 수술계획을 짜서 공표하는 공간, 새로운 입원구역, 새로운 영안실 구역) 계획이 되어있는가?		
15	재난이 원인이 아닌 심정지 및 중증 환자를 위한 계획이 있는가?		
16	재난 시 병원 인력의 원활한 운영을 위하여 병원 인력의 교대와 이탈을 연속적으로 감시하고 평가하는 계획이 있는가?		
17	재난 상황이 끝나면 병원재난대응지침(계획)을 종료하고 단계적으로 평시 상황으로 전환하는 계획이 있는가?		
18	환자 안정화 후 전원을 준비하는 계획이 있는가?		
19	재난 시 병원의 출입구를 관리하는 계획이 있는가?		
20	병원 보안(Security)을 효율적으로 제공할 수 있는 계획이 있는가?		
21	재난 시 병원 내 안전평가를 전담하는 조직과 그 조직의 운영계획이 있는가?		

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI



보건복지부

Ministry of Health and Welfare

IX 장

재난현장의 응급의료 지원에 대한 교육과 훈련



1. 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육
2. 지역 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육
3. 유관기관 교육 및 합동 훈련

IX

재난현장의 응급의료 지원에 대한 교육과 훈련

1 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육

- 정의: 보건복지부에서 주관하는 재난 현장에서 응급의료지원에 필요한 이론, 실습, 훈련 등에 대한 교육과정으로, 재난응급의료 비상대응매뉴얼에 기반한 한국형 재난의료지원 교육(Korea Disaster Life Support, 이하 KDLS)을 말함
- 대상: 권역 DMAT / 중앙 DMAT 등 현장의료 활동인력 및 보건소장
- 종류: 기초과정*(KDLS-Basic, KDLS-Field), 전문과정**(KDLS-Advanced) 과정으로 구분되며, 그 외에도 강사과정(KDLS-Instructor), 보수과정(KDLS-Renewal)으로 구분함

* (연도별 기초과정 명칭) ('15~'17년, '24년~) KDLS-Basic, ('18~'23년) KDLS-Field

** (현행 전문과정) ('23년~) KDLS-Commander(현장응급의료소장(보건소장) 과정)

- 주요내용

구분	주요 내용	구분	주요 내용
이론	• 우리나라 DMAT의 활동사례 • 우리나라의 재난의료체계 • 재난현장의 의료 대응 • 재난현장 응급의료 통신체계 • 재난현장 지원을 위한 DMAT의 구성과 운영 • 재난현장의 유관기관의 역할	실습	• 재난현장 지원을 위한 물품의 비축과 관리(이론 포함) • 재난안전통신망(PS-LTE) • 중증도 분류(Triage) • 서식지 소개 및 작성 • 현장응급의료소(Tent) 구성 및 설치 • 다수사상자 사고 현장 도상훈련 • DMAT의 재난 현장 대응 종합훈련

* 교육 내용은 기본적으로 비상대응매뉴얼에 근거하며, 상황에 따라 일부 변경될 수 있음

- 교육·훈련 시간: 기초과정의 경우 12시간 이상, 그 외에는 교육과정에 따라 상이함
- 교육·훈련 수료기준: 전 교육과정 이수(100%) 및 이론평가 60점 이상 득점 시 수료, 그 외에는 과정별로 상이

- DMAT 활동을 위해서는 기초과정을 이수할 수 있도록 하며, 수료한 사람을 중심으로 출동할 수 있도록 함
- 교육·훈련 수료 대상에게는 수료증을 제공함
- 기초과정 수료자의 경우 3년마다 보수과정에 참여할 수 있도록 함

2 지역 재난응급의료 비상대응매뉴얼 교육

- 정의: 재난응급의료 비상대응매뉴얼을 근거로 응급의료지원센터나 재난거점병원에서 주관하는 교육과정
- 대상: 응급의료권역 내 소방, 보건소, 응급의료기관 등
- 주요내용
 - 재난응급의료 비상대응매뉴얼을 바탕으로 이론 및 실습 실시
 - 현장응급의료지원활동에 대한 실습(도상 및 실제 훈련 포함)
 - 지역특화 재난대응모델 마련 및 합동 훈련

3 유관기관 교육 및 합동 훈련

가. 재난대응 안전한국훈련

- 재난안전법 제35조 및 동법 시행령 제43조의14를 근거로 매년 재난관리책임기관, 긴급구조지원기관 등 관계기관 합동으로 실시하는 재난대비 훈련
- 주관: 행정안전부장관, 중앙행정기관의 장, 시·도지사, 시장·군수·구청장 및 긴급구조기관의 장
- 훈련내용: 재난발생 시 대응 역량 실행과정, 비상조직의 의사결정 과정, 다수 관계기관 상호협력 및 조정과정, 시설·장비 가동 등

나. 소방 주관 훈련

- 권역 DMAT과 신속대응반은 연 1회 이상 ‘다수사상자 구급대응훈련(또는 긴급구조 종합훈련)’ 및 ‘다수사상자 불시출동훈련’에 참여해야 함

구분	훈련유형	다수사상자 구급대응훈련 또는 긴급구조 종합훈련	다수사상자 불시출동훈련
시행 및 평가	소방청	시·도 소방본부 평가	평가 없음
	소방본부	시·도 소속 소방서 중 1개소 지정 평가	시·도 소속 소방서 중 1개소 지정 평가
	소방서	전체 소방서 연중 1회 실시	전체 소방서 분기 1회 실시
	응급의료 지원센터	-	현장응급의료소 부문 평가 (권역 DMAT 및 신속대응반 활동)
훈련내용		- 시·군·구 소방서 긴급구조통제단 가동 - 현장응급의료소 설치, 사상자 중증도 분류·처치·이송 등 현장응급의료 활동 포함	
비고		사전 계획된 훈련 시나리오와 절차에 의해 진행되는 훈련	실제상황처럼 시나리오 없이 진행되는 훈련

다. 방사선 비상진료 교육 및 훈련

- 방사선비상진료 신규·보수교육: 방사선비상진료 요원대상
- 방사능위기 공동대응과정: 군·경·소방·지자체·유관기관 대상
- 방사능위기 구급대응과정: 소방 구급대원·유관기관 대상
- 방사능 방재 훈련

구분	훈련유형	방사능 방재 연합훈련	방사능 방재 합동훈련
주관		원자력안전위원회	방사선비상계획구역 관할 지자체
참여기관		행안부 등 중앙정부, 방사선비상계획구역 관할 지자체, 군·경·소방, 전문기관, 유관기관, 비상진료기관 등	원자력안전위원회, 군·경·소방, 전문기관, 유관기관, 비상진료기관 등
훈련내용		- 방사능 재난 발생 시 국가 방사능방재체계 가동으로 재난 수습조치 및 피해 확산 방지를 위한 체계 가동훈련 - 합동방사선비상진료센터 운영(보건복지부 및 중앙응급의료센터 담당관 파견) - 현장방사선비상진료소와 현장응급의료소 설치 - 중증도 분류·제염/처치·이송 등 현장의료대응 활동 포함	
비고		사전 계획된 훈련 시나리오와 절차에 의해 진행	



보건복지부

Ministry of Health and Welfare

X 장

그 밖에 재난유형별 응급의료지원에 필요한 사항



1. 화학재난
2. 방사선 재난
3. 감염병 재난

X

그 밖에 재난유형별 응급의료지원에 필요한 사항

특수재난 관련 법률

긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙 제35조(재난유형별 긴급구조대응계획의 작성체계)
영 제63조제1항제3호에 따른 재난유형별 긴급구조대응계획은 다음 각 호의 재난유형별로 재난의 진행단계에 따라 조치해야 하는 주요사항과 주민보호를 위한 대민정보사항을 포함하여 작성해야 한다.

8. 유해화학물질(방사능을 포함한다)의 누출 및 확산

기상청과 그 소속기관 직제 시행규칙 제6조(예보국) ③ 예보정책과장은 다음 사항을 분장한다.

1. 예보(장기·수치예보는 제외한다. 이하 이 항, 제4항 및 제9항에서 같다) 및 특보(지진·지진해일·화산 특보는 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 관련 업무에 관한 기본정책 및 계획의 수립·종합·조정

14. 재난 및 위기대응(방사능·유해화학물질·산불 등)에 관한 기상정보 제공

소방청과 그 소속기관 직제 시행규칙 제7조(119특수구조대)

① 중앙119구조본부에 두는 119특수구조대의 명칭·위치 및 관할구역은 별표 1과 같다.

② 119특수구조대장은 다음 사항을 분장한다.

1. 관할구역 내 재난현장대응활동의 지휘 및 통제

8. 소속 119화학구조센터 운영에 관한 사항

소방청과 그 소속기관 직제 시행규칙 제8조(119화학구조센터)

① 119특수구조대장 소속으로 두는 119화학구조센터의 명칭·위치 및 관할구역은 별표 2와 같다

② 119화학구조센터장은 다음 사항을 분장한다.

1. 관할구역 내 특수사고 재난현장에서의 인명구조활동 및 지원

2. 특수사고 재난관리 수습활동 지원

3. 위험물에 대한 사고의 예방 및 대응에 관한 사항

5. 재난 출동대 편성, 현장작전 지휘대 운영

7. 현장활동대원의 안전관리

11. 특수사고 유형별 장비·자재 및 대응 약제 확보

(소방청) 화학재난 합동방재센터의 설치 및 운영에 관한 규정 제7조(업무) ④ 합동방재센터는 다음 각 호의 화학사고 대응 업무를 해당 팀별로 수행한다.

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

1. 위기수준 평가 및 경보 발령 판단(환경팀)
5. 화학물질 운송차량 사고시 사고물질 확인 및 해당 기업 연락(환경팀, 119화학구조팀)
6. 경계구역 재설정 및 오염지역 진·출입 통제(환경팀, 화학구조팀)

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제34조(감염병 위기관리대책의 수립·시행)

- ① 보건복지부장관 및 질병관리청장은 감염병의 확산 또는 해외 신종감염병의 국내 유입으로 인한 재난상황에 대처하기 위하여 위원회의 심의를 거쳐 감염병 위기관리대책(이하 “감염병 위기관리대책”이라 한다)을 수립·시행하여야 한다.
- ② 감염병 위기관리대책에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.
 1. 재난상황 발생 및 해외 신종감염병 유입에 대한 대응체계 및 기관별 역할
 2. 재난 및 위기상황의 판단, 위기경보 결정 및 관리체계
 3. 감염병위기 시 동원하여야 할 의료인 등 전문인력, 시설, 의료기관의 명부 작성
 4. 의료·방역 물품의 비축방안 및 조달방안
 5. 재난 및 위기상황별 국민행동요령, 동원 대상 인력, 시설, 기관에 대한 교육 및 도상연습 등 실제 상황대비 훈련
- 5의2. 감염취약계층에 대한 유형별 보호조치 방안 및 사회복지시설의 유형별·전파상황별 대응방안
6. 그 밖에 재난상황 및 위기상황 극복을 위하여 필요하다고 보건복지부장관 및 질병관리청장이 인정하는 사항

감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제40조의2(감염병 대비 의료·방역 물품 공급의 우선순위 등 분배기준) 질병관리청장은 생물테러감염병이나 그 밖의 감염병의 대유행에 대비하여 제40조제1항 및 제2항에 따라 비축하거나 생산한 의료·방역 물품(「약사법」에 따른 의약품 및 「의료기기법」에 따른 의료기기로 한정한다) 공급의 우선순위 등 분배기준, 그 밖에 필요한 사항을 위원회의 심의를 거쳐 정할 수 있다. 이 경우 분배기준을 정할 때에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역에 의료·방역 물품이 우선 분배될 수 있도록 노력하여야 한다.

1 화학재난

- 화학 재난 대응에 관한 내용은 ‘화학사고 위기관리 표준매뉴얼’(2021. 12) 및 ‘화학사고 위기대응 실무매뉴얼’(2022. 5.)을 따랐으며, 대응 시 ‘화학사고 위기대응 실무매뉴얼’ 최신 개정판을 참고하여 대응함

가. 정의

- 화학사고
 - 시설의 교체 등 작업 시 작업자의 과실, 시설 결함·노후화, 자연재해, 운송사고 등으로 인하여 화학물질이 사람이나 환경에 유출·누출되어 발생하는 모든 상황을 말함(화학물질관리법 제2조)

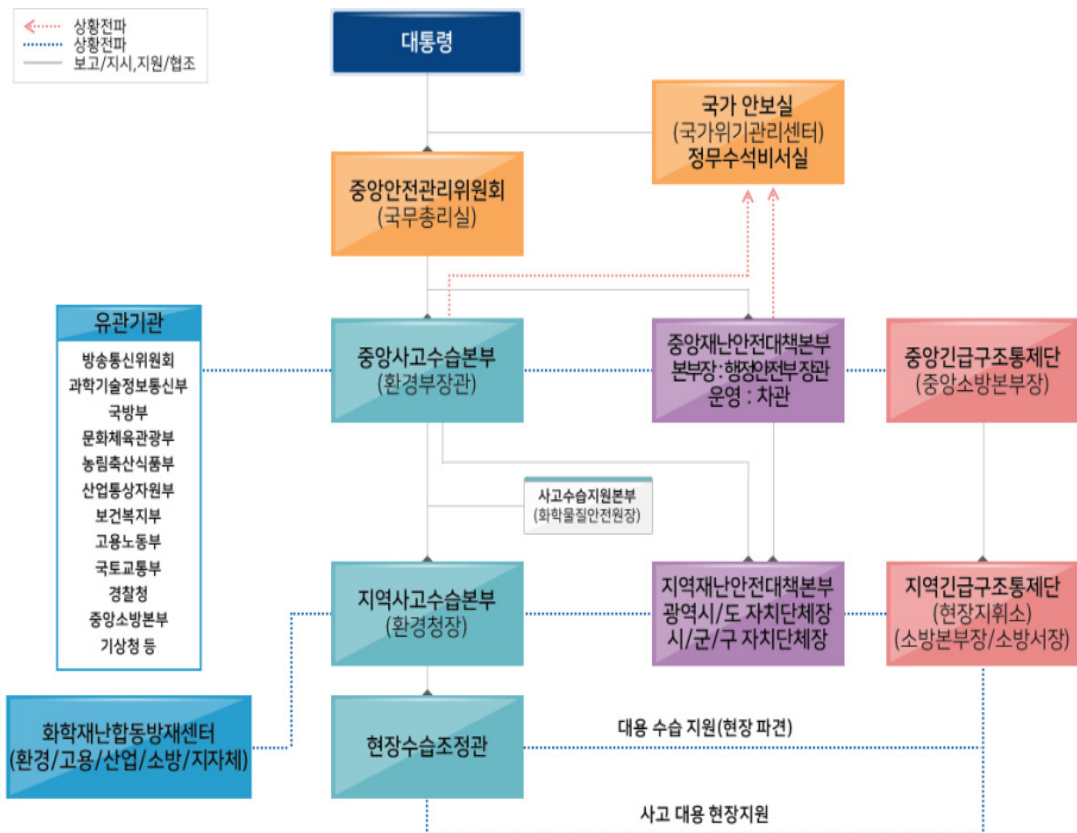
나. 화학재난 신고 및 상황전파 체계

- 화학재난 신고 및 상황 전파

- 소방(119소방본부), 경찰 등 → 화학물질안전원 → 환경청·합동방재센터 → 환경부
- 환경청·합동방재센터 → 화학물질안전원 → 환경부

다. 화학재난 지휘 및 대응체계

- 화학재난 대응체계



〈그림 18. 화학재난 지휘 및 대응체계〉

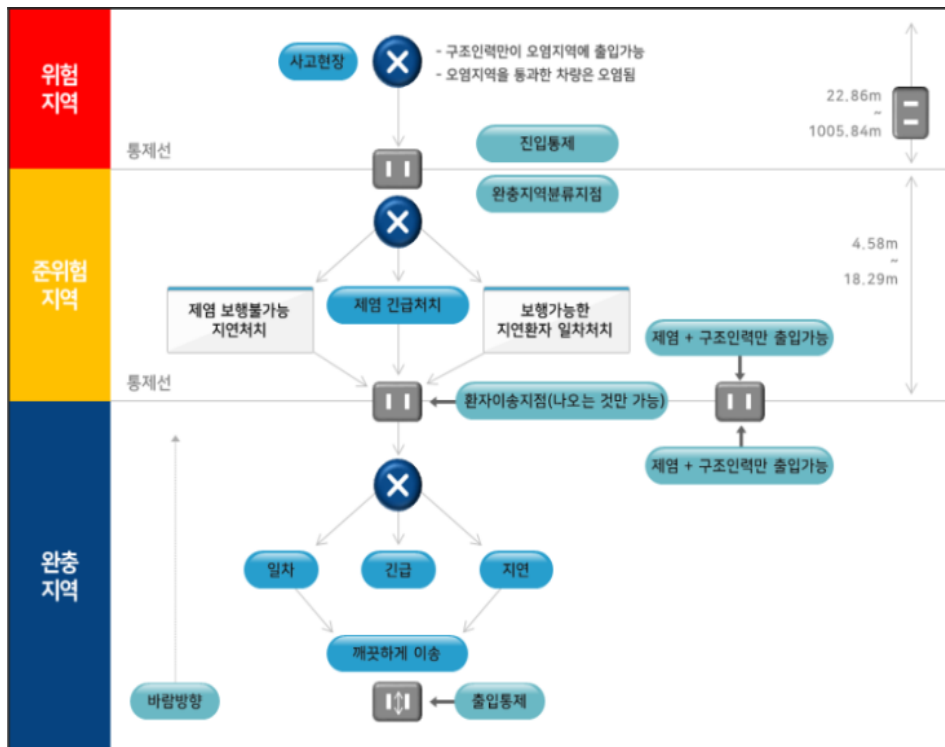
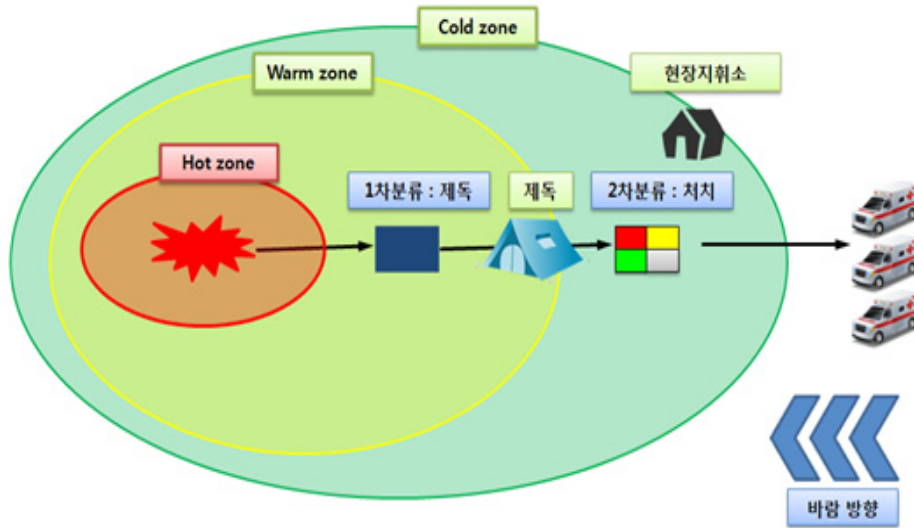


〈그림 19. 화학사고 대응 절차〉

- 대규모 화학재난 발생 시 주관기관은 환경부가 되며, 유역(지방)환경청(합동방재센터 포함)이 재난책임기관이 되고, 화학물질안전원이 대응·수습을 지원, 중·대규모 사고 시 건강영향조사 지원센터는 환자 건강 추적관리 업무를 수행함

라. 화학재난 현장의료대응

- 화학재난 대응지역



Source: J.E. Tintinalli, J.S. Stapczynski, O.J. Ma, Yealy, G.D. Meckler, D.M. Cline: Tintinalli's Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, 8th Edition.

〈그림 20. 화학재난 대응 지역〉

보호복 종류 : 미 환경보호청

수준	사진	구성 및 보호효과
Level A		SCBA(Self-contained breathing apparatus) + 전신화학물질-저항 피부복 → 최고수준 호흡기, 눈, 점막, 피부보호 ※ 물질이 잘 튀거나, 물질에 잠기거나, 물질의 기화나 증기화 여부를 예측할 수 없을 때, 작업 현장 내 물질 농도가 높고 환기가 거의 되지 않을 때
Level B		SCBA(Self-contained breathing apparatus) + 화학물질-저항 보호복, 장갑, 장화 → 최고수준 호흡기 보호, 낮은 수준 피부 보호 ※ 유해물질이 밝혀졌을 때 화학물질 노출 장소에 출입 시
Level C		공기정화기(Air purifying respirator) + 화학물질-저항 보호복, 장갑, 장화 → 낮은 수준의 호흡기 및 피부 보호 ※ 비밀 타입의 물질로 성분이 알려지고 농도가 측정되며 피부, 눈의 노출 및 흡수 가능성이 낮고 물질이 공기 청정 호흡기의 사용 기준에 맞을 때 사용
Level D		호흡보조기 없음 + 수술가운, 마스크, 라텍스 장갑 → 호흡보조기 없음, 최소 수준 피부 보호 ※ 공해 오염 시에만 일차적인 작업복으로 사용, 대기 중에 오염 물질이 존재하거나, 호흡기나 피부 독성 화학물질 존재 시 사용해서는 안됨

• 현장의료대응



〈그림 21. 화학 사고에서의 생존 사슬〉

- 상황전파를 받은 신속대응반 및 DMAT이 도착하여 화학물질 등으로부터 안전이 확보된 범위 내에서 활동함
- 물질정보가 파악되어 대응 수준을 알고 있으며 적절한 수준의 개인보호구 착용 전에는 오염 현장 활동에서 대응은 금지함

- 현장대응 시 바람을 등지는 방향에서 진입함
- 높은 수준(level)의 보호복을 착용하고 오염지역에서 활동 시 활동시간은 총 30분을 초과하지 않도록 하고, 활동 중 화학사고에 대원들이 노출되지 않도록 2차 오염방지에 힘씀
- 관계기관 협조체제와 통신을 유지하며 상황을 관리하고, 통제단에서 확산범위가 정해지면 위험 및 활동구역을 설정함
- Hot zone은 화학 물질 식별 및 일차적인 구조가 집중되는 공간이며 현장 안전과 개인보호장비 착용의 한계로 환자 처치는 제한됨
- 제염/제독이 필요하다면 warm zone과 cold zone의 경계에서 시행하되 가급적 빨리 시행하여야 효과적임
- 제염이 끝난 환자는 Cold zone에서 의료진이 진료하고 레벨 D 수준의 근무복을 착용하면 됨

제염 / 제독 종류

종류	방법	효과 및 주의점
탈의	의복 재단, 단추 풀기, 당기기 상의에서 시작하여 하의로	오염 감소 효과는 약 50-70%로 간주 옷감 내 증기도 제거하는 효과
건식	흡착재를 이용하여 피부를 닦음 얼굴, 모발에서 시작하여 아래로 내려감	표면 오염에 효과적 부식성 물질에서는 자제
습식	물과 비누를 이용하여 세척 상처에서 얼굴, 모발 순으로	오염원이 액체, 에어로졸, 가루, 먼지일 때 효과적이나 기체는 효과가 크지 않음 저체온 주의

화학물질 및 해독제 예시

화학물질	해독제
불산 혹은 불소	칼슘
시안화물	히드록소코발라민, 아질산아밀, 산소
유기인계, 카바메이트계, 신경제	아트로핀
니트릴, 황화물	아질산아밀
메트헤모글로빈 유발 물질	메틸렌 블루, 산소
질식제, 일산화탄소, 황화수소	산소
하이드라진	피리독신

2 방사선 재난

- 방사선 재난 대응에 관한 내용은 ‘원전 안전분야(방사능누출) 위기관리 표준매뉴얼(2019. 02.)’ 및 ‘원전 안전분야(방사능누출) 위기관리 실무 매뉴얼(2019. 07)’을 따랐으며, 대응 시 ‘원전 안전분야(방사능누출) 위기관리 표준매뉴얼’ 및 ‘원전 안전분야(방사능누출) 위기관리 실무 매뉴얼’ 최신 개정판을 참고하여 대응함

가. 정의

- 방사선 비상

방사성물질 또는 방사선이 누출되거나 누출될 우려가 있어 긴급한 대응 조치가 필요한 상황을 말함(원자력시설 등의 방호 및 방재 대책법, 이하 방재법 제2조)

방사선 비상 종류

구분	정의
백색비상	- 방사성물질의 밀봉상태의 손상 또는 원자력 시설의 안전상태 유지를 위한 전원공급 기능 손상이 발생하거나 발생할 우려가 있는 등의 사고 - 방사선영향이 원자력시설 건물 내에 국한될 것으로 예상되는 비상 상태
청색비상	- 백색비상 등에서 안전상태로의 복구기능의 저하로 원자력시설의 주요 안전기능에 손상이 발생하거나 발생할 우려가 있는 사고 - 방사선 영향이 원자력시설 부지 내에 국한될 것으로 예상되는 비상 상태
적색비상	- 노심의 손상 또는 용융 등으로 원자력 시설의 최후방벽에 손상이 발생하거나 발생할 우려가 있는 사고 - 방사선 영향이 원자력시설 부지 밖으로 미칠 것으로 예상되는 비상상태

- 방사능 재난

방사선비상이 국민의 생명과 재산 및 환경에 피해를 줄 수 있는 상황으로 확대되어 국가적 차원의 대처가 필요한 재난을 말함(방재법 제2조)

나. 방사선재난 신고 및 상황전파 체계

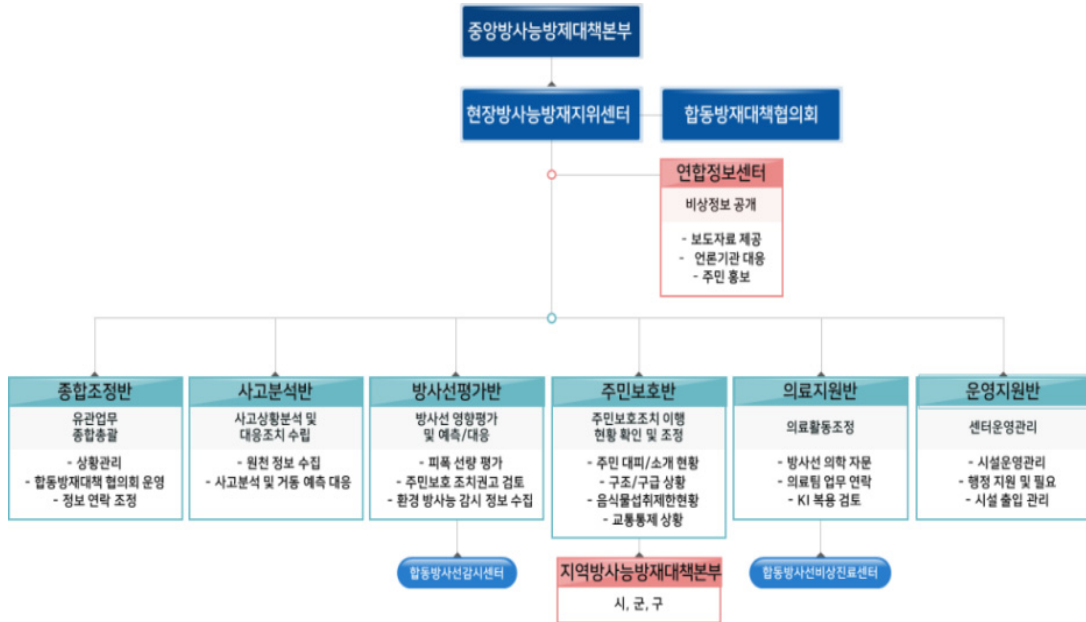
- 누구든지 원자력시설 외의 장소에서 방사성물질 운반차량·선박 등의 화재·사고 또는 방사성물질이나 방사성물질로 의심되는 물질을 발견하였을 때에는 지체없이 원자력 안전위원회, 지방자치단체, 소방관서, 경찰관서 또는 인근 군부대 등에 신고하여야 함(방재법 제22조)

- 다. 방사선재난 지휘 및 대응체계

-
- The organizational chart illustrates the structure of the National Disaster Management Organization (NDMO) and its regional branches. At the top is the **대통령** (President). Below the President is the **중앙안전관리위원회** (Central Safety Management Committee), which includes the **위원장 국무총리** (Chairman, Prime Minister). To the right of the President is the **국가안보실/대통령비서실** (National Security Council/President's Secretariat), which includes the **(국가위기관리센터/소관비서관실)** (National Crisis Management Center/Assigned Secretary's Office). A red dashed arrow labeled **(상황보고)** (Situation Report) points from the National Security Council/President's Secretariat to the President. Below the Central Safety Management Committee is the **방사능지원본부** (Nuclear Support Headquarters), which includes the **행정안전부** (Ministry of the Interior) and **유관기관** (Related Agencies) such as the **국토부, 산업부 등** (Ministry of Land, Urban Planning and Construction, Ministry of Industry, etc.). To the right of the Nuclear Support Headquarters is the **중앙방사능방재대책본부** (Central Nuclear Disaster Response Headquarters), which includes the **본부장 국무총리(법정부 통합대응시)** (Headquarters, Prime Minister (during integrated response by the Ministry of Government Administration)), the **차장 원자력안전위원회 위원장** (Deputy Head, Chairman of the Nuclear Safety and Security Commission), and the **본부장 원자력안전위원회 위원장** (Headquarters, Chairman of the Nuclear Safety and Security Commission). A red dashed arrow labeled **상황보고 정보전파** (Situation Report Information Dissemination) points from the Central Nuclear Disaster Response Headquarters to the National Security Council/President's Secretariat. Below the Central Nuclear Disaster Response Headquarters is the **현장지휘** (On-site Command) box, which includes the **현장방사능방재지휘센터** (On-site Nuclear Disaster Response Command Center) and the **센터장 원안위 사무처장** (Center Head, Office of the Nuclear Safety and Security Commission). Below the On-site Command box are four boxes: **방사능방호 기술지원본부 원자력안전기술원** (Nuclear Radiation Protection Technology Support Headquarters, Nuclear Safety and Security Technology Research Institute), **비상대책지원본부 원너지력사업자** (Emergency Response Support Headquarters, Nuclear Power Plant Operators), **방사선비상 의료지원본부 원자력의학원** (Radiation Emergency Medical Support Headquarters, Korea Atomic Energy Research Institute), and **시·도 지역방사능 방재대책본부 지방자치단체 (시·도)** (City/Provincial Regional Nuclear Disaster Response Headquarters, Local Governments (City/Provincial)). Below these four boxes are two boxes: **원자력시설 비상대책본부 (원자력사업자)** (Nuclear Facility Emergency Response Headquarters (Nuclear Power Plant Operators)) and **시·군·구 지역방사능 방재대책본부 지방자치단체 (시·군·구)** (City/County/District Regional Nuclear Disaster Response Headquarters, Local Governments (City/County/District)). Below these two boxes is the **지역 긴급구조통제단(현장지휘소)** (Regional Emergency Response Control Unit (On-site Command Post)), which includes **소방, 119구조대, 경찰, 해양경찰, 군부대, 보건소, 병원 등 지역공공기관** (Fire, 119 Emergency Response Team, Police, Marine Police, Military Units, Health Centers, Hospitals, etc. Regional Public Institutions). A legend at the bottom right indicates the types of lines: **— 지휘·통제** (Command/Control), **····· 협조·지원** (Cooperation/Support), and **- - - 상황보고** (Situation Report).

〈그림 22. 국가 방사능 방재체계〉

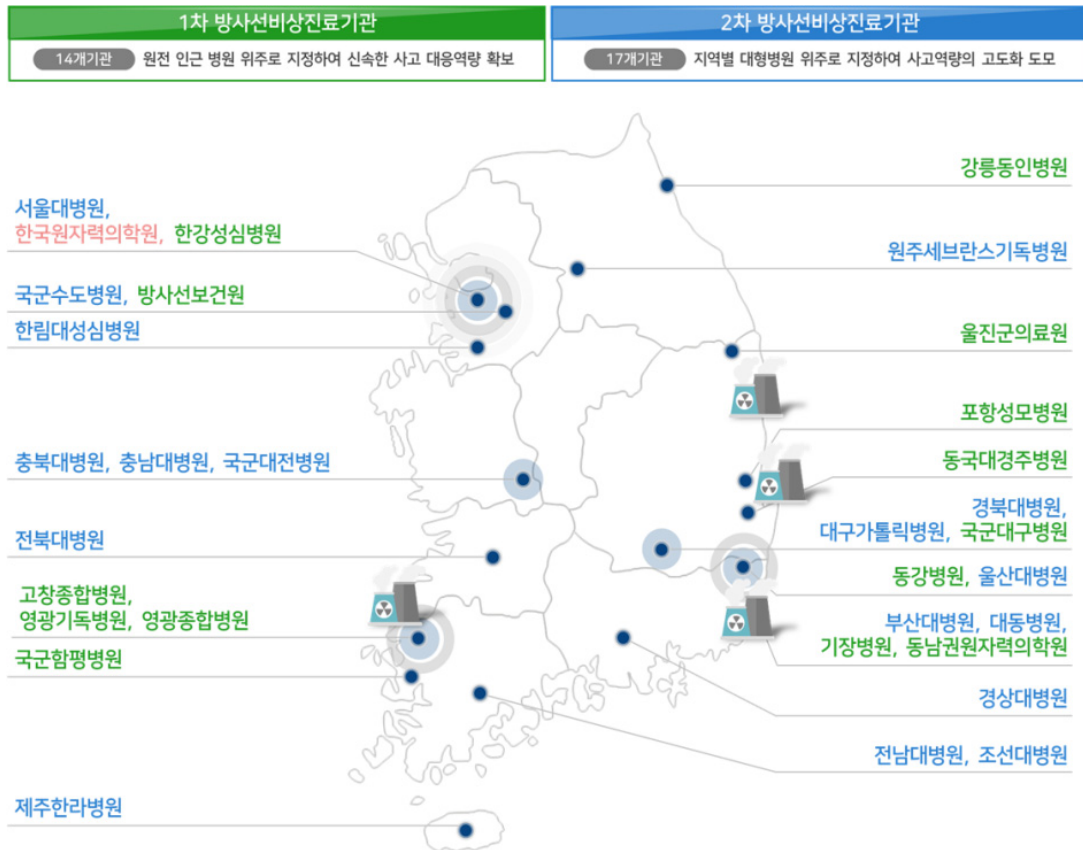
- 현장 방사능방재지휘센터(원전 사고 대응)



〈그림 23. 현장 방사능방재지휘센터(원전 사고 대응)〉

- 방사선비상진료기관

- 방사선사고 시 신속한 의료대응과 진료수준 제고를 위해 원자력안전위원회에서 전국 31개 의료기관을 1,2차 방사선비상진료기관으로 지정하고 있으며, 한국원자력 의학원(국가방사선비상진료센터)이 방사선 비상의료지원본부의 역할을 수행함
- 이들 기관은 응급진료·제염·계측장비 및 방호약품을 구비하고 비상진료팀을 운영하고 있으며, 교육·훈련 및 장비관리 업무를 수행중임



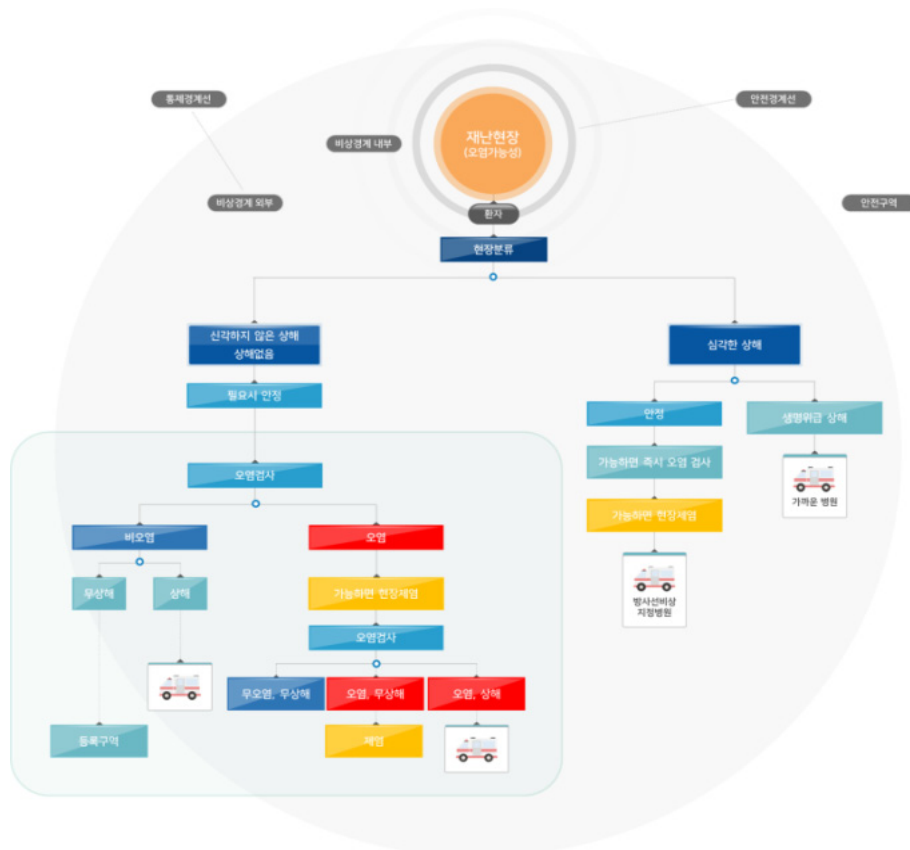
〈그림 24. 전국방사선비상진료기관 현황(2020년 11월 기준)〉

방사선 비상진료기관별 역할

1차 진료기관의 역할	2차 진료기관의 역할
• 외래에서 대처 가능한 의료를 원칙으로 함 • 사고현장 주민 응급의료구호 • 현장에서의 1차 제염 및 응급처치 • 방사능사고로 인한 오염 및 피폭에 관한 진단 • 2차 지정의료기관 및 중앙의료기관으로의 환자 이송 • 주민 소개소 또는 이재민센터 등에서 전개되는 의료구호활동 지원 • 관내 의료자원(인력, 장비)의 동원 • 방사선피폭환자에 대한 기록 보존 및 비상진료 센터를 경유하여 원자력안전위원회에 보고 • 방사선비상진료교육 참여	• 입원 및 전문치료(내부오염 치료, 조혈모세포 이식, 화상치료 등) • 제염설비, 무균실, 수술실, 선량측정 장비 등의 시설과 장비를 활용한 진료 제공 • 사고현장 1차 지정 의료기관과의 합동방사선 비상진료활동 • 중앙의료기관 현장파견팀 도착 전까지의 합동 방사선비상진료활동 주도 • 방사선피폭환자에 대한 기록 보존 및 비상진료 센터를 경유하여 원자력안전위원회에 보고 • 방사선비상진료교육 참여

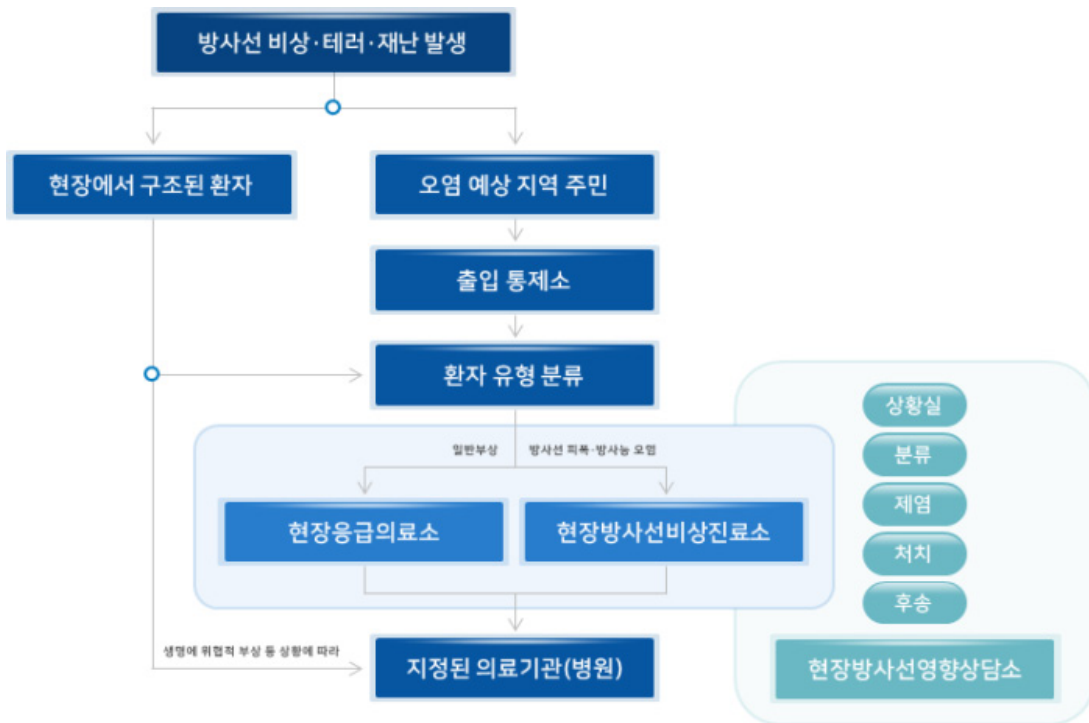
라. 방사선재난 현장의료대응

- 현장응급의료 개요
 - 방사선 물질 관련 사고에 대해서는 방사선 비상진료체계를 우선 가동하고, 방사선 비상진료체계에 의한 대응 부족 시 출동 요청
 - 방사선비상진료기관은 오염환자에 대한 처치를 담당함
 - 보건소와 응급의료기관에서 파견된 DMAT의 현장에서의 역할은 오염되지 않은 사상자에 대한 중증도분류·응급처치·이송임
 - 방사선 피해자가 외상을 동반한 복합손상 및 기저질환으로 인해 생명이 위협적인 상태인 경우에는 지체없이 응급조치를 우선적으로 수행하여야 함
 - 현장 대응하는 모든 인력 및 의료기관에서 피폭된 환자에 대응하는 모든 인력은 피폭량 판독을 위해 개인선량계를 착용하여야 함. 개인선량계를 좌측 흉부에 착용하는 것이 권장됨



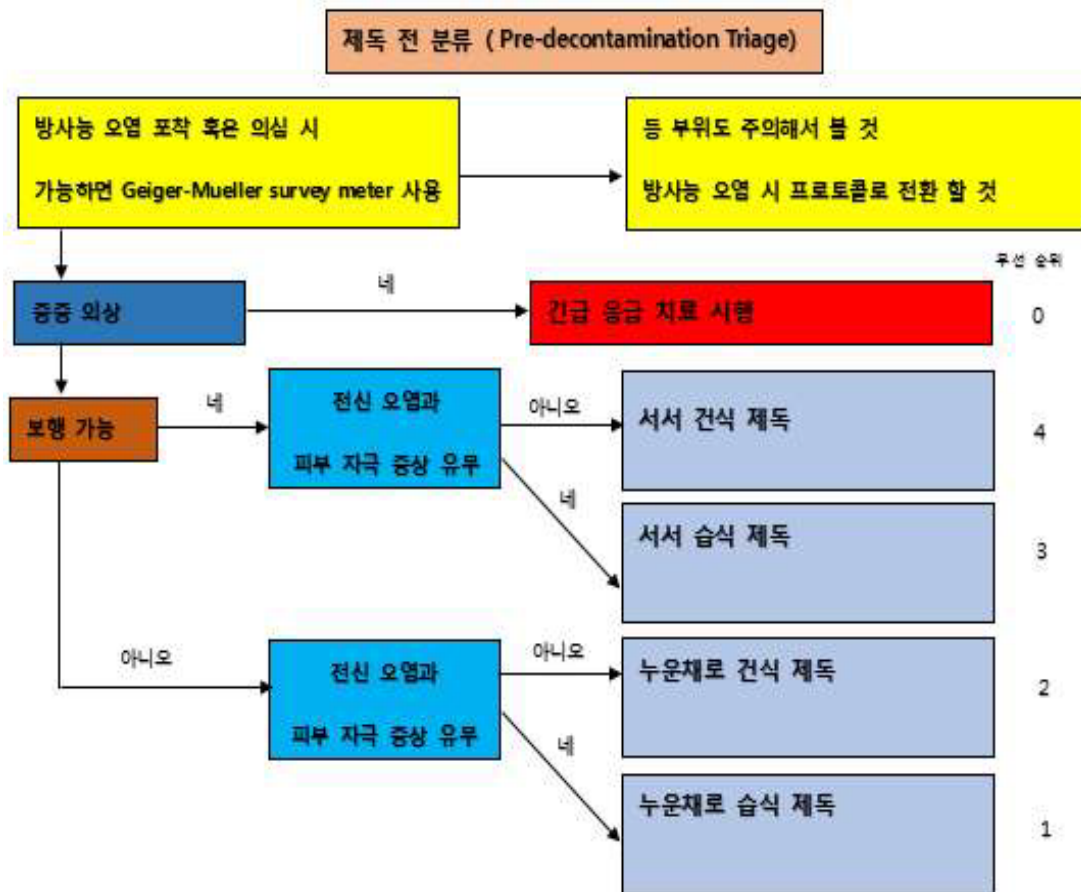
〈그림 25. 방사선 재난 현장의 의료대응 개요〉

- 환자 흐름도에 따른 현장방사선비상진료소 운영



〈그림 26. 환자 흐름도에 따른 현장 방사선 비상진료소 운영〉

- 현장의료대응 제공 시 환자분류 중 일반상해와 방사선상해로 구분은 지자체 방사능 방재요원이나 기타 방사선오염측정기 운영이 가능한 요원, 또는 방사선비상진료기관에서 가능하며 현장방사선비상진료소는 방사선비상진료 지정기관이 설치하고 운영함
- 방사능 오염(방사선 상해) 및 비오염(일반 상해) 환자를 구분하기 위해서는 방사선계측 장비가 필요하며, 방사능 방재 유관 기관(방사선비상진료기관, 권역응급의료센터, 원자력 관계 사업자, 지자체, 군, 경, 소방 등)에서 보유하고 있음
- 방사선학적 상해자의 분류 방법은 의학적 비오염 손상으로 인한 상해자 분류와 차이가 있음



〈그림 27. 방사선학적 피해자의 오염 전 분류〉

- 현장응급의료소에서 방사능 오염자 발견 시 조치 요령
 - 기본적으로 방사선비상진료기관은 오염환자에 대한 처치를 담당하며, 보건소와 응급 의료기관에서 파견된 DMAT의 역할은 오염되지 않은 사상자에 대한 중증도분류·응급처치·이송임
 - 생명에 위협적인 손상에 대해서는 지체 없이 응급처치를 실시함(예 : 주요 출혈 부위의 지혈, 기도 확보, 긴장성 기흉에 대한 감압술 등)
 - 방사능 오염이 의심된다는 이유로 응급처치가 지연되어서는 안 됨
 - 개인 보호 장구의 착용함(방사능 사고에 대한 의료대응은 Level D 수준으로도 충분한 방사선방호가 가능함)

- 대응요원의 피폭량을 감시하기 위한 개인선량계 및 방사능 대량 노출 시 오염 여부를 신속하게 판단하기 위한 이동식 외부오염감시기 및 표면오염감시기 활용이 필요함. 이를 위해 방사선 계측장비를 보유하고 있는 현장에 파견된 관계기관(군·경·소방·방사선비상진료기관 등)에게 관련 장비 지원 요청
- 현장의 제염/제독은 화학 재난 시의 방법을 따름. 탈의 및 습식 제염으로 오염의 95% 이상을 감소시킬 수 있음
- 탈의 시 시트 3장을 사용하여 통나무 굴리기와 의복 재단을 이용하여 오염된 의복을 제거하고 탈의 후 전신 계측이 필요함. 습식 제염 시에는 전신 제염 → 방사선 파편 제거 → 개방 상처 → 신체 개구부 → 계측 시 가장 오염도가 높은 피부 순으로 시행함
- 방사선학적 상해자의 주요 관찰 대상인 임상적 증상 및 징후는 구토, 오심, 설사, 홍반 또는 발적, 림프구수 분포 5가지임
- 현장방사선비상진료소가 개소된 경우에는 환자를 인계함
- 대량 피폭 환자의 처치는 원자력의학원 혹은 방사선비상진료소와 상의가 필요함

방사선 사상자의 증상 및 징후

구분	1군	2군	3군
추정피폭 선량	< 2 Gy	2-6 Gy	> 6 Gy
증상 발현까지 시간	12시간 이하	5시간 이하	30분 이하
구토 (24시간 내)	1회 이상	1-10회	10회 이상
오심	+	+++	(-)
설사 (24시간 내)	2-3회	2-9회	10회 이상
홍반	(-)	+/-	+++
림프구수 (24시간 내)	1500/ul 이상	1500/ul 이하	500/ul 이하

- 방사선비상진료체계가 활성화되기 전 단계에서는 한국원자력의학원 사고접수 응급전화 (02-3399-5959)로 연락하여 후송병원 배정 요청하며, 오염되지 않고 피폭만 된 환자는 특별한 절차 없이 이송하되 오염된 환자의 이송 시에는 원자력의학원 혹은 방사선비상진료소와 상의가 필요함
- 대응과정에서 방사선 피폭 우려가 있는 경우 한국원자력의학원과 상의하여 후속 대책 강구함

3 감염병 재난

- 감염병 재난 대응에 관한 내용은 ‘감염병 재난 위기대응 표준매뉴얼(2019. 02.)’, 감염병 재난 위기관리 실무 매뉴얼(2019. 07)’ 및 ‘검역업무지침(2020)’을 따랐으며, 대응 시 ‘감염병 재난 위기대응 표준매뉴얼’ 감염병 재난 위기관리 실무 매뉴얼’ 최신 개정판을 참고하여 대응함

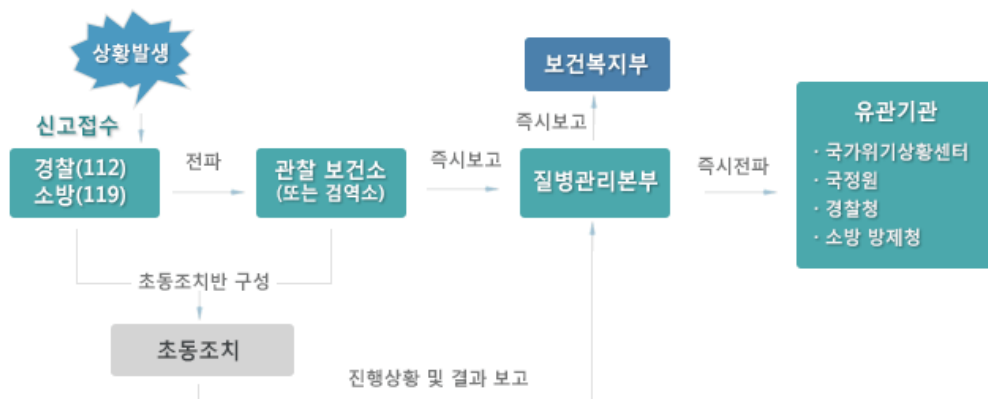
가. 정의

- 감염: 감염병의 병원체가 사람의 몸에 침입하여 질병을 유발하는 모든 경우를 통칭함
- 생물테러: 잠재적으로 사회 붕괴를 의도하고 바이러스, 세균, 곰팡이, 독소 등을 사용하여 살상을 하거나, 사람, 동물 혹은 식물에 질병을 일으키는 것을 목적으로 하는 행위
- 생물테러감염병: 고의 또는 테러 등을 목적으로 이용된 병원체에 의하여 발생한 감염병 중 질병관리청장이 고시하는 감염병(탄저, 보툴리눔독소증, 페스트, 마버그열, 에볼라열, 라싸열, 두창, 야토병)
- 신종 및 재출현 감염병: 기존에 알려지지 않은 새로운 감염병 및 과거에 사라졌다가 다시 발생한 감염병
- 대유행(Pandemic): 전세계적으로 새로운 감염병이 퍼지는 것

* 기술하지 않은 사항은 질병관리청 생물테러감염병 대비 및 대응 지침과 감염병 재난 표준 매뉴얼, 개별 질환별 매뉴얼을 따름

나. 감염병재난 신고 및 상황전파 체계

- 생물테러 감시 및 전파



〈그림 28. 생물테러 감시체계와 운용〉

다. 감염병재난 의료대응

- 신종감염병, 대유행 감염병은 “감염병 재난 위기관리 표준매뉴얼 (보건복지부, 질병관리청)”을 따르고, 생물테러 감염병은 “생물테러감염병 대비 및 대응지침(질병관리청)”을 따름
- 감염병 비상진료기관
 - 감염병예방법 제36조(감염병 관리기관의 지정 등), 제37조(감염병위기 시 감염병 관리기관의 설치 등)에 따라 관할 및 인근 지역 감염병 관리기관 지정
- 생물테러감염병 발생 시 대응
 - 소방에서 환경검체 채취 후, 3중용기에 밀봉하여 보건기관(예. 보건환경연구원)에 전달
- 생물테러감염병 개인보호장비 착용 기본원칙
 - 생물테러감염병 의심병원체 확인을 위한 검체 채취 활동을 수행하는 모든 사람들은 보호복 및 보호 장비 등의 착용을 원칙으로 함
 - 노출지역에서 검체를 채취하는 경우 노출지역과 인접한 관찰지역에서 보호복을 착용하고 노출지역으로 이동하여 활동해야 함
 - 채취 활동 후에는 노출지역과 인접한 관찰지역에서 제독(소독) 완료 후 보호복을 벗어야 함

생물테러감염병별 권장 착용 보호복 및 구성 물품

구분	현장용	의료기관용
탄저 페스트 야토병	Level C급 보호복 생물 작용제 제거 가능 정화통이 달린 전면형 면체	Level D급 보호복 N95 혹은 KF 94급 마스크(필요시 PAPR*)
에볼라열 마버그열 라싸열	Level C급 보호복 생물 작용제 제거 가능 정화통이 달린 전면형 면체	Level C급 보호복 N95 혹은 KF 94급 마스크 안면보호구, 앞치마(필요시 PAPR*)
두창	Level A급 보호복, 공기호흡기	Level C급 보호복, PAPR
보툴리눔 독소증	Level C급 보호복 생물 작용제 제거 가능 정화통이 달린 전면형 면체	Level D급 보호복 N95 혹은 KF 94급 마스크(필요시 PAPR*)

* PAPR : Powered Air Purifying Respirator

- 신종 감염병 및 대유행 감염병 개인보호장비 착용원
 - 전파양식에 따라서 호흡기전파 감염병은 Level D급 보호복에 N95 호흡구 또는 PAPR을 착용하고, 바이러스 출혈열 등 체액접촉에 의한 전파가 가능한 감염병은 Level C급 보호복에 N95 호흡구 또는 PAPR을 착용함. 추후 전파양식이 더 확실해지면 지침에 따라 보호구 수준을 조정

XI 장

부록



1. 현장응급의료 인력의 복장
2. 현장 의료지원 가용인력의 사전 등록
3. 중증도분류표 서식
4. 병원별 수용능력표
5. 사상자 이송현황
6. 환자등록지(예시)
7. 신속대응반 활동보고서
8. DMAT 활동보고서
9. 재난거점병원 시설·장비 현황
10. PS-LTE 사용방법(사이버텔브릿지)
11. PS-LTE 사용방법(블루버드)
12. 화학사고 대응기관 연락처
13. 방사선비상진료기관 연락처
14. 재난 대비·대응 활동 체크리스트

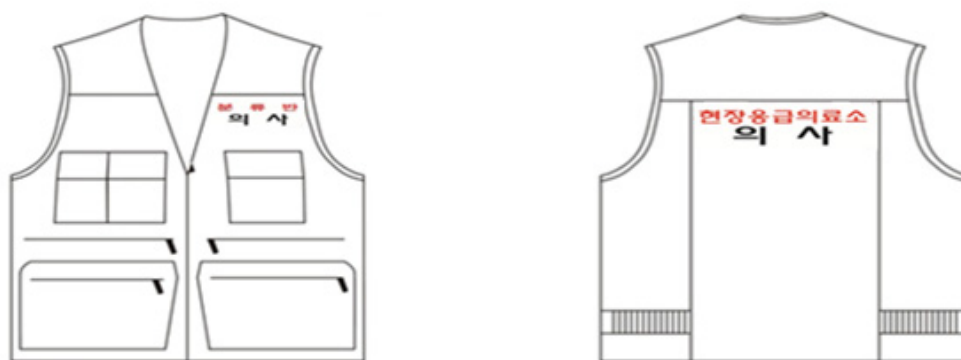
부록1 현장응급의료 인력의 복장

- 의료소장 및 각 반의 반원은 소속과 역할이 구분된 표준 복장을 착용(「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」제20조 제8항 별표6의2)
- 표준화된 복장은 각 보건소 및 재난거점병원에 비치하고, 현장 출동 시 구비된 복장을 착용

• 동절기



• 하절기



• 색 상 : 전체 흰색 재 질 : 폴리에스테르 100% 글씨체 : 견고딕

• 글씨색 : 붉은색 및 검정색

※ 복장은 의료소장, 의사, 간호사 및 지원요원으로 각각 표시하고, 각 반별 구분이 가능하도록 소속에 따라 분류반, 응급처치반 및 이송반으로 표시

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

부록2 현장 의료지원 가용인력의 사전 등록

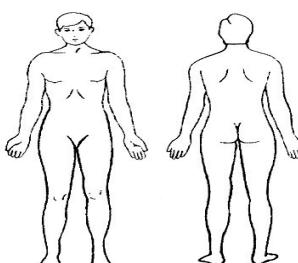
- 재난거점병원 또는 보건소는 통제단장이 미리 발급한 재난현장 출입증을 보관하고, 출동 요청이 있는 경우 DMAT이나 신속대응반에게 파견 명령과 함께 재난현장 출입증을 지급
- 출동 명령을 받은 DMAT 및 신속대응반은 재난현장 출입증을 소지하고 재난현장에 출동하여 현장 응급의료 지원 업무를 수행

(앞 면)	(뒷 면)
출 입 증 이 증을 소지한 사람은 재난 현장 통제선 출입을 허가합니다. 긴급구조통제단장 (00 소방서)	No. 0000 유 의 사 항 1. 재난현장 출입 시에는 본 증을 출입 통제 요원에게 제시하시기 바랍니다. 2. 분실 또는 훼손된 경우에는 해당 소방서로 연락하시기 바랍니다. 긴급구조통제단장 (00 소방서)

* 「긴급구조대응활동 및 현장지휘에 관한 규칙」제17조 제4항 서식 1

부록3 중증도분류표 서식

긴급구조현장지휘규칙 제22조 제3항 관련

중증도 분류표		일련번호
보행여부: 가능 / 불가능		호흡: 정상 / 비정상
맥박: 정상 / 비정상		의식: 정상 / 비정상
분류자:		0 ● I ● II ● III ●
분류시간:		
이름:	나이:	성별: 남 / 여
발견된 장소:		
 주요 손상명 및 처치		
생체징후	혈압 / 호흡	맥박 의식
구급차	119 / 119 외	
이송의료기관		
이송(출발)시간		
 사  긴  응  비  망  급  급  응  망  급  급  응		

비고

1. 일련번호는 연번으로 작성합니다.

2. 사상자를 이송하는 이송반장 또는 이송반원은 위 중증도 분류표 중 1부는 이송반에 보관하고, 나머지 1부는 이송의료기관이 보관할 수 있도록 인계해야 합니다.

※ 제작방법: 중증도 분류표는 2장으로 만들되 각 장이 동시에 기록될 수 있도록 하며, 환자의 분류 부분은 떼어 낼 수 있도록 제작합니다.

부록5 사상자 이송현황

긴급구조현장지휘규칙 제24조 제3항 별지 제2호 서식

사상자 이송현황

수신 : _____ 발신 : _____

연번	성명	성별	연령	주증상 (손상원인)	이송 병원	중증도 분류 (해당란 √)				발견 지점	이송수단 (해당란 √)				출발 시간
						긴급	응급	비응급	사망		119	병원	이송업자	기타	
1		남/여													:
2		남/여													:
3		남/여													:
4		남/여													:
5		남/여													:
6		남/여													:
7		남/여													:
8		남/여													:
9		남/여													:
10		남/여													:
11		남/여													:
12		남/여													:
13		남/여													:
14		남/여													:
15		남/여													:
16		남/여													:
17		남/여													:
18		남/여													:
19		남/여													:
20		남/여													:
21		남/여													:
22		남/여													:
23		남/여													:
24		남/여													:
25		남/여													:
☐ 작성자 : 소속 _____ 직급 _____ 성명 _____ (서명 또는 인)															

210mm×297mm[일반지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

I 긴급 D 응급 M 비응급 E 사망예상

기록자:

124 / Ministry of Health and Welfare

부록7 신속대응반 활동보고서

_____사고 관련 신속대응반 활동보고서

20 . . 000 보건소

<<사고 개요>>

- 일 시 :
- 장 소 :
- 사고경위 :

□ 현 황

- 최종 인명피해(기준일시:20 . . 00시 00분)

총 사상자: 명 (긴급: 명, 응급: 명, 비응급: 명, 사망: 명)					
이송 의료기관	계(환자 수)	중상		경상	사망
		긴급	응급	비응급	
합 계					

□ 재난응급의료 지원 현황(인력)

- 현장응급의료소 운영현황(총 명)

연번	중앙응급의료센터 (명)	DMAT(명)			보건소 (명)			
		직종	역할	이름	현장인원	병원파견 인원		

* 역할 예시) 소장, 소장보조, 연락관, 분류반장, 분류반원, 처치반장, 처치반원, 이송반장, 이송반원, 기타

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

□ 재난응급의료 지원 현황(장비)

- 현장응급의료소 운영 처치 물품:
- 현장응급의료소 운영 행정 물품:
- 현장응급의료소 운영 지원 물품: 약품 등..
- 현장응급의료소 텐트 :

□ 현장응급의료소 운영 실적(필요 시 작성)

- 진료 실적(기준일시:20 . . 00시 00분)

현장응급의료소 진료실적: 총 명 (긴급: 명, 응급: 명, 비응급: 명, 사망: 명) → 이송: 명, 귀가: 명					
이송 의료기관	계(환자 수)	중상		경상	사망
		긴급	응급	비응급	
합 계					

□ 시간대별 조치사항

시간*	조치사항	비고
:	○ 상황수신	
:	○ 출동(보건소)	
:	○ 출동(DMAT)	
:	○ 현장도착(보건소)	
:	○ 현장도착(DMAT)	
:	○ 현장지휘체계의 확인 및 연계 · 000(보건소장 또는 보건소보다 먼저 도착시에는 현장 지휘관 등)에게 도착 보고 · 임시의료소의 진료 내용을 인계받았는지	
:	○ 현장 안전 확보 · 현장 안전에 대한 직접 확인 또는 구두 확인 여부 · 출동자 개인안전보호장구 착용했는지 확인(마스크, 헬멧 등)	

시간*	조치사항	비고
:	○ 통신체계 구성 · 현장 통신상태 양호했는지 여부 및 PS-LTE 통화그룹 확인 여부 - 중앙응급의료상황실과의 통신 확보(예: 모바일상황실) - 현장지휘소(또는 긴급구조통제단)과의 통신 확보 (예: 연락관 또는 소방용무전기) - 현장응급의료소 내부 통신 확보(예: PS-LTE 의료소 채널)	
:	○ 현장의료수요 파악 · 인명피해 규모 파악 및 상황 전파 - 구조된 환자 및 기이송된 환자 파악 - 피해자 예상규모 및 중증도 파악 (어려운 경우 관계자로부터 건물 내 상주인력 확인) - 중앙응급의료센터 모바일 상황실을 통한 상황전파 시행 · 추가의료지원 필요 여부 결정 및 요청 예: 대응인력(DMAT, 신속대응반 추가) 이송자원(구급차, 민간구급차, 재난버스, 헬기, 등) 대응물품(지자체, 재난의료지원차량, 지역 약사회 등)	
:	○ 현장응급의료 시행장소 선정 · 현장응급의료소 위치 등 적절성 판단 등 - 안전 확보, 외부인 차단, 적절한 면적, 환자집결지 동선 고려, 구급차 입출입로 동선 고려, 가능한 건물, 그늘 및 전기운영이 가능한 곳 등 예) 흑한의 날씨로 환자 저체온증 발생 가능성 있어 인근 건물 등 으로 현장응급의료소 위치 이동 필요 의견 전달 예) 재난 현장 인근에 환자와 구급차의 접근과 집결이 용이한 의료기관이 있어 현장응급의료소 선정 의견 전달	
:	○ 중증도분류 - 분류 결과 기재	
:	○ 응급처치 - 주요 처치를 시행한 경우 기재	
:	○ 이송 · 사상자 이송현황 파악 및 분산 이송 지도 예) 보건소, 소방과 협력하여 사상자 이송 현황 파악 예) 인근 응급의료기관 이송 풀림 현상으로 분산 이송 지도 · 이송병원 선정 지도 예) 중증화상 환자 화상전문병원으로 이송 지도 예) 중증외상 환자 권역외상센터로 이송 지도	
:	○ 현장상황 파악 :	
:	○ 사상자 중간 집계 :	

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

시간*	조치사항	비고
:	○ 현장상황 파악 :	
:	○ 사상자 중간 집계 :	
:	○ 현장상황 파악 :	
:	○ 철수결정	
:	○ 현장상황 파악 :	
:	○ 사상자 최종 집계 :	
:	○ 철수	

* 시간표시: 24시간

+ 현장상황 파악 및 사상자 집계 횟수는 상황에 따라 유동적으로 변경가능

작성일시: . . 작성자: (서명) 확인자: (서명)

부록8 DMAT 활동 보고서

○○○ 재난의료지원팀 활동 보고서

- ☐ 사건명:
- ☐ 출동요청일시:
- ☐ 출동요청자: ○119 ○중앙응급의료센터 ○기타 ()
- ☐ 출동자

번호	성명	직종	출동일시	현장 도착일시	현장 철수일시
1	○○○	의사	10:00	10:10	10:30
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

※출동일시는 병원출발일시로 기술

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

□ 주요활동내용

체크	활동내용	세부 활동내용
☐	현장지휘체계의 확인 및 연계	· 000(보건소장 또는 보건소보다 먼저 도착시에는 현장 지휘관 등)에게 도착 보고 · 임시의료소의 진료 내용을 인계받았는지
☐	현장 안전 확보	· 현장 안전에 대한 직접 확인 또는 구두 확인 여부 · 출동자 개인안전보호장구 착용했는지 확인(마스크, 헬멧 등)
☐	통신체계 구성	· 현장 통신상태 양호했는지 여부 및 PS-LTE 통화그룹 확인 여부 - 중앙응급의료상황실과의 통신 확보(예: 모바일상황실) - 현장지휘소(또는 긴급구조통제단)과의 통신 확보(예: 연락관 또는 소방용무전기) - 현장응급의료소 내부 통신 확보(예: PS-LTE 의료소 채널)
☐	현장의료수요 파악	· 인명피해 규모 파악 및 상황 전파 - 구조된 환자 및 기이송된 환자 파악 - 피해자 예상규모 및 중증도 파악 (어려운 경우 관계자로부터 건물 내 상주인력 확인) - 중앙응급의료센터 모바일 상황실을 통한 상황전파 시행 · 추가의료지원 필요 여부 결정 및 요청 예: 대응인력(DMAT, 신속대응반 추가) 이송자원(구급차, 민간구급차, 재난버스, 헬기, 등) 대응물품(지자체, 재난의료지원차량, 지역 약사회 등)
☐	현장응급의료 시행장소 선정	· 현장응급의료소 위치 등 적절성 판단 등 - 안전확보, 외부인 차단, 적절한 면적, 환자집결지 동선 고려, 구급차 입출입로 동선 고려, 가능한 건물, 그늘 및 전기운영이 가능한 곳 등 - 후한의 날씨로 환자 저체온증 발생 가능성 있어 인근 건물 등으로 현장응급의료소 위치 이동 필요 의견 전달 - 재난 현장 인근에 환자와 구급차의 접근과 집결이 용이한 의료기관이 있어 현장응급의료소 선정 의견 전달
☐	중증도분류	· 다빈도 손상종류 - 화상, 연기흡입, 중증외상, 외상 등
☐	응급처치	· 주요 처치내역 - 산소투여, 화상치료, 외상초기 등
☐	이송	· 사상자 이송현황 파악 및 분산 이송 지도 - 보건소, 소방과 협력하여 사상자 이송 현황 파악 - 인근 응급의료기관 이송 풀림 현상으로 분산 이송 지도 · 이송병원 선정 지도 - 중증화상 환자 화상전문병원으로 이송 지도 - 중증외상 환자 권역외상센터로 이송 지도
☐	기타 현장응급의료 활동	· 의료지도: 구급대원 처치 지도, 기타 의학적 판단 후 개입 등 · 언론보도: 통일성 있는 언론대응을 위해 현장지휘소 확인 등 · 관련보고: 현장응급의료소 운영사항 보고 등

☐ 건의 및 개선사항

작성일시: ____ . ____ . ____ 작성자: _____ (서명) 확인자: _____ (서명)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

부록9 재난거점병원 시설·장비 현황

표 1. 재난응급의료 대응을 위한 재난거점병원 기준

분류	내용
계획	○ 원내 재난 대응 계획 수립 - 원내 재난 시 인력 동원 계획 - 다수 환자 수용 계획
인력	○ 3개 이상의 재난의료지원팀을 구성하고 요청 시 즉시 출동 ○ 재난의료책임자 지정 ○ 재난의료관리자(국립중앙의료원에서 파견) 근무
시설	○ 권역응급의료센터 법정기준(응급의료법 시행규칙 제13조제2항) 시설 - 음압·일반격리병상, 재난 및 응급의료지원실 등 ○ 응급실 일일 내원환자 2배 혹은 200병상 규모의 예비병상 - 평소 진료공간이 아닌 로비, 휴게실, 복도 등의 공간에 간이침대 등을 이용 - 환자 진료를 위한 부속시설(의료가스·음압공급 유닛 등)과 장비(간이침상, 수액걸이 등)를 갖추어야 함 ○ 화학·방사능재난 등에 대응할 수 있는 제염·제독시설 - 고정형/이동형 가능(고정형 권고) - 운수제공이 가능하며, 독립된 오·폐수 시설을 갖출 것 - 응급환자 진료구역 또는 인접한 곳에 설치할 것 - 각 제염·제독시설은 동시에 2명 이상이 제염·제독을 할 수 있도록 할 것(권고) ○ 헬기착륙장(권고) - 「항공법」에 따른 착륙장의 설치기준 준수
장비	○ DMAT bag 1세트 이상 - 「재난응급의료 비상대응매뉴얼」상 표준사양 참고 ○ Level C 보호복 12개 이상 - DMAT 3개 팀원 수 고려 ○ 방사능 계측기 3개 이상(1개 필수, 3개 권고) ○ 의료진 출동차량(구급차 가능) ○ 재난의료지원차량: 현장응급의료소용 경량텐트(1동) 포함 - 「재난의료지원차량 관리 지침」 참고 ○ 재난안전통신망(PS-LTE)

표 2. 재난의료지원차량 내 보유 장비 및 물품

* 다음의 재난의료지원차량 구성안은 최소한으로 구성해야 하는 물품이며, 각 재난거점병원의 판단에 따라 품목의 종류나 수량을 증가할 수 있으며, 같은 기능을 가진 다른 물품으로 교체도 가능함

① 의료장비

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
환자감시	제세동기	EA	2	
	이동형 환자감시장치	EA	2	
기도삽관	기도삽관세트(후두경)	EA	2	
산소공급	산소분배기	EA	2	
	산소발생기	EA	2	
	백밸브마스크(소아/성인)	EA	10	
진단	휴대용 초음파	EA	1	
	청진기	EA	2	
	펜라이트	EA	5	
	EMT 가위	EA	5	
	체온계	EA	2	
	혈압계	EA	5	
	혈당측정기	EA	2	
	이경	EA	2	
외상	검안경	EA	1	
	에어 부목	EA	10	
	와이어 부목	EA	10	
	경추보호용 고정대	EA	20	
	척추보호판	EA	3	
	스쿱 또는 분리형 들것	EA	2	
진료	스트레처 카트	EA	1	
	눈보호용 고글	EA	5	
	차트판	EA	5	
흡인	필기구	EA	10	
	마질포셉	EA	2	
흡인	흡입기(자동/수동)	EA	2	

② 의료소모품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
환자 감시	제세동기 기록지	EA	2	
	제세동 패드	EA	5	
	심전도 전극	EA	100	
	젤리	EA	4	
기도 삽관	스타일렛	EA	2	
	기관삽관고정기(성인/소아)	EA	20	성인용 5개, 소아용 15개
	기관삽관튜브	EA	20	3.5~8.0Fr 2개씩, 7.5Fr는 5개 이상
	후두마스크기도기(LMA)	EA	9	3~5번 각 3개씩
산소 공급	구강용 기도기	EA	20	성인/소아 크기별로 각 10개씩
	비강 캐놀라	EA	5	
	비재호흡 마스크	EA	5	
	산소연결튜브	길이(M)	10	
	휴대용산소통	EA	10	
진단	혈당측정스트립	BOX	1	
순환 보조	수액주입세트	EA	50	
	카테터	EA	90	16G/18G/20G 각 30개씩
	주사기(5cc/10cc)	EA	400	각 200개
	주사기 50cc	EA	10	
	토니켓	EA	5	
	알콜솜통	EA	2	
	주사기 폐기통(1L)	EA	1	
외상 치료	봉합세트	EA	3	
	드레싱 세트	EA	10	
	일회용 드레싱세트	EA	80	
	농반	EA	3	
	거즈	EA	1000	10장/pack
	면봉 통	EA	3	
	포셉통	EA	1	
	비닐장갑	BOX	2	

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
	비열균장갑	EA	800	중/대 각 400개씩
	수술장갑	EA	200	6.5/7.0/7.5/8.0 각 50개씩
	밴드	BOX	2	여러 모양의 반창고
	플라스터	EA	10	종이/면 각각 5개씩
	붕대(2/4/6 inch)	EA	90	2/4/6 inch 각 30개씩
	Burn 거즈	EA	30	
	봉합사 (나일론 3.0/실크 3.0)	EA	10	각 5개
	외용생리식염액 1L	BTL	40	
	플라스틱 생리식염액 20cc	BTL	10	
	70% 에탄올 500cc	BTL	2	
	포비돈 용액 500cc	BTL	4	
	수술칼 (blade) 11번	BOX	1	
	바세린 거즈	BOX	1	
	멸균스킨스테플러	EA	5	
진료	설압자	BOX	1	
	휴지	BOX	10	두루마리
	비닐주머니	EA	20	
	건전지	EA	다양	혈당측정계, 전자혈압계 등 용도
	방진마스크	EA	20	
	보호복(Level D)	EA	10	신규
	1회용 마스크(Dental mask)	BOX	1	
	N95마스크	EA	30	
흡인	흡입팁	EA	40	튜브용/구강용 각 20개
기타	중증도 분류표	EA	300	
	밧줄	길이(M)	10	

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

③ 생활물품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
텐트	에어텐트	EA	1	
	발전기	EA	1	
진료실	매트리스 또는 접이식 침대	EA	40	
	간이링거대	EA	5	
	S 고리	EA	10	
	조명(형광등)	EA	8	
	탁자	EA	6	
	의자	EA	6	
	담요	EA	40	
	시트	EA	30	
	이송용 시트(carrying sheet)	EA	10	
	히터(겨울용)	EA	2	
	선풍기(여름용)	EA	2	
기타	제염세트	EA	1	
	랜턴	EA	3	
	손전등	EA	3	
	시체낭	EA	30	
	확장용 전선(extension cable)	EA	2	10M
	일반냉장고	EA	1	소형, 현장 약품보관용
	출동복(조끼)	EA	20	

4 의약품

분류	구성품	단위	최소 수량	비고
수액제제	Normal saline 1L	BAG	80	
	5D/W 0.1L	BAG	20	약제혼합용
	10D/W 0.1L	BAG	5	
	50D/W 0.1L	BAG	10	
	주사용 증류수	EA	40	
마취제	lidocaine 2%	AMP	20	
소염제	diclofenac	AMP	40	
항불안제	Lorazepam	AMP	20	경련 1차 선택제
	Phenytoin	AMP	5	
심혈관계	epinephrine	AMP	80	차광냉장보관
	Norepinephrine bitartrate	AMP	10	
	Na bicarbonate	AMP	40	
	aspirin	TAB	20	
호흡기계	clemastine	BOX	10	차광
	hydrocortisone Na succinate	BOX	10	
	dexamethasone disodium phosphate	BOX	10	
	Albuterol sulfate inhalation 200dose	EA	5	

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

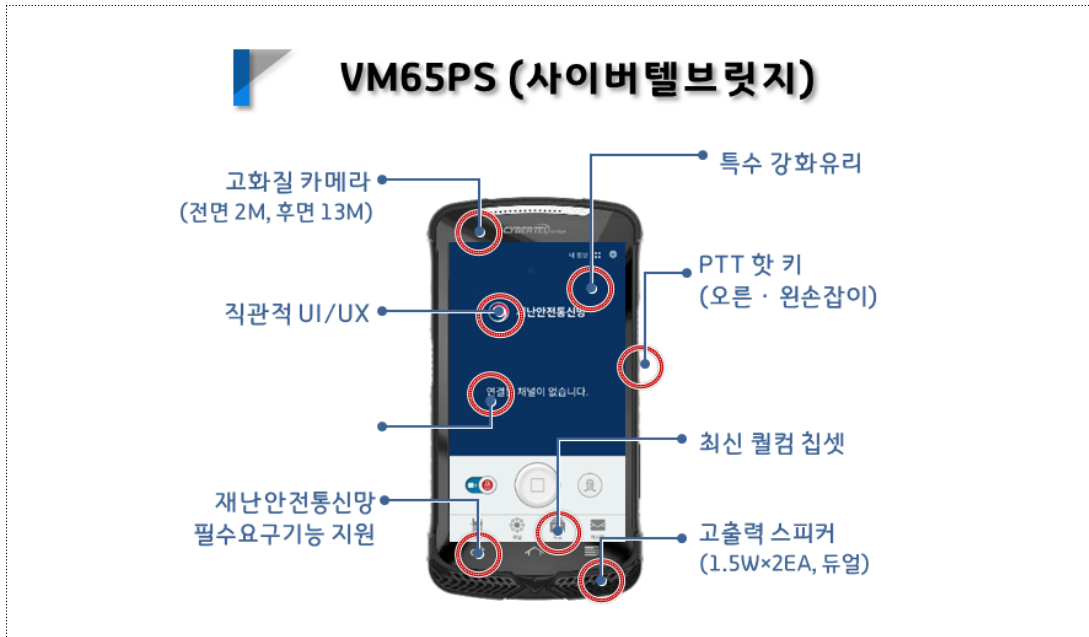
IX

X

XI

부록10 PS-LTE 사용방법(사이버텔브릿지)

01. 주요 명칭



연번	주요 부위 명칭
1	비상통화 버튼
2	무전 버튼
3	스피커
4	볼륨 버튼
5	벨트 클립
6	전원 버튼
7	외부연결 커넥터(USB-C)
8	후면 카메라, 플래쉬
9	전면 카메라
10	탈착식 배터리
11	최근실행APP·홈·이전 버튼
12	오디오 연결 잭
13	배터리 잠금 락커
14	충전 연결 단자

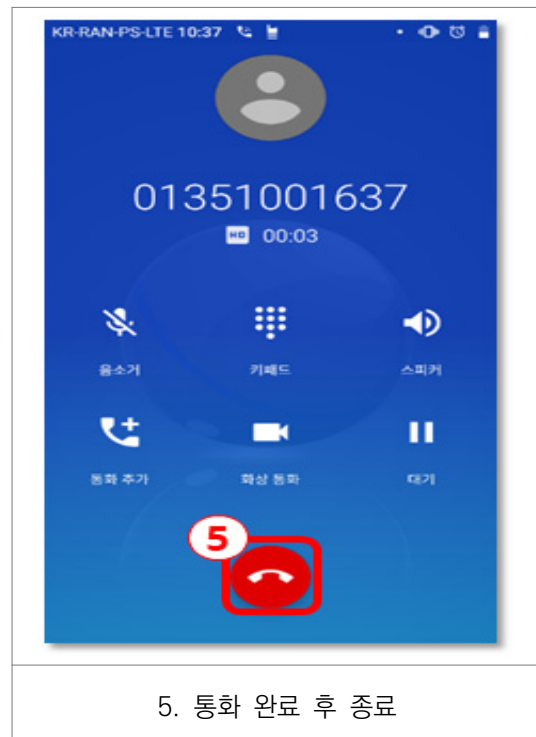
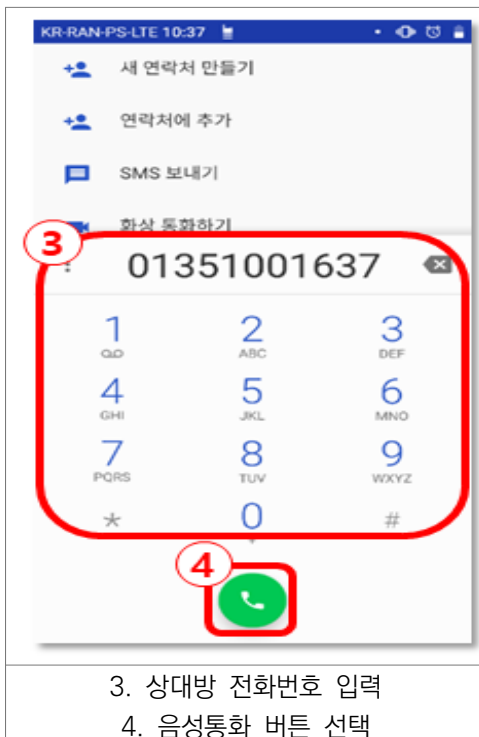
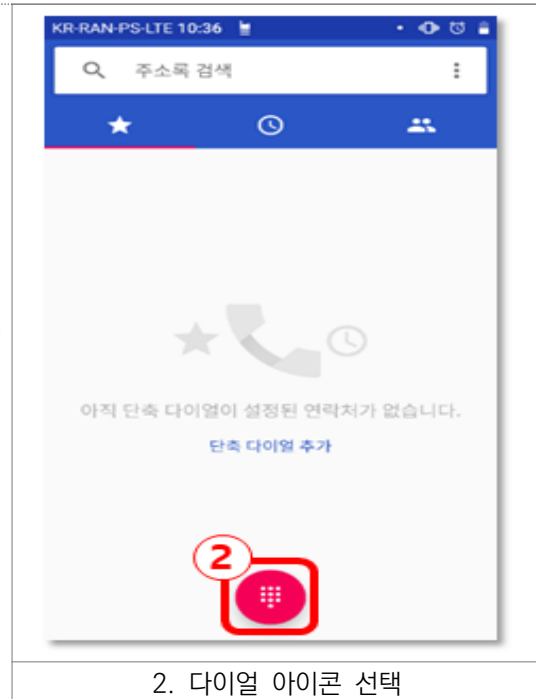
02. 기본 화면



03. 화면 상단 아이콘 설명

좌상단 아이콘	의미	우상단 아이콘	의미
	재난망 기지국 연결 상태		음성 통화 가능
	상용망 기지국 연결 상태(로밍)		데이터 연결(상용망/재난망)
	그룹 무전 사용자 인증 / 미인증		그룹 무전 채널 진입
	위치측위 동작 중		화상통화 녹음중
	그룹 무전 수신중 / 발신중		상단 아이콘 표시가 많을 경우

04. 개별(1:1) 양방향 음성 통화



05. 그룹(1:다수) 통화 기능 사용법

□ 5-1 그룹통화 메인 화면

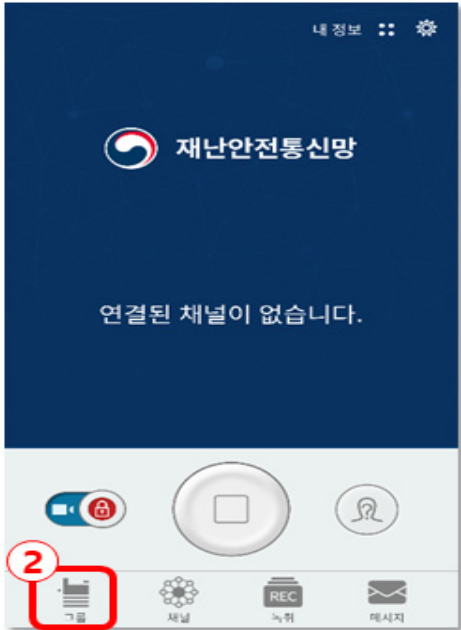


연번	메인 화면 설명
1	설정 메뉴 진입 아이콘
2	본인 단말번호 확인
3	현재 채널 등급 및 상태
4	참여하고 있는 채널의 그룹명과 그룹번호
5	녹취 버튼/음소거 버튼
6	그룹 음성/ 그룹 영상 변환 스위치
7	PTT 발언 버튼 (짧게-PTT Hold/길게-PTT)
8	그룹 참여자 표시

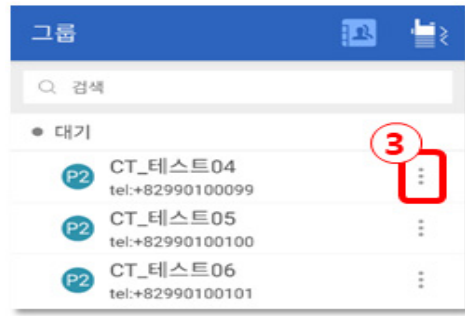
□ 5-2 그룹 채널 설정



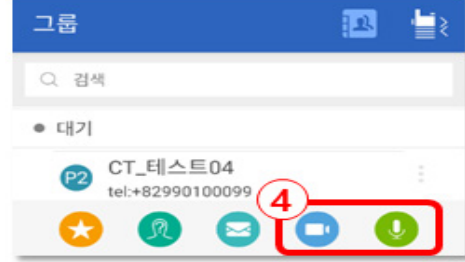
1. 무선통신 어플 선택



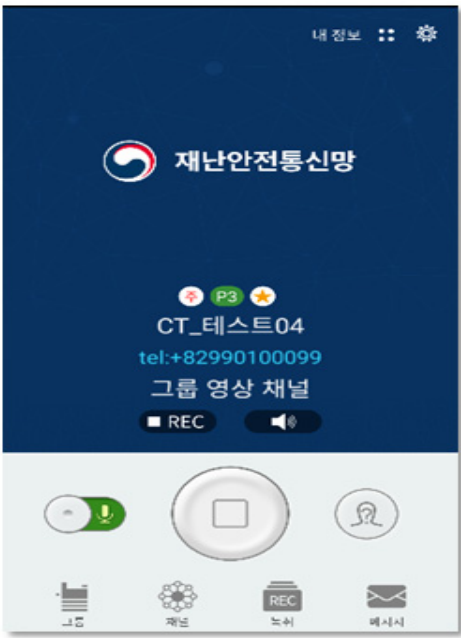
2. 그룹 아이콘 선택



3. 더 보기 버튼 선택



4. 영상 혹은 음성 연결 선택



5. 그룹 통화 연결 완료

□ 5-3 그룹 통화 발신



I

II

III

IV

V

VI

VII

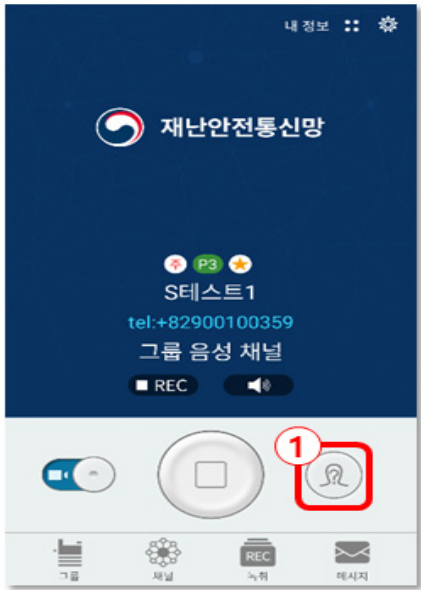
VIII

IX

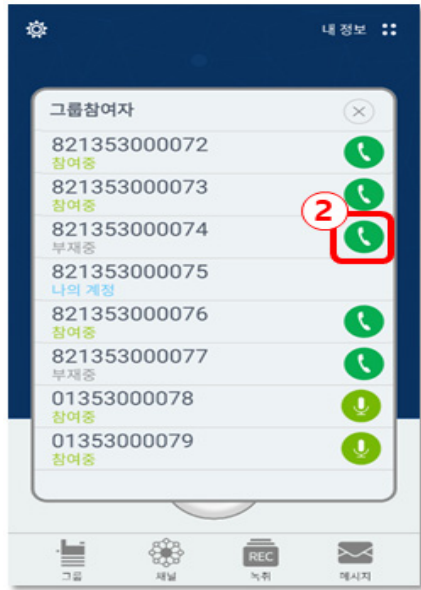
X

XI

□ 5-4 그룹참여자자와 1:1 통화



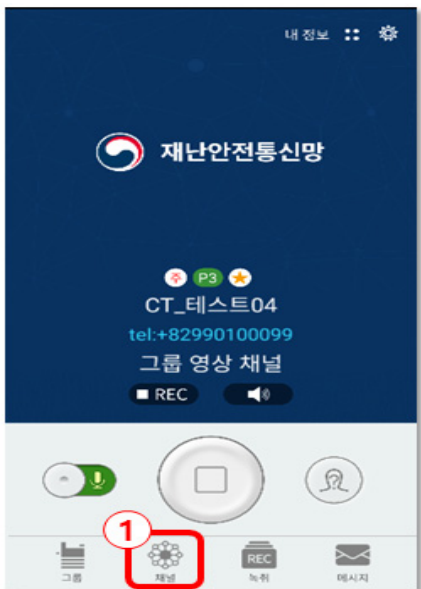
⇒



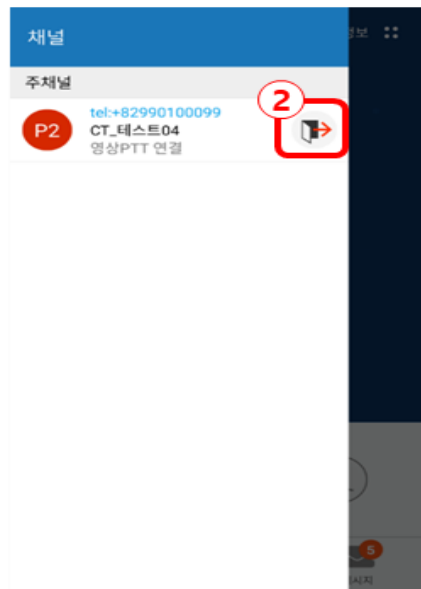
1. 그룹 참여자 아이콘 선택

2. 그룹 참여자의 번호와 참여 상태 확인, 발신 버튼을 눌러 1:1 통화 발신

□ 5-5 그룹 채널 나가기



⇒



1. 채널 아이콘 선택

2. 해당 채널 확인 후 나가기 버튼 선택

부록11 PS-LTE 사용방법(블루버드)

01. 주요 명칭



연번	주요 부위 명칭
1	오디오 연결 잭
2	비상통화 버튼
3	볼륨 버튼
4	무전 버튼
5	최근실행APP·홈·이전 버튼
6	전원 버튼
7	스트랩 고리
8	충전 핀(크레들/USB-C 충전)
9	전면 카메라
10	스피커
11	USIM 트레이
12	후면 카메라, 플래쉬
13	배터리 잠금 락커
14	배터리(탈착 가능)

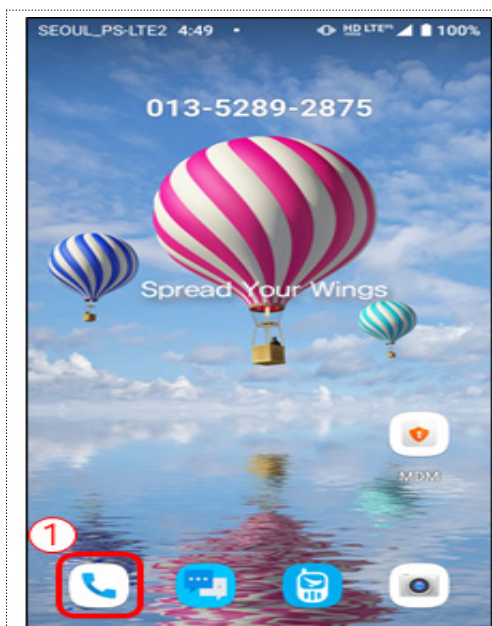
02. 기본 화면



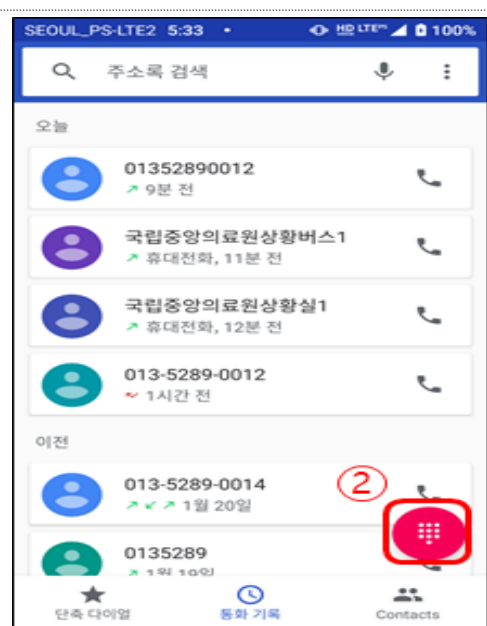
03. 화면 상단 아이콘 설명

좌상단 아이콘	의미	우상단 아이콘	의미
SEOUL_PS-LTE1	재난망 기지국 연결 상태	HD VOICE	음성 통화 가능
SEOUL_RAN_PS-LTE	상용망 기지국 연결 상태(로밍)	LTE ^{PS}	기지국 접속 상태
MCPTT 로그인 됨 / 로그인 안됨		전파 세기	
상단 아이콘 표시가 많을 경우			

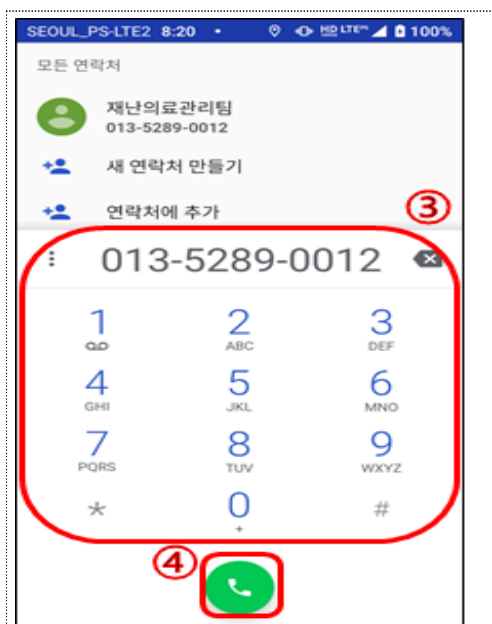
04. 개별(1:1) 양방향 음성 통화



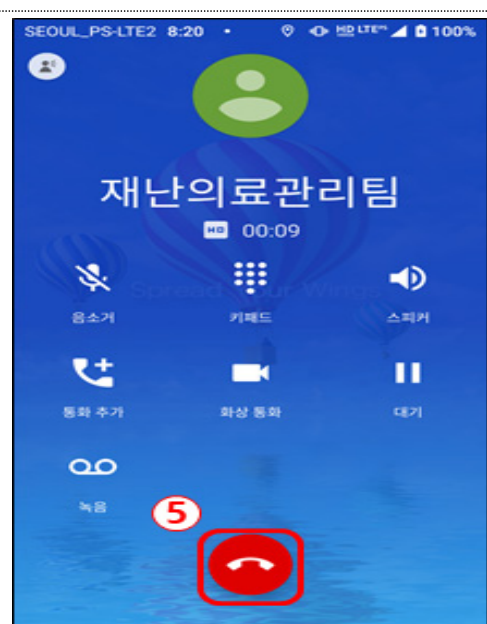
1. 전화 어플 선택



2. 다이얼 아이콘 선택



3. 상대방 전화번호 입력
4. 음성통화 버튼 선택



5. 통화 완료 후 종료

05. 그룹(1:다수) 통화 기능 사용법

□ 5-1 그룹통화 메인 화면



연번	메인 화면 설명
1	참여하고 있는 채널의 그룹명
2	영상무전 변환 버튼
3	영상무전 변환 버튼
4	녹음 버튼
5	가로채기 버튼
6	PTT 발언 버튼
7	수신음 소거 / 발신음 소거 버튼
8	무전 홈 버튼 / 채널 버튼
9	최근 기록 버튼 / 더보기 버튼

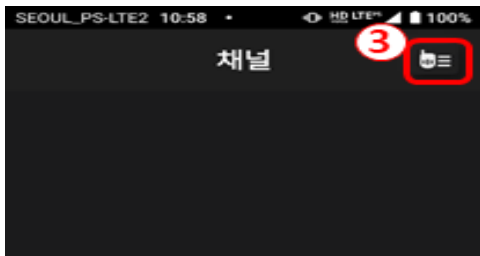
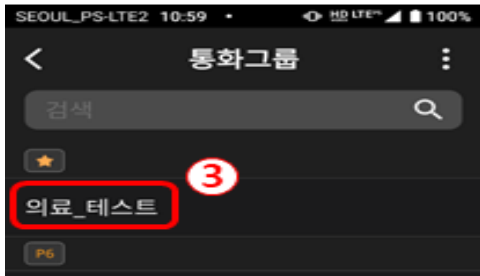
□ 5-2 그룹 채널 설정



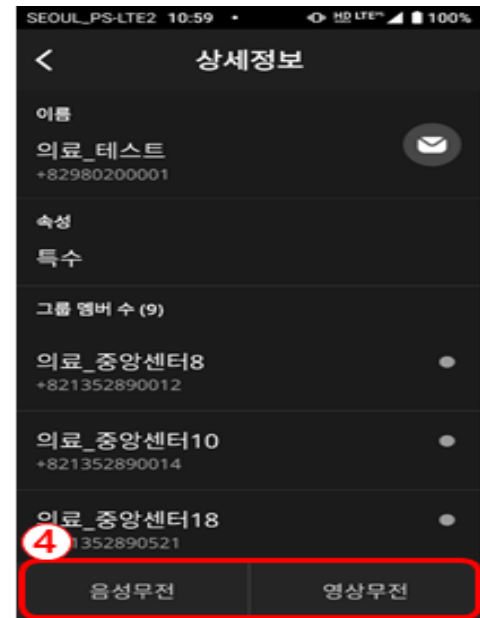
1. 무선통신 어플 선택



2. 채널 아이콘 선택

3. 채널목록 아이콘 선택 후 연결할 채널 선택



4. 음성무전 또는 영상무전 선택



5. 그룹 통화 연결 완료

□ 5-3 그룹 통화 발신



I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

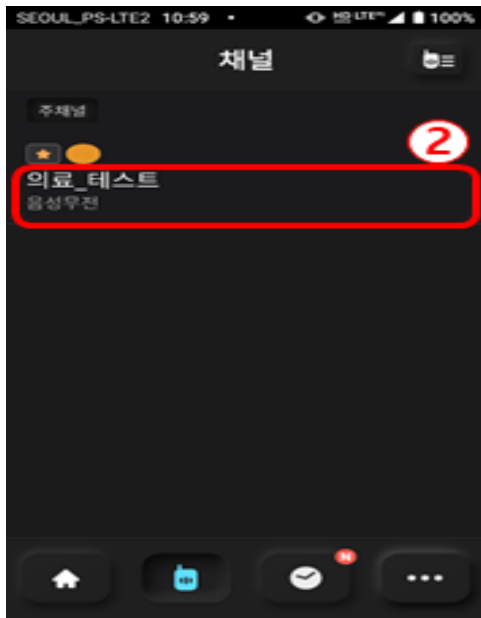
X

XI

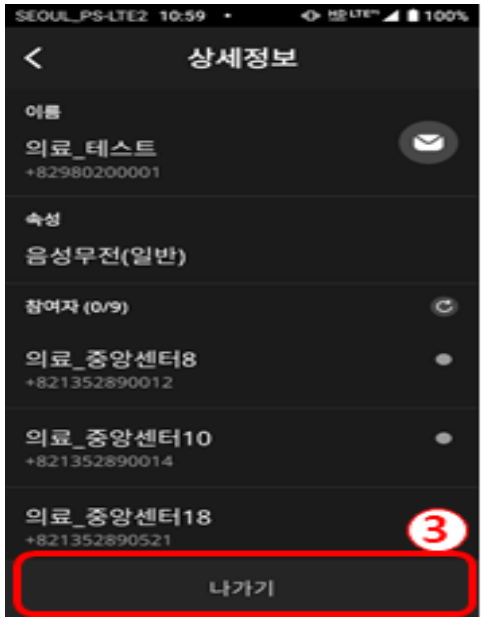
□ 5-4 그룹 채널 나가기



1. 채널 아이콘 선택



2. 해당 채널 선택



3. 나가기 선택



4. 종료하기 선택

부록12 화학사고 대응기관 연락처

담당구역	기관명	사무실(주간)	당직실(야간)
전국공통	화학물질안전원	043-830-4120~4 043-830-4125~6 (비상전화)	043-830-4120~4 043-830-4125~6 (비상전화)
전국공통	소방서	119	119
서울특별시, 인천광역시, 경기도	환경유역환경청	031-790-2879	031-790-2590
	시흥합동 방재센터	031-470-2416	031-470-2454
대전광역시, 세종특별자치시, 충청북도(원주지방환경청의 관할구역제외), 충청남도	금강유역환경청	042-865-0790	042-865-0700
	서산합동방재센터	041-661-5882	041-661-5880
전라북도	전북지방환경청	063-238-8932	063-238-8888
	익산합동방재센터	063-839-5218	063-839-5200
광주광역시, 전라남도, 경상남도(하동군, 남해), 제주도	영산강유역환경청	062-410-5231	062-410-5115
	여수합동방재센터	061-690-1623	061-690-1633
부산광역시, 울산광역시, 경상남도(하동군, 남해군 제외)	낙동강유역환경청	055-211-1661	055-211-1789
	울산합동방재센터	052-228-5803	052-228-5868
대구광역시, 경상북도	대구지방환경청	053-230-6574	053-230-6600
	구미합동방재센터	054-459-1175	054-459-1119
강원도, 충청북도(충주시, 제천시, 괴산군, 음성군, 단양군)	원주지방환경청	033-760-6447	033-760-6447
	충주합동방재센터	043-870-5971	043-870-5900

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

부록13 방사선비상진료기관 연락처

지 역	병 원 명	연 락 처	
		대 표	당직실(당)/응급실(응)
서 울	한국원자력의학원	02-970-2114	(당)02-970-2622 (응)02-970-2619, 2620, 2621
	서울대학교병원	1588-5700	(당)02-2072-2477 (응)02-2072-1182
	한림대학교한강성심병원	02-2639-5114	(당)02-2639-5681 (응)02-2639-5555, 5556
	방사선보건원	031-719-8780	02-998-9875
경 기	국군수도병원	1688-9151	(응)031-725-6119
	한림대학교성심병원	031-380-1500	(당)031-380-6029 (응)031-380-4129, 4130
부 산	부산대학교병원	051-240-7000	(당)051-240-7067 (응)051-240-7501, 7502, 7088
	동남권원자력의학원	051-720-5114	(응)051-720-5911
	기장병원	051-723-0171	(응)051-723-2119
	대동병원	051-554-1233	(당)051-550-9366 (응)051-550-9390
대 구	경북대학교병원	1666-5114	(당)053-200-6408 (응)053-200-5100, 5200
	국군대구병원	1688-9154	(응)053-750-1777
	대구가톨릭대학교병원	1688-0077	(응)053-650-4194, 4196
대 전	국군대전병원	1688-9152	(당)042-878-4205 (응)042-878-0911, 4119
	충남대학교병원	1599-7123	(응)042-280-8129
광 주	전남대학교병원	1899-0000	(당)062-220-5111, 5112 (응)062-220-5555, 6801
	조선대학교병원	062-220-3114	(당)062-220-3285 (응)062-220-3119, 3280

지 역	병 원 명	연 락 처	
		대 표	당직실(당)/응급실(응)
울 산	울산대학교병원	052-250-7000	(응)052-250-7610, 7612
	울산동강병원	054-241-1114	(응)052-241-1190, 1290
포 향	포항성모병원	054-272-0151	(당)054-260-8130 (응)054-260-8600
전 주	전북대학교병원	1577-7877	(당)063-250-1115 (응)063-250-2222
제 주	제주한라병원	064-740-5000	(당)064-740-5367 (응)064-740-5158, 5159
진 주	경상대학교병원	055-750-8000	(당)055-750-8119 (응)055-750-8282
청 주	충북대학교병원	1533-0075	(응)043-269-6991, 6994
울 진	울진군의료원	054-785-7000	(응)054-785-7119, (응)054-781-0704
함 평	국군함평병원	1688-9153	(당)061-390-5530 (응)061-324-0911
영 광	영광기독병원	061-350-3000	(당)061-350-3080 (응)061-350-3119, 3080
	영광종합병원	061-353-8000	(당)061-350-8183 (응)061-350-8129
경 주	동국대학교경주병원	054-748-9300	(응)054-770-8119
강 릉	강릉동인병원	033-651-6161	(응)033-650-6105, 6106
원 주	원주세브란스기독병원	033-741-0114	(당)033-741-0330 (응)033-741-1649
고 창	고창종합병원	063-560-5600	(응)063-560-5555

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

부록14 재난 대비·대응 활동 체크리스트

① 인력

구분	대상	확인사항	확인
인력	공통	주말/공휴일/야간 출동 체계를 갖추고 있는가?	
		재난 발생시 업무분장은 되어 있는가?	
		매월 재난인적자원현황보고를 하고 있는가?	
	신속대응반	2개팀이 구성 되어 있는가? (팀당 의료인 2-3인, 행정요원 2인 이상)	
		1차팀(4인 이상)은 즉시 출동이 가능한 상태인가?	
		현장상황이 12시간 이상 길어질 경우, 2차팀(4인이상) 출동이 가능한가?	
	DMAT	3개팀이 구성되어 있는가? (팀당 의사 1인, 간호사/응급구조사 2인, 행정요원 1인 이상)	
		1차팀(4인이상)은 즉시 출동이 가능한 상태인가?	
		현장 상황이 길어질 경우, 2차팀은 2시간이내, 3차팀은 12시간이내 출동이 가능한가?	
		재난의료책임자 및 담당자가 지정되어 있는가?	

② 물품

구분	대상	확인사항	확인
물품	공통	재난의료책임자 및 담당자가 지정되어 있는가?	
		재난의료지원물품을 정기적으로 관리하고 있는가?	
		현장응급의료소 복장이 준비되어 있는가?	
	신속대응반	재난 발생시 재난의료지원 물품 반출이 즉시 가능한가?	
		구급차 및 응급의료장비 확보 현황을 파악하고 있는가?	
		인근 지역 장례식장 현황을 파악하고 있는가?	
		현장에 즉시 출동할 수 있는 비상차량이 준비되어 있는가?	
	DMAT	재난 발생시 재난의료지원 물품 반출이 즉시 가능한가?	
		재난의료지원 차량은 24시간 출동이 가능한가?	
		재난·감염병 위기대응 차량은 24시간 출동이 가능한가?	
		현장에 즉시 출동할 수 있는 비상차량이 준비되어 있는가?	

③ 통신

구분	대상	확인사항	확인
통신	공통	핫라인의 용도를 알고 있는가?	
		모바일 상황실의 운영과 보고 내용을 알고 있는가?	
		보조배터리가 준비되어 있는가?	
		단말기가 주채널(해당 지역 의료 채널), 부채널(재난안전통신망 표준운영절차(SOP)에 따른 공통통화그룹)이 설정되어 있는가?	
		단말기가 상시 충전 되고 있는가?	
		단말기 사용 방법을 알고 있는가?	
		단말기 관리자가 지정되어 있는가?	
	신속대응반	재난핫라인을 구성하고 있는가?	
	DMAT	재난핫라인과 출동핫라인을 구성하고 있는가?	

④ 출동 전 확인사항

구분	대상	확인사항	확인
출동 전	공통	재난 유형(교통사고, 화재 등) 파악을 하였는가?	
		현재 상황에 대해 내부 보고를 하였는가?	
		출동 및 관련 인원이 모바일 상황실에 초대되어 있는가?	
		출동 차량이 준비되었는가?	
		정확한 사고 발생 위치 및 경로를 파악하였는가?	
		출동 요청에 즉시 응답하였는가?	
		직종별 출동 인원 수, 출동 시각, 도착 예정 시각을 보고하였는가?	
		중앙응급의료상황실에서 제공한 병원별 수용능력을 파악하였는가?	
		재난 유형에 따른 출동 물품 준비가 되었는가?	
		현장응급의료소 복장 준비가 되었는가?	
		개인보호구 등 안전장비가 필요한 상황인가?	
		PS-LTE 단말기를 준비하였는가?	
	신속대응반	보건소장이 모바일 상황실에 초대되어 있는가?	
		출동 인력이 적절하게 구성되어 있는가?	
	DMAT	재난의료책임자가 모바일상황실에 초대되어 있는가?	
		출동 인력이 적절하게 구성되어 있는가?	
		재난의료지원차량 출동이 필요한 상황인가?	
		현장 출동인력 근무공백시 대체 근무자가 준비되어 있는가?	

[5] 현장 확인사항

구분	대상	확인사항	확인
현장	공동	통제단에 도착 보고(인원 등)를 하였는가?	
		현장 활용 재난통신망을 확보하였는가?	
		연락관 파견을 하였는가?	
		임시의료소와 인수인계를 하였는가?	
		현장응급의료소 지휘체계를 확인하였는가?	
		소장으로부터 현장응급의료소 활동 업무를 지시받았는가?	
		현장응급의료소 추가 설치 장소를 확인하였는가?	
		119구급대에 이송반 배치를 하였는가?	
		모바일 상황실에 도착을 보고하였는가?	
		CBRNE 상황의 경우 안전지역을 확인하였는가?	
		CBRNE 의 경우 현장 대응 추가 물품 요청을 하였는가?	
		CBRNE 의 경우 적절한 대응 보호장구를 착용하였는가?	
	신속대응반	분류, 처치, 이송반 업무를 부여받았는가?	
	DMAT	분류, 처치, 이송반 업무를 부여받았는가?	